



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

PERAWATAN KESEHATAN WANITA DALAM BERBAGAI TAHAP KEHIDUPAN

Yenda Hasnita • Cintika Yorinda Sebtalesty • Machria Rachman
Januar Dwi Christy • Selvy Apriani • Devi Arista
Elivne Ivana Kabuhung • Hardiningsih
Cynthia Puspariny

Editor: Nurul Evi



BUNGA RAMPAI: PERAWATAN KESEHATAN WANITA DALAM BERBAGAI TAHAP KEHIDUPAN

Penulis:

Yenda Hasnita, S.Tr.Keb., M.Keb.
Cintika Yorinda Sebtalezy, SST., M.Kes.
Machria Rachman, S.ST., M.Kes.
Januar Dwi Christy, SST., Bd., M.Kes.
Selvy Apriani, SST., M.Biomed.
Dr. Devi Arista, SST., Bdn., M.Kes.
Elivne Ivana Kabuhung, SST., M.Kes.
Hardiningsih, SST., M.Kes.
Cynthia Puspariny, S.ST., Bdn., M.Kes.

Editor:

Ns. Nurul Evi, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Mat.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga rampai: Perawatan Kesehatan Wanita Dalam Berbagai Tahap Kehidupan

Penulis: Yenda Hasnita, S.Tr.Keb., M.Keb.

Cintika Yorinda Sebtalezy, SST., M.Kes.

Machria Rachman, S.ST., M.Kes.

Januar Dwi Christy, SST., Bd., M.Kes.

Selvy Apriani, SST., M.Biomed.

Dr. Devi Arista, SST., Bdn., M.Kes.

Elivne Ivana Kabuhung, SST., M.Kes.

Hardiningsih, SST., M.Kes.

Cynthia Puspariny, S.ST., Bdn., M.Kes.

Editor: Ns. Nurul Evi, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7139-78-8

Cetakan Pertama: Maret, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Buku *Perawatan Kesehatan Wanita dalam Berbagai Tahap Kehidupan* hadir sebagai panduan yang komprehensif untuk membantu para wanita dalam menjaga dan merawat kesehatan tubuh mereka sepanjang perjalanan hidup. Sebagai individu yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, wanita sering kali menghadapi tantangan kesehatan yang unik pada setiap tahap usia mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengelola kesehatan dengan bijak, baik dari segi fisik, mental, maupun emosional.

Dalam buku ini, kami membahas berbagai topik penting yang berkaitan dengan kesehatan wanita, dimulai dari deteksi dini kanker payudara, perawatan menopause, hingga pemahaman tentang kesehatan reproduksi pada wanita remaja. Tidak hanya itu, kami juga memberikan perhatian khusus pada perawatan kesehatan wanita lansia, dengan penekanan pada pencegahan penyakit degeneratif dan penanganan osteoporosis. Selain itu, topik tentang pentingnya olahraga dan nutrisi, serta perawatan kesehatan mental wanita juga turut dibahas dalam buku ini.

Setiap bab dirancang untuk memberikan edukasi dan informasi yang bermanfaat, agar wanita di semua usia dapat menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan bahagia. Kami berharap buku ini menjadi sumber daya yang berguna bagi setiap wanita yang ingin menjaga kesehatannya, baik dalam kondisi normal maupun menghadapi masalah kesehatan yang memerlukan perhatian khusus.

Dengan membaca dan memahami isi buku ini, diharapkan pembaca akan lebih sadar akan pentingnya deteksi dini, pengelolaan masalah kesehatan, serta merawat diri dengan cara yang holistik dan menyeluruh. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi kesehatan dan kesejahteraan para wanita di Indonesia.

Maret, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 KESEHATAN PAYUDARA: DETEKSI DINI KANKER

PAYUDARA	1
Yenda Hasnita, S.Tr.Keb., M.Keb.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Pengertian Kanker Payudara.....	2
C. Faktor Risiko Kanker Payudara	3
D. Metode Deteksi Dini	7
E. Kesimpulan.....	14
F. Referensi	14
G. Glosarium	15

CHAPTER 2 PERAWATAN MENOPAUSE: PEMAHAMAN DAN

PENGELOLAAN	17
Cintika Yorinda Sebtalezy, SST., M.Kes.	17
A. Pendahuluan/Prolog	17
B. Definisi Menopause.....	18
C. Insidensi Menopause.....	18
D. Perubahan Fisiologis dan Gejala Menopause.....	19
E. Faktor yang Mempengaruhi Gejala Pre Menopause	21
F. Perubahan Pada Perimenopause.....	21
G. Siklus Kehidupan	22
H. Diagnosis dan Evaluasi Medis.....	23
I. Pendekatan Pengelolaan Menopause	24
J. Aspek Psikologis dan Sosial	25
K. Pencegahan dan Kesehatan Jangka Panjang.....	26
L. Kesimpulan.....	26
M. Referensi	27
N. Glosarium	29

CHAPTER 3 KESEHATAN REPRODUKSI PADA WANITA REMAJA:

EDUKASI MENSTRUASI DAN PENGELOLAAN MASALAH REPRODUKSI	31
Machria Rachman, S.ST., M.Kes.	31
A. Pendahuluan/Prolog	31
B. Kesehatan Reproduksi pada Remaja Perempuan	32

C. Edukasi Menstruasi.....	32
D. Pengelolaan Masalah Reproduksi pada Remaja.....	41
E. Kesimpulan.....	46
F. Referensi	47
G. Glosarium	48

CHAPTER 4 PERAWATAN KESEHATAN SEKSUAL WANITA.....49

Januar Dwi Christy, SST., Bd., M.Kes.	49
A. Pendahuluan/Prolog	49
B. Memelihara Kesehatan Reproduksi	50
C. Cara pencegahan penyakit menular seksual.....	50
D. Tanda dan gejala PMS.....	51
E. Faktor – faktor resiko bisa terkena PMS.	52
F. Penyakit Menular Seksual Gonorea.	52
G. Keputihan (Vaginitis).....	54
H. Kutil kelamin (Kondiloma Akuminata)	55
I. <i>Herpes simplek</i> (HSV)	57
J. <i>HIV and AIDS</i>	58
K. Referensi	59

CHAPTER 5 GANGGUAN MENSTRUASI PADA WANITA: DIAGNOSA DAN PENGELOLAAN.....61

Selvy Apriani. SST., M.Biomed.....	61
A. Pendahuluan/Prolog	61
B. Menoragia (Hiperemenorea)	62
C. Hipomenorea	65
D. Polimenorea	66
E. Oligomenorea.....	68
F. Amenorea	70
G. Metroragia	72
H. Dismenore	74
I. Mestalgia	79
J. Kesimpulan.....	81
K. Referensi	82

CHAPTER 6 PERAWATAN KESEHATAN WANITA LANSIA: PENCEGAHAN PENYAKIT DEGENERATIF DAN PENANGANAN OSTEOPOROSIS.....85

Dr. Devi Arista, SST., Bdn., M.Kes.	85
A. Pendahuluan/Prolog	85
B. Pencegahan Penyakit Degeneratif	85
C. Pengertian Osteoporosis.....	86

D. Patofisiologi Osteoporosis	86
E. Diagnosis Osteoporosis.....	89
F. Faktor Risiko Osteoporosis.....	89
G. Pengobatan Farmakologis Osteoporosis	91
H. Tindakan Nonfarmakologis Untuk Pencegahan dan Pengobatan Osteoporosis	93
I. Simpulan	94
J. Referensi	95
K. Glosarium	98

CHAPTER 7 PENTINGNYA OLAHRAGA DAN NUTRISI PADA WANITA

DI SEMUA USIA 99

Elivne Ivana Kabuhung,SST., M.Kes.....	99
A. Pendahuluan/Prolog	99
B. Pentingnya Olahraga pada Wanita	100
C. Pentingnya Nutrisi pada Wanita di Semua Usia	109
D. Kesimpulan.....	110
E. Referensi	110
F. Glosarium	114

CHAPTER 8 PERAWATAN KESEHATAN WANITA HAMIL:

PEMANTAUAN DAN EDUKASI SELAMA KEHAMILAN..... 115

Hardiningsih, SST., M.Kes.....	115
A. Pendahuluan/Prolog	115
B. Pemantauan Selama Kehamilan	116
C. Edukasi Selama Kehamilan	119
D. Kesimpulan.....	126
E. Referensi	127
F. Glosarium	129

CHAPTER 9 KESEHATAN MENTAL PADA WANITA: MENANGANI

STRESS DAN DEPRESI DI BERBAGAI TAHAP KEHIDUPAN..... 131

Cynthia Puspariny, S.ST., Bdn., M.Kes.....	131
A. Pendahuluan/Prolog	131
B. Konsep Kesehatan Mental.....	132
C. Faktor Risiko Stres dan Depresi pada Wanita.....	134
D. Tahap Kehidupan dan Dinamika Kesehatan Mental Wanita	135
E. Dampak Stres dan Depresi pada wanita.....	136
F. Strategi Penanganan Stres dan Depresi pada Wanita	138
G. Simpulan	141
H. Referensi	141
I. Glosarium	143

PROFIL PENULIS	145
-----------------------------	------------

CHAPTER 1

KESEHATAN PAYUDARA: DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA

Yenda Hasnita, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan payudara adalah salah satu aspek penting dari kesehatan wanita yang sering kali kurang mendapatkan perhatian yang cukup. Payudara tidak hanya sebagai fungsi biologis seperti menyusui namun juga memiliki dampak psikologis dan emosional bagi setiap individu. Oleh karena itu, menjaga kesehatan payudara sangat penting untuk mendukung kesejahteraan wanita secara keseluruhan.

Salah satu tantangan terbesar bagi wanita untuk menjaga kesehatan payudara adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya melakukan deteksi dini terhadap masalah pada payudara seperti kanker payudara. Kanker payudara adalah kondisi dimana sel-sel ganas berkembang didalam jaringan payudara. Sel-sel ini membentuk tumor yang bisa teraba pada pemeriksaan fisik atau terdeteksi melalui pemeriksaan mammografi. (Kemenkes, 2024). Tumor ini dapat tumbuh dalam kelenjar susu, saluran kelenjar dan jaringan penunjang payudara seperti jaringan lemak maupun jaringan ikat payudara) dan dapat menyebar keseluruh bagian tubuh.

Kanker payudara merupakan kanker yang paling sering ditemukan pada wanita diseluruh dunia dan merupakan penyakit yang menakutkan bagi wanita, karena kanker payudara sering ditemukan pada stadium yang sudah lanjut. (Nurrohman et al., 2022). Namun, kanker ini bisa disembuhkan selama dideteksi sejak masih dalam stadium awal, semakin dini dilakukan perawatan, maka kemungkinan sembuhnya akan semakin tinggi. Skrining kanker payudara sejak dini dapat dilakukan. Deteksi dini kanker payudara dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri) dan melakukan SADANIS (Pemeriksaan Payudara secara Klinis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan). Dengan menghindari potensi munculnya kanker payudara dan melakukan deteksi dini diharapkan bisa segera menemukan kanker pada stadium yang lebih dini dan dapat meningkatkan peluang kesembuhan hingga 80-90%. (Kemenkes, 2024).

Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kanker dalam payudara wanita. (Olfah, 2019). *American Cancer Society* menganjurkan bahwa SADARI perlu dilakukan oleh wanita usia 20 tahun atau lebih setiap bulannya yaitu pada hari ke-7 atau ke-10 setelah selesai haid/ menstruasi.

Namun seiring berjalan waktu, penyakit ini mulai mengarah ke usia yang lebih muda yaitu usia 13-20 tahun maka usia remaja perlu untuk melakukan SADARI secara rutin sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini kanker payudara

Kanker payudara menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia dan menjadi salah satu penyumbang kematian pertama akibat kanker. Menurut Data Globocan tahun 2020, jumlah kasus baru kanker payudara mencapai 68.858 (16,6%) dari total 396.914 kasus baru kanker di Indonesia, sedangkan angka kematian akibat kanker payudara sangat tinggi mencapai 22.000 jiwa.

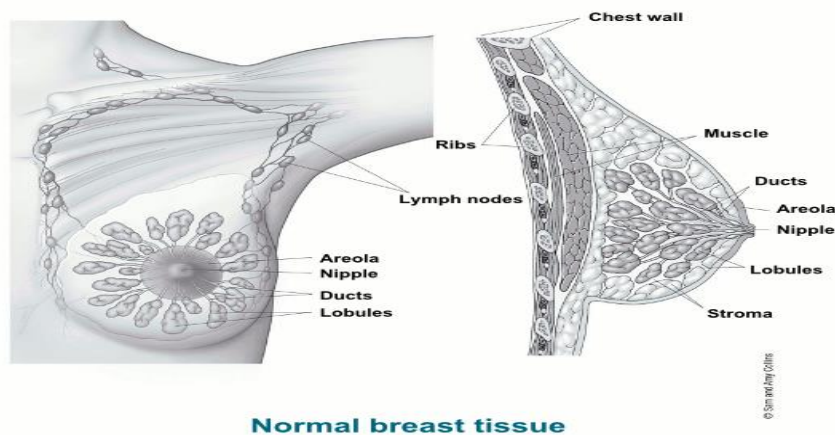
Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO), 2018 prevalensi kanker payudara sebesar 80.653.000 kasus dimana kanker ini paling banyak diderita oleh kaum wanita. Terdapat 58.256.000 kasus terjadi di negara berkembang dan menyebabkan 22.692.000 kematian akibat kanker payudara, sedangkan menurut *International Agency for Research on Cancer* (IARC) tahun 2020, kanker payudara merupakan jenis kanker yang paling banyak didiagnosis di dunia, dengan lebih dari 2,26 juta kasus baru kanker payudara di seluruh dunia. Pada tahun 2022, meski diperkirakan terjadi peningkatan lebih dari 2,31 juta kasus baru, kanker payudara menjadi jenis kanker terbanyak kedua, setelah kanker paru-paru. Kanker payudara tetap menjadi jenis kanker yang paling sering didiagnosis pada wanita dan penyebab kematian akibat kanker paling umum pada wanita. Dan merupakan penyebab kematian akibat kanker paling umum keempat secara keseluruhan.

Diagnosis dini kanker payudara akan memberikan dampak positif yang luas, mulai dari peningkatan tingkat kesembuhan hingga pengurangan beban emosional serta finansial. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan edukasi, kesadaran dan akses layanan skrining untuk dapat meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya wanita.

B. Pengertian Kanker Payudara

Payudara wanita terdiri dari lobulus (kelenjar yang menghasilkan air susu), duktus (saluran kecil yang mengalirkan air susu ke puting susu) dan stroma (jaringan lemak dan jaringan ikat disekeliling duktus dan lobulus, pembuluh darah dan limfe). Pada umumnya karsinoma berasal dari sel-sel yang terdapat di duktus, beberapa diantaranya berasal dari lobulus dan jaringan lainnya. (American Cancer Society, 2024)

Kanker payudara adalah kondisi di mana sel-sel ganas berkembang di dalam jaringan payudara. Biasanya, kanker ini dimulai di saluran susu atau lobulus (kelenjar penghasil air susu). (Kemenkes, 2024)



Gambar 1.1 Anatomi Payudara

Kanker payudara adalah tumor ganas pada payudara atau salah satu payudara, kanker payudara juga merupakan benjolan atau massa tunggal yang sering terdapat di daerah kuadran atas bagian luar, benjolan ini keras dan bentuknya tidak beraturan dan dapat digerakkan (Olfah dkk, 2013)

Sedangkan menurut Rozi Abdullah 2012, Kanker payudara atau Carcinoma mammae merupakan kanker ganas pada payudara atau salah satu payudara. Kanker ini adalah suatu penyakit neoplasma ganas yang berasal dari parenchyma (bagian organ yang produktif). Kanker bisa mulai tumbuh di dalam kelenjar susu, saluran susu, jaringan lemak maupun jaringan ikat pada payudara. Kanker payudara disebabkan oleh adanya kerusakan pada materi genetik sel yang kemudian bersentuhan dengan bahan kimia yang mempercepat pembiakan sel yang diperlukan untuk berkembang menjadi sel kanker yang lebih ganas.

C. Faktor Risiko Kanker Payudara

Kanker payudara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko, menurut Iman Rasjidi (2010) faktor – faktor risiko kanker payudara yaitu:

1. Faktor risiko yang berhubungan dengan diet, terdapat dua yaitu:

- a. Faktor yang memperberat kanker payudara yaitu peningkatan berat badan yang bermakna pada saat pasca menopause, diet ala barat yang tinggi lemak (western style) dan minuman berkalkohol
- b. Faktor risiko yang mempunyai dampak positif kanker payudara yaitu peningkatan konsumsi serat, buah dan sayur.

2. Faktor reproduksi dan hormon

Kanker payudara merupakan masalah kesehatan yang utama bagi wanita. Insiden kanker payudara akan terus meningkat selama 20 tahun kedepan meskipun upaya dalam pencegahan sudah dilakukan. Ada beberapa faktor risiko hormonal kanker payudara antara lain usia menarche dini, usia kehamilan

pertama, paritas, riwayat menyusui dan usia menopause dan faktor risiko lain yang meningkatkan kejadian kanker payudara adalah obesitas, konsumsi alkohol, dan terapi penggantian hormon. (Howell *et al*, 2014)

Faktor hormonal berperan dalam meningkatkan angka kejadian kanker payudara, karena akan memicu pertumbuhan dari sel kanker. Kadar hormon yang tinggi selama masa reproduktif wanita jika tidak diselingi dengan perubahan hormonal akan berdampak dalam meningkatkan peluang kerusakan tumbuhnya sel-sel yang akan menyebabkan kanker.

a. Usia menstruasi pertama (menarche)

Menarche adalah istilah umum yang biasa dipakai ketika seorang perempuan mengalami pendarahan pertama kalinya yang berasal dari uterus atau sering disebut dengan menstruasi pertama kali (Anggraini, 2014). Siklus menstruasi umumnya dialami perempuan pada usia 10-16 tahun.

Usia menarche yang lebih dini, yakni dibawah 12 tahun akan meningkatkan resiko kanker payudara 3 kali dibandingkan dengan usia menarche diatas 12 tahun (Sjamsuhidajat, 2010). Usia *menarche* dini akan menyebabkan paparan hormon estrogen pada tubuh menjadi lebih cepat. Hormon estrogen ini dapat memicu pertumbuhan sel pada bagian tubuh tertentu secara tidak normal. Mekanisme terjadinya kanker payudara oleh paparan hormon estrogen belum diketahui secara pasti disebabkan karena stimulasi estrogen terhadap pembelahan sel epitel atau karena disebabkan oleh estrogen dan metabolitnya yang secara langsung bertindak sebagai mutagen sehingga menyebabkan timbulnya sel kanker pada payudara (Sandra, 2011).

Perkembangan payudara dimulai lebih awal dari pada periode datangnya menstruasi, karena pada saat menstruasi produksi hormon progesteron sedikit mengalami perubahan, hal ini menyebabkan payudara akan terasa nyeri dan sakit saat ditekan. Rasa nyeri dan sakit pada payudara tersebut akan menghilang pada saat menstruasi telah selesai (Astrid Savitri dkk, 2015)

Seorang wanita yang mengalami usia menstruasi lebih awal berhubungan dengan lamanya paparan hormon estrogen dan progesteron pada wanita yang berpengaruh terhadap proses proliferasi jaringan termasuk jaringan payudara (Cici dkk, 2013).

b. Usia kehamilan pertama

Semakin tua wanita memiliki anak pertama, maka akan semakin besar risiko untuk terkena kanker payudara. Melahirkan anak pertama pada usia 30 tahun akan meningkatkan terkena kanker payudara, hal ini disebabkan oleh adanya rangsangan pematangan sel-sel payudara yang diinduksi selama kehamilan, sehingga membuat sel-sel ini lebih peka terhadap perubahan kearah yang

lebih ganas. Hal ini karena adanya rangsangan pematangan dari sel-sel pada payudara yang diinduksi oleh kehamilan, yang membuat sel-sel pada payudara lebih peka terhadap transformasi yang bersifat karsinogenik. (Rasjidi, 2010).

c. Paritas

Dalam suatu studi meta analisis, melaporkan bahwa pada wanita nulipara atau belum pernah melahirkan mempunyai risiko 30% untuk berkembang menjadi kanker dibandingkan dengan wanita yang multipara.

d. Menyusui

Menyusui merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Menyusui memberikan efek yang bersifat protektif terhadap kanker payudara. waktu menyusui yang lebih lama lebih dari 1 tahun akan menurunkan risiko terkena kanker payudara, dimana terjadi penurunan kadar estrogen dan pengeluaran zat pemicu kanker selama proses menyusui. Semakin lama wanita menyusui bayinya, maka semakin besar efek proteksi terhadap kanker payudara (Mardiana, 2007).

Wanita yang tidak pernah menyusui memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker payudara karena pada masa menyusui peran hormon estrogen dan hormon progesteron akan menurun dan didominasi oleh hormon prolaktin. Menurunnya hormon estrogen dan hormon progesteron dalam darah selama menyusui akan mengurangi pengaruh hormon tersebut terhadap proliferasi jaringan termasuk jaringan payudara (Rini Indriati dkk, 2018).

Menurut penelitian Mohamed Khalis *et al*/ tahun 2018 bahwa menyusui dapat menurunkan resiko terkena kanker payudara sebesar 4,3% untuk setiap menyusui selama 12 bulan.

3. Faktor genetik

a. Faktor endogen

Faktor risiko yang penting dalam pertumbuhan kanker payudara adalah pada wanita adalah paparan hormon endogen selama hidupnya. Pada penelitian Yenda, Hasnita 2019 menemukan bahwa adanya penurunan risiko kanker yang signifikan terhadap wanita dengan usia menarche 12 tahun atau lebih muda ($p < 0,001$), menopause sebelum usia 50 tahun. Faktor- faktor tersebut merupakan faktor risiko yang berperan dalam pertumbuhan kanker payudara.

b. Faktor eksogen

1) Kontrasepsi oral

Kontrasepsi merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pembuahan dan kehamilan (Rochmah, 2009). Pemakaian alat kontrasepsi hormonal khususnya pil dapat meningkatkan

risiko terkena kanker payudara. Alat kontrasepsi hormonal berupa pil antara lain pil KB kombinasi dan pil KB mini (Puspitasari, 2008).

Pil KB kombinasi mengandung hormon estrogen dan progesteron untuk mencegah terjadinya ovulasi. Hormon progesteron menghambat sekresi FSH (*follicle stimulating hormone*) sehingga menghambat pematangan sel telur. Hormon estrogen membantu pembentukan endometrium atau membran mukosayang melapisi dinding uterus. Endometrium tetap terbentuk, namun tidak ada sel telur yang matang sehingga kehamilan tidak dapat terjadi (Dewi, 2015).

Wanita yang menggunakan kontrasepsi oral (pil KB) akan memiliki risiko lebih besar terkena kanker payudara dibandingkan wanita yang tidak menggunakannya, hal ini disebabkan karena kandungan estrogen dan progesteron pada kontrasepsi oral akan memberikan efek proliferasi berlebih pada duktus epithelium payudara. Berlebihnya proliferasi sel yang diikuti dengan hilangnya kontrol atas pertumbuhan sel dan pengaturan kematian sel yang sudah terprogram (apoptosis) akan mengakibatkan sel payudara berproliferasi secara terus menerus tanpa adanya batas kematian. Hilangnya fungsi apoptosis menyebabkan ketidakmampuan dalam mendeteksi kerusakan sel akibat adanya kerusakan pada DNA, sehingga sel-sel abnormal akan berproliferasi terus menerus tanpa bisa dikendalikan (Marchbanks *et al*, 2002). Penggunaan kontrasepsi oral yang meningkatkan resiko kanker payudara pada umumnya ketika menggunakan dosis estrogen yaitu dalam pil kombinasi dimana memiliki dampak lebih tinggi dari penggunaan yang menggunakan dosis progestin saja. Risiko penggunaan kontrasepsi hormonal dalam jangka waktu yang lama diatas 5 tahun akan meningkatkan resiko kanker payudara dibandingkan dengan wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal kurang dari 5 tahun (Mørch Lina, 2017).

Menurut Yenda. H tahun 2019 menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara lama penggunaan kontrasepsi pil dengan kanker payudara dengan nilai $p < 0,05$ dan nilai OR 3,16 artinya penggunaan kontrasepsi pil ≥ 5 tahun akan meningkatkan 3,16 kali beresiko terkena kanker payudara dibandingkan responden dengan penggunaan kontrasepsi pil < 5 tahun, karena dapat meningkatkan kadar estrogen didalam tubuh.

2) Terapi Sulih Hormon

Menurut Chieci dkk dalam Rasjidi 2010 meneliti faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan perkembangan payudara yang dapat mempengaruhi penggunaan TSH pada wanita pascamenopause. Obesitas juga

berhubungan dengan peningkatan risiko kanker payudara pascamenopause, hal ini disebabkan oleh jumlah hormon endogen pada wanita obesitas juga ikut meningkat.

Wanita usia 45 tahun atau lebih dengan hasil mammogram menunjukkan kepadatan jaringan payudara minimal 75% juga meningkatkan risiko kanker sebesar lima kali lipat. Pada wanita dengan golongan ini juga kontraindikasi untuk menerima TSH, karena tingginya jumlah estrogen didalam tubuh.

Konsumsi alkohol juga dapat meningkatkan risiko berkembangnya kanker payudara. Karena alkohol meningkatkan konsentrasi estradiol dalam darah pada wanita yang mendapat TSH.

3) Densitas Payudara pada Mammografi

Densitas Payudara berhubungan dengan risiko kanker payudara karena dipengaruhi oleh jaringan lemak, jaringan ikat dan epitel pada payudara. Densitas payudara pada wanita dipengaruhi oleh 20-30% seperti status menopause, berat badan, dan paritas serta dicurigai adanya kecendrungan terhadap genetic.

4) Intake Alkohol

Asupan alkohol dapat meningkatkan risiko kanker payudara karena disebabkan oleh aktifitas estrogen didalam tubuh. Studi menemukan bahwa setelah konsumsi alkohol, akan terdapat peningkatan jumlah estrogen didalam urin dan kulit. Alkohol dapat menyebabkan hyperinsulinemia yang akan merangsang faktor pertumbuhan pada jaringan payudara.

D. Metode Deteksi Dini

1. Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI)

SADARI adalah pemeriksaan yang dilakukan sebagai deteksi dini kanker payudara yang dilakukan oleh setiap wanita untuk mencari benjolan yang dicurigai atau kelainan lainnya (Nugroho, 2011). SADARI adalah usaha atau cara pemeriksaan payudara yang dilakukan secara teratur dan sistematis oleh setiap wanita sebagai langkah deteksi dini (Purwoastuti, 2008).

Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) adalah pengembangan kepedulian seorang wanita terhadap kondisi payudaranya sendiri. Tindakan ini dilengkapi dengan langkah-langkah khusus untuk mendeteksi secara awal penyakit kanker payudara. Kegiatan ini sangat sederhana dan dapat dilakukan oleh semua wanita tanpa perlu merasa malu kepada pemeriksa, tidak membutuhkan biaya, dan bagi wanita yang sibuk hanya perlu menyediakan waktunya selama kurang lebih lima menit. Tidak diperlukan waktu khusus, cukup dilakukan saat mandi atau pada saat sedang berbaring. SADARI sebaiknya mulai dilakukan saat seorang wanita telah

mengalami menstruasi. Tingkat sensitivitasnya (kemampuan untuk mendeteksi kanker payudara) adalah sekitar 20-30% (Nisman, 2011).

Langkah dilakukan SADARI yaitu dengan melihat bentuk, ukuran, dan warna kulit payudara, dan meraba permukaan payudara menggunakan jari-jari tangan ke seluruh permukaan payudara sampai pangkal ketiak. Jika mendapati sesuatu yang tidak normal pada payudara, wanita disarankan untuk memeriksakan lebih lanjut dengan SADANIS atau mammografi.

Tujuan SADARI menurut Nisman, 2010 dalam Lusa dkk 2020 terdiri atas:

- a. SADARI hanya mendeteksi secara dini kanker payudara, bukan untuk mencegah kanker payudara sehingga dapat terdeteksi pada stadium awal, maka pengobatan dini akan memperpanjang harapan hidup penderita kanker payudara.
- b. Menurunkan angka kematian penderita karena kanker payudara.
- c. Untuk merasakan dan mengenal lekuk-lekuk payudara sehingga jika terjadi perubahan dapat segera diketahui.
- d. Dapat menemukan tumor/ benjolan payudara pada saat stadium awal, yang digunakan sebagai rujukan melakukan mamografi

Waktu pemeriksaan payudara sendiri adalah 7 hari sampai 10 hari setelah menstruasi. Dimana pada kondisi payudara sudah tidak bengkak karena perubahan hormon pada saat menstruasi sehingga payudara terasa lebih lunak (tidak kencang). Menurut The American Cancer Society menganjurkan wanita untuk melakukan SADARI mulai usia 20 tahun, dimana waktu terbaik adalah hari terakhir masa haid 7-8 hari setelah haid, karena payudara akan terasa lebih lunak dan longgar sehingga memudahkan perabaan dan waktu 10 menit setiap bulan periksa payudara (Bustan, 2010).

Manfaat pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) terdiri dari :

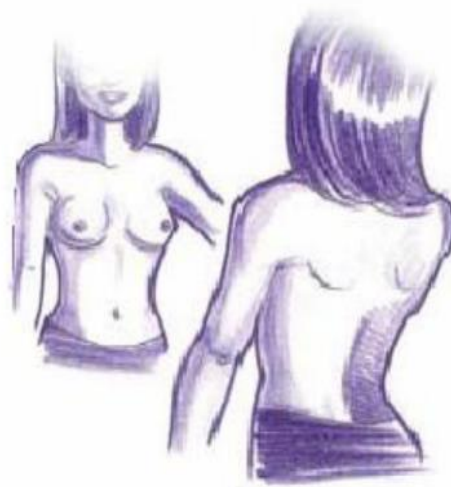
- a. Dapat mendeteksi adanya tumor dalam ukuran kecil.
- b. Dapat mendeteksi adanya kanker payudara stadium dini.
- c. Dapat mencegah penyakit kanker payudara.
- d. Dapat menemukan adanya kelainan pada payudara.
- e. Dapat menurunkan angka kematian wanita akibat kanker payudara (Hasanah, 2016).

Tahapan- Tahapan dalam pemeriksaan payudara sendiri (SADARI): menurut Lusa dkk 2020

Pemeriksaan payudara dapat dilakukan dengan melihat perubahan payudara dihadapan cermin dan melihat perubahan bentuk payudara dengan cara berbaring.

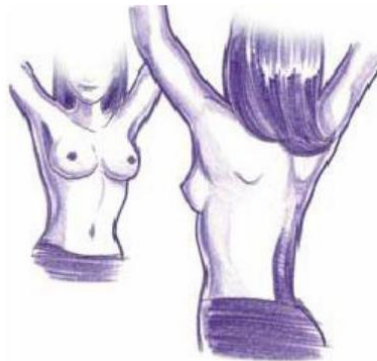
- a. Melihat perubahan dihadapan cermin : lihat pada cermin, bentuk dan keseimbangan bentuk payudara (apakah simetris atau tidak)

Cara melakukannya:



Gambar 1.1 Melihat Perubahan Bentuk dan Besarnya Payudara

Melihat apakah ada perubahan bentuk dan besarnya payudara, perubahan puting susu, serta kulit payudara didepan kaca. Sambil berdiri tegak didepan cermin, posisi kedua lengan lurus kebawah disamping badan.



Gambar 1.2 Periksa Payudara dengan tangan diangkat

Periksa payudara dengan tangan diangkat diatas kepala dengan maksud untuk melihat retraksi kulit atau perlekatan tumor terhadap otot atau fascia dibawahnya.



Gambar 1.3 Berdiri tegak di Cermin dengan Tangan di samping kanan dan kiri
berdiri tegak didepan cermin dengan tangan disamping kanan dan kiri. Miringkan badan kekanan dan kiri untuk melihat perubahan pada payudara.



Gambar 1.4 Meregangkan Otot-otot Bagian Dada dengan Tangan di Pinggang
Meregangkan otot-otot bagian dada dengan tangan dipinggang menekan pinggul, dimana dimaksudkan untuk menegangkan otot di daerah *axilla*.
b. Melihat perubahan bentuk payudara dengan berbaring



Gambar 1.5 Dimulai dari Payudara kanan

Dimulai dari payudara kanan, berbaring menghadap ke kiri dengan membengkokkan kedua lutut. Letakkan bantal atau handuk yang sudah dilipat dibawah bahu sebelah kanan untuk menaikkan bagian yang akan diperiksa. Kemudian letakkan tangan kanan dibawah kepala. Gunakan tangan kiri untuk memeriksa payudara kanan, gunakan telapak jari- jari untuk memeriksa

benjolan atau penebalan. Periksa payudara dengan menggunakan *vertical strip* dan *circular*.



Gambar 1.6 Pemeriksaan payudara dengan *vertical strip*

Memeriksa seluruh bagian payudara dengan cara vertical, dari tulang selangka dibagian atas ke bra line dibagian tengah, dan garis tengah antara kedua payudara kegaris tangan bagian ketiak. Gunakan tangan kiri untuk mengawali pijatan pada ketiak. Kemudian putar dan tekan kuat untuk merasakan apakah ada benjolan atau tidak. Gerakkan tangan secara perlahan-lahan kebawah bra line dengan putaran ringan dan tekan kuat disetiap tempat. Dibagian bawah bra line, bergerak kurang lebih 2 cm kekiri dan terus kearah atas menuju tulang selangka dengan memutar dan menekan. Bergeraklah keatas dan kebawah mengikuti pijatan dan meliputi seluruh bagian yang ditunjuk.



Gambar 1.7 Pemeriksaan payudara dengan cara memutar

Berawal dari bagian atas payudara, buatlah putaran yang besar. Bergeraklah sekeliling payudara dengan memperhatikan benjolan yang ada. Buatlah sekurang-kurangnya tiga putaran kecil sampai keputing payudara. Lakukan sebanyak 2 kali. Satu kali dengan tekanan ringan dan satu kali dengan tekanan kuat. Jangan lupa periksa bagian bawah *areola mammae*.



Gambar 1.8 Pemeriksaan cairan diputing payudara

Menggunakan kedua tangan, kemudian tekan payudara untuk melihat apakah ada cairan abnormal di puting payudara.



Gambar 1.9 Memeriksa ketiak

Letakkan tangan kanan disamping dan rasakan diketiak apakah teraba benjolan abnormal atau tidak.

2. Periksa Payudara Klinik (SADANIS)

Pemeriksaan payudara klinis (SADANIS) merupakan pemeriksaan deteksi dini kanker payudara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, atau perawat terlatih.

Sasaran pemeriksaan Sadanis adalah wanita usia diatas 20 tahun. Namun prioritas adalah pada usia wanita 30-50 tahun dengan target 50%. Pemeriksaan SADANIS dapat dilakukan setahun sekali.

Tahapan pemeriksaan SADANIS menurut buku panduan program nasional gerakan pencegahan dan deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara. Tahapan pemeriksaan SADANIS adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan
 - 1) *Informed consent*
 - 2) Meminta pasien membuka pakaian dari pinggang keatas dan duduk dimeja periksa dengan kedua lengan disisi tubuhnya
- b. Inspeksi
 - 1) Melihat bentuk dan ukuran payudara. Perhatian apakah ada perbedaan bentuk, ukuran, puting, kerutan, lipatan atau kerutan pada kulit. Ketidakberaturan atau perbedaan ukuran dan bentuk mengindikasikan adanya massa.
 - 2) Melihat putting susu dan memperhatikan ukuran dan bentuknya serta arah jatuhnya. Memeriksa apakah terdapat ruam atau nyeri pada kulit dan adanya cairan dari puting.
 - 3) Meminta pasien untuk mengangkat tangan ke atas kepala kemudian menekan kedua tangan di pinggang untuk mengecangkan otot dadanya. Memeriksa ukuran, bentuk dan simetri, lekukan puting atau kulit payudara, dan kelainan pada setiap posisi.
- c. Palpasi
 - 1) Meminta pasien untuk berbaring dan meletakkan bantal di bawah punggung pada sisi yang akan diperiksa.
 - 2) Meletakkan kain bersih di atas perut pasien
 - 3) Meletakkan lengan kiri ibu ke atas kepala. Memperhatikan payudara untuk melihat apakah tampak sama dengan payudara kanan dan apakah terdapat lekukan atau lipatan.
 - 4) Dengan tiga jari, melakukan palpasi payudara dengan teknik spiral mulai dari sisi terluar payudara. Perhatikan jika ditemukan benjolan atau nyeri (tenderness).
 - 5) Dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, menekan putting payudara dengan lembut. Perhatikan jika terdapat pengeluaran cairan: bening, keruh, atau berdarah.
 - 6) Mengulangi langkah tersebut untuk payudara sebelahnya.
 - 7) Jika menemukan keraguan tentang temuan, ulangi langkahlangkah, ibu duduk dengan kedua lengan di sisi badannya.
 - 8) Untuk memalpasi bagian pangkal payudara, ibu diminta untuk mengangkat lengan kirinya setinggi bahu kemudian menekan sisi luar dari otot pektoralis sambil bertahap menggerakkan jarijari ke pangkal ketiak untuk memeriksa apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening atau kekenyalan. Penting untuk melakukan palpasi pada pangkal payudara karena biasanya disisi ini terdapat kanker

- 9) Mengajari ibu untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri
- 10) Mencatat dan dokumentasikan hasil temuan

E. Kesimpulan

Deteksi dini kanker payudara adalah langkah awal dalam melakukan skrining untuk mengurangi komplikasi, peluang meningkatkan kesembuhan dan meminimalkan dampak fisik maupun emosional pasien, dengan mendeteksi kanker pada tahap awal, maka pengobatan dan penyembuhan menjadi lebih efektif, risiko penyebaran atau metastasis) dapat dicegah dan kualitas hidup pasien dapat dipertahankan.

Pentingnya deteksi dini didukung dengan berbagai metode seperti pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) dan pemeriksaan klinis (SADANIS). Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya wanita, akan mendorong skrining rutin, dan mempromosikan gaya hidup sehat, angka kematian akibat kanker payudara dapat ditekan, dan memberikan harapan dan masa depan yang lebih baik bagi individu.

F. Referensi

- American Cancer Society. (2022). *Breast Cancer. Atlanta*: American Cancer Society.
- Anggraini, S., & Handayani, E. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) Pada Mahasiswi Non Kesehatan UIN Antasari Banjarmasin. (9) 2: 487– 492./ <https://journal.stikeshb.ac.id/index.php/jurkessia/article/view/158>
- Bustan. 2010. SADARI. epidemiologi Penyakit Tidak Menular Jurnal Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang.1(3), 28-30
- Hasanah, E. (2016). Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) Di MAN 1 Kendari. Karya Tulis Ilmiah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Politeknik Kesehatan Kendari.
- Howell A. Anderson AS. Clarke RB *et al.* (2014). Risk Determination and Prevention Of Breast Cancer. Manchester : *BioMed Central*.
- International Agency for Research on Cancer (IARC) / WHO. (2018). *GLOBOCAN 2018*. Estimated cancer incidence, mortality, and prevalence world wide in 2018
- Khalis Mohamed, Barbara, Veronique *et al.*(2018). Menstrual and Reproductive factors and risk of breast cancer: A case-control study in the Fez region, Morocco. *Research article*. Yi Li Baylor College of Medicine United States
- Kementrian Kesehatan (2024). Panduan Pelaksanaan Kanker Payudara. Jakarta : Kemenkes RI

- Lusa R, Sulistyaningsih P, Nureva M.D. (2020) Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI). Zahir Publishing: Sleman Yogyakarta
- Mardiana, Lina. (2007). *Kanker pada Wanita*. Niaga Swadaya
- Nisman, W. 2011. Lima Menit Kenali Payudara. Yogyakarta: Andistar.
- Nugroho. 2011. ASI dan Tumor Payudara. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Nurromah, A., Aprianti A., & Hartutik, S (2022) Risk Factors of Breast Cancer. *GAster Journal of Health Science*. 20(1), 1-10
- Olfah, Yustiana. Mendri, Ni Ketut. Badi'ah, Atik. (2019). Kanker payudara dan SADARI. Nuha Medika. Yogyakarta
- Rasjidi I, (2010). Deteksi Dini, dan Pencegahan Kanker Pada Wanita. CV Sagung Seto; Jakarta
- Rini Indriati, Henry Setyawan, Djoko Handoko, (2018) Faktor-faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian payudara wanita. *Jurnal Epidemiologi*; 1-8
- Sjamsuhidajat & de Jong, (2010). *Buku Ajar Ilmu Bedah*, Edisi II. Jakarta : EGC
- Sandra, Y. (2011). Melatonin dan Kanker Payudara. *Majalah Kesehatan Pharma Medika*, Vol 3, No.2: 286 – 291.
- Purwoastuti, E. 2008. Pencegahan Deteksi Dini Kanker Payudara. Yogyakarta: Kanisius.
- Yenda, H, Wirnsma, A.H, Defrin, D. (2019). Pengaruh Faktor Risiko Hormonal Pada Pasien Kanker Payudara di RSUP.Dr.M.Djamil Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*. 8(3), 523-528. : <http://dx.doi.org/10.25077/jka.v8i3.1037>

G. Glosarium

- SADARI = Pemeriksaan Payudara Sendiri
 SADANIS = Pemeriksaan Payudara Klinis

CHAPTER 2

PERAWATAN MENOPAUSE: PEMAHAMAN DAN PENGELOLAAN

Cintika Yorinda Sebtalesey, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Menopause merupakan fase alami dalam kehidupan wanita yang ditandai dengan penghentian menstruasi dan penurunan produksi hormon estrogen. Definisi menopause sering kali mencakup perimenopause, yaitu periode transisi yang terjadi beberapa tahun sebelum menopause resmi, di mana wanita mulai mengalami gejala-gejala yang terkait dengan perubahan hormonal. Pemahaman yang baik tentang menopause dan perimenopause sangat penting untuk membantu wanita mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup mereka selama fase ini (Ariani & Teja, 2021) (Sulistyowati & Susilawati, 2021). Kualitas hidup wanita menopause dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan tentang kondisi ini, dukungan sosial, dan gaya hidup sehat (Ariani & Teja, 2021) (Khoeriyah, 2024).

Usia rata-rata menopause bervariasi, tetapi umumnya terjadi antara usia 45 hingga 55 tahun. Beberapa faktor dapat memengaruhi usia onset menopause, termasuk faktor genetik, kesehatan umum, dan gaya hidup seperti pola makan dan aktivitas fisik (Sari & Istighosah, 2019). Selain itu, faktor psikologis seperti kecemasan dan stres juga dapat berkontribusi pada pengalaman menopause, yang menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan kesehatan wanita selama periode ini (Kamilie, Koesma, & Zamralita, 2020).

Pentingnya pemahaman menopause dalam menjaga kualitas hidup wanita tidak dapat diabaikan. Wanita yang memiliki pengetahuan yang baik tentang menopause lebih mampu mengatasi gejala yang muncul dan mencari bantuan medis jika diperlukan (Ariani & Teja, 2021) (Sulistyowati & Susilawati, 2021).

Selain itu, pemahaman ini juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya dukungan sosial dan aktivitas fisik dalam mengelola gejala menopause, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Ariani & Teja, 2021) (Khoeriyah, 2024). Oleh karena itu, edukasi tentang menopause harus menjadi bagian integral dari program kesehatan wanita untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalani fase ini dengan lebih baik dan lebih sehat.

B. Definisi Menopause

Menopause adalah peristiwa alami yang dialami oleh wanita ketika masa kesuburannya menurun. Hal ini dapat menimbulkan kecemasan atau kekhawatiran bagi sebagian wanita, sementara bagi yang lain justru meningkatkan rasa percaya diri (Suparni, 2016). Menopause menandai fase di mana seorang wanita tidak lagi mengalami menstruasi (Proverawati, 2010). Berhentinya menstruasi menunjukkan berakhirnya fungsi reproduksi, tetapi bukan berarti seorang wanita kehilangan perannya dalam memenuhi kebutuhan seksual suami (Icesmi, 2013).

Seiring bertambahnya usia, manusia mengalami berbagai proses perkembangan dan pertumbuhan. Sebelum memasuki fase menopause, wanita akan melewati tahap premenopause, yaitu masa transisi dari periode subur menuju kondisi di mana ovulasi tidak lagi terjadi (anovulasi). Umumnya, premenopause dialami oleh wanita di usia 40-an dan mencapai puncaknya sekitar usia 50 tahun, yang menandai fase menopause, di mana menstruasi berhenti sepenuhnya. Sebagian besar wanita mengalami menopause dalam kurun waktu kurang dari lima tahun, sementara sebagian kecil dapat mengalaminya lebih lama. Secara rata-rata, menopause terjadi pada usia 45 hingga 50 tahun.

Menopause merupakan suatu proses alami yang merupakan bagian dari penuaan dan terjadi pada setiap wanita. Namun, masa premenopause sering kali menimbulkan berbagai masalah akibat penurunan kadar estrogen, yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

Beberapa masalah yang muncul menjelang menopause antara lain berkurangnya kesuburan serta meningkatnya risiko osteoporosis. Jika tidak ditangani dengan baik, gejala yang muncul dapat menjadi lebih serius dan menyebabkan kecemasan. Kondisi ini dikenal sebagai sindrom premenopause, yang ditandai dengan berbagai gejala seperti hot flushes (sensasi panas yang menjalar dari dada ke wajah), night sweats (keringat berlebih di malam hari), gangguan ingatan, insomnia (kesulitan tidur), depresi atau kecemasan, kelelahan, penurunan gairah seksual, dyspareunia (nyeri saat berhubungan seksual), serta inkontinensia urin (sering buang air kecil).

Gejala-gejala premenopause ini dapat menimbulkan berbagai keluhan yang berbeda pada setiap wanita, tergantung pada cara mereka menghadapinya.

C. Insidensi Menopause

Sindrom premenopause dialami oleh banyak wanita di seluruh dunia. Diperkirakan sekitar 70-80% wanita di Eropa, 60% di Amerika, 57% di Malaysia, 18% di China, serta 10% di Jepang dan Indonesia mengalami kondisi ini. Berdasarkan data yang tersedia, salah satu faktor yang memengaruhi perbedaan angka tersebut

adalah pola makan. Wanita di Eropa dan Amerika memiliki kadar estrogen yang lebih tinggi dibandingkan wanita di Asia. Saat menopause terjadi, penurunan kadar estrogen pada wanita Eropa dan Amerika berlangsung lebih drastis dibandingkan wanita Asia yang memiliki kadar estrogen dalam jumlah moderat. Penurunan estrogen ini sering kali menyebabkan gejala yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

Beberapa gejala yang menyertai sindrom premenopause meliputi hot flushes (sensasi panas dari dada hingga wajah), night sweats (keringat berlebih di malam hari), kekeringan pada vagina, gangguan daya ingat, insomnia (sulit tidur), depresi atau kecemasan, kelelahan, penurunan gairah seksual, dyspareunia (nyeri saat berhubungan seksual), serta inkontinensia urin (sering buang air kecil). Munculnya gejala ini dapat menyebabkan berbagai keluhan yang ditanggapi secara berbeda oleh setiap wanita.

Perubahan akibat sindrom premenopause juga berdampak pada siklus menstruasi yang menjadi tidak teratur, yang secara otomatis berpengaruh pada organ reproduksi wanita. Fungsi ovarium yang menurun akan memengaruhi produksi hormon, yang kemudian memberikan dampak pada organ tubuh lainnya. Akibatnya, wanita dapat mengalami berbagai keluhan fisik, baik yang berkaitan dengan organ reproduksi maupun bagian tubuh lainnya. Selain itu, perubahan hormon ini sering kali berdampak pada kondisi psikologis seorang wanita.

Keluhan psikologis bersifat sangat individual dan dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, tingkat pendidikan, lingkungan, serta kondisi ekonomi. Gangguan fisik maupun psikis yang dialami tentu dapat memengaruhi kesehatan serta perkembangan emosional wanita. Bahkan, kondisi ini juga bisa berdampak pada kualitas hidup mereka. Beberapa wanita menyikapi masa premenopause dengan tenang, menganggapnya sebagai bagian dari siklus kehidupan yang alami.

Namun, banyak wanita merasa cemas saat memasuki premenopause. Kecemasan ini sering dikaitkan dengan kekhawatiran menghadapi situasi yang sebelumnya tidak menjadi masalah. Wanita yang mengalami kondisi ini cenderung lebih sensitif terhadap perubahan emosional akibat fluktuasi hormon. Hal ini dikhawatirkan dapat memengaruhi hubungan mereka dengan suami maupun lingkungan sosial. Selain itu, pada usia ini, risiko penyakit seperti kanker atau gangguan kesehatan lainnya meningkat, yang semakin menambah kecemasan bagi sebagian wanita yang memasuki fase premenopause.

D. Perubahan Fisiologis dan Gejala Menopause

Menopause adalah fase penting dalam kehidupan wanita yang ditandai dengan perubahan fisiologis yang signifikan, terutama terkait dengan perubahan

hormon, gejala umum, dan dampak jangka panjang yang dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan.

1. Perubahan hormon (penurunan estrogen dan progesteron)

Salah satu perubahan paling mencolok selama menopause adalah penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron. Estrogen berfungsi dalam berbagai proses fisiologis, termasuk regulasi siklus menstruasi dan pemeliharaan kesehatan tulang. Penurunan kadar estrogen yang terjadi selama menopause dapat menyebabkan berbagai gejala fisik dan psikologis, termasuk kekeringan vagina dan gangguan mood (Rahmansyah, Hairunisa, & Imran, 2023) (Widjayanti, 2022). Selain itu, penurunan progesteron juga berkontribusi terhadap ketidakseimbangan hormonal yang dapat memicu gejala seperti hot flashes dan gangguan tidur (Prior, 2011). Penelitian menunjukkan bahwa penurunan estrogen dapat mempercepat penurunan fungsi kognitif, yang berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit jantung (Rahmansyah, Hairunisa, & Imran, 2023).

2. Gejala umum: *hot flashes*, keringat malam, gangguan tidur, perubahan mood

Gejala menopause yang umum meliputi hot flashes, keringat malam, gangguan tidur, dan perubahan mood. Hot flashes, yang ditandai dengan sensasi panas mendadak, dapat terjadi akibat fluktuasi kadar estrogen yang mempengaruhi pusat pengaturan suhu di otak (Widjayanti, 2022). Keringat malam sering kali menyertai hot flashes dan dapat mengganggu kualitas tidur, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kelelahan dan masalah konsentrasi (Nainggolan, 2024). Perubahan mood, seperti kecemasan dan depresi, juga sering dilaporkan oleh wanita menopause, yang dapat disebabkan oleh perubahan hormonal serta faktor psikologis lainnya (Alchalidi Alchalidi, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80% wanita mengalami gejala fisik dan psikologis yang signifikan selama periode ini (Susanti & Indrajati, 2022).

3. Dampak jangka panjang: osteoporosis, penyakit kardiovaskular, perubahan metabolisme

Dampak jangka panjang dari menopause termasuk peningkatan risiko osteoporosis, penyakit kardiovaskular, dan perubahan metabolisme. Penurunan estrogen berkontribusi terhadap kehilangan massa tulang, yang meningkatkan risiko osteoporosis dan patah tulang (Rahmayani, Abdat, & Harira, 2023). Selain itu, wanita menopause juga berisiko lebih tinggi mengalami penyakit kardiovaskular, karena estrogen memiliki efek protektif terhadap kesehatan jantung (Rahmansyah, Hairunisa, & Imran, 2023). Perubahan metabolisme yang terjadi selama menopause dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan risiko obesitas, yang selanjutnya dapat berkontribusi pada masalah kesehatan

lainnya seperti diabetes tipe 2 (Simangunsong & Marlisa, 2022). Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang perubahan ini sangat penting untuk mempersiapkan wanita menghadapi menopause dengan lebih baik dan mengurangi risiko kesehatan jangka panjang (Widjayanti, 2022).

E. Faktor yang Mempengaruhi Gejala Pre Menopause

Beberapa faktor yang memengaruhi gejala premenopause antara lain:

1. Perubahan psikologis dan fisik

Gejala premenopause berkaitan erat dengan kadar estrogen dalam tubuh. Beberapa gejala utama yang sering muncul meliputi penurunan energi dan gairah, berkurangnya konsentrasi serta kemampuan akademik, serta perubahan emosi seperti mudah tersinggung, kesulitan tidur, perasaan kurang percaya diri, kesepian, ketakutan, ketidaksabaran, hingga munculnya agresivitas.

2. Faktor sosial dan ekonomi

Kondisi sosial ekonomi berpengaruh terhadap kesehatan fisik, tingkat pendidikan, dan kesejahteraan seseorang. Jika faktor-faktor tersebut dalam kondisi baik, maka beban fisiologis, psikologis, kesehatan, serta dampak klimakterium sebagai proses alami tubuh dapat berkurang.

3. Budaya dan lingkungan

Aspek budaya dan lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan wanita dalam beradaptasi dengan fase klimakterium. Faktor ini dapat menentukan sejauh mana seorang wanita mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi selama masa premenopause.

4. Faktor lainnya

Beberapa kondisi lain yang dapat memengaruhi pengalaman premenopause antara lain status pernikahan, status sebagai wanita karier baik yang sudah menikah maupun belum, serta keterlambatan menarche (menstruasi pertama). Faktor-faktor ini dapat memengaruhi tingkat keluhan yang dialami selama fase klimakterium, di mana gejalanya cenderung lebih ringan.

F. Perubahan Pada Perimenopause

Pola menstruasi menunjukkan variasi yang sangat besar antar individu, dengan pemendekan siklus sering kali menjadi tanda awal perubahan. Seiring waktu, ovarium secara bertahap menjadi kurang responsif terhadap stimulasi gonadotropin, yang disertai dengan peningkatan kadar FSH yang dapat terdeteksi selama fase folikular dalam siklus menstruasi.

Pada beberapa kasus, periode amenore dapat diselingi dengan menstruasi yang tetap teratur, meskipun umumnya terjadi pemanjangan siklus seiring

mendekati menstruasi terakhir. Siklus menstruasi yang lebih panjang menandakan tidak adanya ovulasi, dan perdarahan menstruasi yang terjadi setelahnya dapat menjadi lebih banyak akibat paparan endometrium terhadap estrogen dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa adanya pengaruh progesteron.

G. Siklus Kehidupan

Kata menopause berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata "men" yang berarti bulan, dan kata "peuseis" yang berarti penghentian sementara. Secara linguistik kata yang lebih tepat adalah menocease yang berarti berhentinya menstruasi. Pandangan medis, menopause ini tidak bias serta-merta diketahui, tetapi biasanya akan diketahui biasanya akan diketahui dari masa produktif menuju perlahan-lahan ke masa non produktif yang disebabkan berkurangnya hormone estrogen dan progesterone.

Ketika wanita dalam usia 40-an tidak adanya pembuahan (anovulasi) menjadi lebih nyata, dan sebelum anovulasi, siklus menstruasi memanjang, mulai 2 sampai 8 tahun sebelum menopause. Bila panjangnya siklus melebihi 42 hari. lamanya fase folikuler adalah penentu utama dari panjangnya siklus. Perubahan siklus menstruasi ini pada fase pre menopause ditandai dengan peningkatan follicle-stimulating hormone (FSH) dan penurunan kadar inhibin, tetapi kadar luteinizing-hormone (LH) normal dan sedikit peningkatan kadar estradiol.

Peningkatan FSH berkaitan hanya suatu penurunan inhibin-B, dalam persentase, konsentrasi estradiol meningkat sedikit. Penurunan sekresi inhibin oleh folikel-folikel ovarium terjadi mulai dini sekitar usia 35 tahun, tetapi menjadi cepat sesudah usia 40 tahun. Tahun-tahun perimenopause adalah periode waktu selama kadar FSH pascamenopause (>20 IU/L) dapat dilihat walaupun perdarahan menstruasi terus berlanjut, sementara kadar-kadar LH masih tetap dalam rentang normal kadang-kadang, pembentukan fungsi korpus luteum terjadi, dan wanita perimenopause tidak aman terhadap risiko dari suatu kehamilan yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan sampai peningkatan kadar FSH (>20 IU/L) dan LH (>30 IU/L) dapat ditunjukkan. Bahwa dalam kondisi ini, fluktuasi dapat terjadi, dengan suatu periode kegagalan ovarium diikuti oleh pemulaan lagi fungsi ovarium.

Perubahan kejiwaan seorang wanita menjelang menopause seorang wanita menjelang menopause meliputi masa tua, tidak menarik lagi, rasa tertekan karena takut menjadi tua, mudah tersinggung, mudah terkejut sehingga jantung berdebar, takut tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual suami rasa takut bahwa suami akan menyeleweng, keinginan seksual menurun dan sulit mencapai kepuasan (orgasme).

Perubahan wanita menuju masa baya antara 50-65.

1. Fase pramenopause (klimakterium)

Pada fase ini seorang wanita akan mengalami kekacauan pola menstruasi, terjadi perubahan psikologis/kejiwaan, terjadi perubahan fisik. Berlangsung selama 48-55 tahun.

2. Fase menopause

Terhentinya menstruasi. Perubahan dan keluhan psikologis dan fisik makin menonjol. Berlangsung sekitar 3-4 tahun. Pada usia antara 56-60 tahun.

3. Fase pasca menopause

Terjadi pada usia di atas 60-65 tahun. Wanita beradaptasi terhadap perubahan psikologis dan fisik. Keluhan makin berkurang.

Perubahan terjadi karena pada alat genitalia meliputi liang senggama terasa kering, lapisan sanggama menipis yang menyebabkan mudah terjadi infeksi (infeksi saluran kencing, infeksi liang senggama). Daerah sensitive makin sulit untuk di rangsang.

Saat hubungan seksual dapat terjadi nyeri (Dispareunia), dan sulit mencapai orgasme. Lemahnya penyangga alat kelamin bagian dalam menyebabkan kurang enak sekitar linang senggama, liang senggama terasa turun (menonjol) dalam bentuk tonjolan kandung kemih (sistokel), tonjolan dinding bagian belakang (rektokel), dan mulut Rahim terbuka. Kepuasan berkemih dan buang air besar semakin kurang seolah olah masih tersisa .

H. Diagnosis dan Evaluasi Medis

1. Cara menentukan menopause

Menopause dapat didiagnosis melalui kombinasi gejala klinis, tes hormon, dan evaluasi riwayat kesehatan. Gejala klinis seperti hot flashes, perubahan suasana hati, dan gangguan tidur sering kali muncul selama periode perimenopause dan dapat menjadi indikator awal menopause (Moser, Chodick, Bar-On, & Shalev, 2020). Tes hormon, khususnya pengukuran kadar hormon perangsang folikel (FSH) dan estradiol, juga digunakan untuk menentukan status menopause. Kadar FSH yang tinggi dan estradiol yang rendah menunjukkan bahwa seorang wanita mungkin telah memasuki fase menopause (Vahidroodsari, Ayati, Yousefi, & Saeed, 2010). Selain itu, perubahan pH vagina juga dapat digunakan sebagai indikator menopause, dengan pH yang lebih tinggi menunjukkan penurunan estrogen (Panda, Das, & Singh, 2014).

2. Kapan perlu berkonsultasi dengan tenaga medis

Wanita disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis jika mengalami gejala menopause yang mengganggu kualitas hidup, seperti depresi,

kecemasan, atau insomnia yang berkepanjangan (Moser, Chodick, Bar-On, & Shalev, 2020). Konsultasi juga penting jika ada riwayat kesehatan yang dapat memperburuk gejala menopause, seperti penyakit jantung atau osteoporosis, yang lebih umum terjadi pada wanita yang mengalami menopause lebih awal (Panay, Anderson, & Nappi, 2020) (Letourneau, Ebbel, & Katz, 2011).

3. Perbedaan menopause alami dan menopause akibat intervensi medis (operasi, kemoterapi)

Menopause alami terjadi sebagai bagian dari proses penuaan, biasanya antara usia 45 hingga 55 tahun, sedangkan menopause akibat intervensi medis, seperti operasi pengangkatan ovarium atau kemoterapi, dapat terjadi lebih awal dan sering kali disertai dengan gejala yang lebih parah (Panay, Anderson, & Nappi, 2020); (Letourneau, Ebbel, & Katz, 2011); (Marino, Saunders, & Emery, 2014). Wanita yang mengalami menopause dini akibat intervensi medis berisiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan jangka panjang, termasuk penyakit kardiovaskular dan osteoporosis, dibandingkan dengan mereka yang mengalami menopause secara alami (Panay, Anderson, & Nappi, 2020).

I. Pendekatan Pengelolaan Menopause

1. Terapi Hormonal

- a. Terapi penggantian hormon (HRT): HRT dapat membantu mengurangi gejala menopause seperti hot flashes dan gangguan tidur, serta melindungi terhadap osteoporosis (Akbarzadeh, Ebrahimi, & Tayebi, 2020); (Donohoe, O'Meara, & Roberts, 2022). Namun, HRT juga memiliki risiko, termasuk peningkatan risiko kanker payudara dan penyakit jantung, terutama pada wanita dengan riwayat kesehatan tertentu (Donohoe, O'Meara, & Roberts, 2022); (Hogan, 2024)). Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kontraindikasi dan melakukan diskusi mendalam dengan tenaga medis sebelum memulai terapi ini (Akbarzadeh, Ebrahimi, & Tayebi, 2020); (Donohoe, O'Meara, & Roberts, 2022)).
- b. Alternatif non-hormonal untuk manajemen gejala
- c. Alternatif non-hormonal, seperti penggunaan suplemen herbal (misalnya, isoflavon kedelai) dan terapi akupunktur, semakin populer di kalangan wanita yang mencari pengobatan tanpa efek samping dari HRT (Akbarzadeh, Ebrahimi, & Tayebi, 2020); (Coppus, Evenhuis, & Verberne, 2010)). Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat membantu mengurangi gejala menopause tanpa risiko yang terkait dengan terapi hormonal (Akbarzadeh et al., 2020; Coppus et al., 2010).

2. Pendekatan Non-Medikamentosa

a. Perubahan gaya hidup (diet, olahraga, manajemen stres)

Perubahan gaya hidup, termasuk diet sehat, olahraga teratur, dan teknik manajemen stres, dapat membantu mengelola gejala menopause dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Akbarzadeh, Ebrahimi, & Tayebi, 2020); (Donohoe, O'Meara, & Roberts, 2022)). Penelitian menunjukkan bahwa wanita yang aktif secara fisik dan memiliki pola makan seimbang cenderung mengalami gejala menopause yang lebih ringan (Akbarzadeh, Ebrahimi, & Tayebi, 2020); (Coppus, Evenhuis, & Verberne, 2010)).

b. Pengobatan herbal dan terapi komplementer (soy isoflavin, akupunktur)

Pengobatan herbal, seperti penggunaan suplemen berbasis kedelai dan akupunktur, telah terbukti efektif dalam mengurangi gejala menopause (Akbarzadeh, Ebrahimi, & Tayebi, 2020); (Coppus, Evenhuis, & Verberne, 2010)). Terapi ini sering dipilih oleh wanita yang ingin menghindari efek samping dari terapi hormonal dan mencari pendekatan yang lebih alami (Akbarzadeh, Ebrahimi, & Tayebi, 2020); (Coppus, Evenhuis, & Verberne, 2010)).

J. Aspek Psikologis dan Sosial

1. Dampak menopause pada kesehatan mental

Menopause dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental wanita, dengan peningkatan risiko depresi dan kecemasan (Moser, Chodick, Bar-On, & Shalev, 2020); (Marino, Saunders, & Emery, 2014)). Penurunan kadar estrogen dapat mempengaruhi neurotransmitter yang berperan dalam suasana hati, sehingga meningkatkan kemungkinan gangguan mental (Moser, Chodick, Bar-On, & Shalev, 2020); (Marino, Saunders, & Emery, 2014)).

2. Dukungan sosial dan psikologis bagi wanita menopause

Dukungan sosial dari keluarga dan teman sangat penting bagi wanita yang mengalami menopause. Penelitian menunjukkan bahwa wanita dengan jaringan dukungan sosial yang kuat cenderung memiliki pengalaman menopause yang lebih positif (Moser, Chodick, Bar-On, & Shalev, 2020); (Marino, Saunders, & Emery, 2014)). Terapi kelompok juga dapat memberikan ruang bagi wanita untuk berbagi pengalaman dan strategi coping (Moser, Chodick, Bar-On, & Shalev, 2020); (Marino, Saunders, & Emery, 2014)).

3. Peran keluarga dan pasangan dalam mendukung wanita menghadapi menopause

Mendukung Wanita Menghadapi Menopause** Keluarga dan pasangan memiliki peran penting dalam mendukung wanita selama transisi menopause. Dukungan emosional dan pemahaman dari pasangan dapat membantu

mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup (Moser, Chodick, Bar-On, & Shalev, 2020)). Keterlibatan keluarga dalam proses ini juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi wanita yang mengalami perubahan ini (Marino, Saunders, & Emery, 2014).

K. Pencegahan dan Kesehatan Jangka Panjang

1. Pencegahan osteoporosis (asupan kalsium dan vitamin D, olahraga)

Asupan kalsium dan vitamin D yang cukup, bersama dengan olahraga teratur, sangat penting untuk mencegah osteoporosis pada wanita pasca-menopause (Panay, Anderson, & Nappi, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa wanita yang menjaga asupan nutrisi ini memiliki risiko yang lebih rendah terhadap patah tulang dan masalah kesehatan tulang lainnya (Panay, Anderson, & Nappi, 2020).

2. Manajemen kesehatan jantung pasca menopause

Setelah menopause, risiko penyakit jantung meningkat, sehingga penting bagi wanita untuk memantau kesehatan jantung mereka secara rutin (Panay, Anderson, & Nappi, 2020). Gaya hidup sehat, termasuk diet seimbang dan aktivitas fisik, dapat membantu mengurangi risiko ini (Bove, Healy, & Musallam, 2015).

3. Pemeriksaan kesehatan rutin dan skrining yang disarankan

Pemeriksaan kesehatan rutin, termasuk skrining untuk kanker payudara dan kanker serviks, sangat penting bagi wanita pasca-menopause (Bove, Healy, & Musallam, 2015). Skrining ini membantu dalam deteksi dini dan pengelolaan potensi masalah kesehatan yang lebih serius (Bove, Healy, & Musallam, 2015).

L. Kesimpulan

Menopause merupakan fase yang kompleks dan multifaset dalam kehidupan wanita yang melibatkan perubahan hormonal yang signifikan, gejala umum yang mengganggu, dan dampak jangka panjang yang dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Edukasi dan dukungan yang tepat sangat penting untuk membantu wanita menghadapi perubahan ini dengan lebih baik. Memahami menopause dan dampaknya pada kesehatan fisik dan mental sangat penting bagi wanita untuk mengelola transisi ini dengan lebih baik (Moser, Chodick, Bar-On, & Shalev, 2020). Pengetahuan ini memungkinkan wanita untuk mengambil langkah proaktif dalam menjaga kesehatan mereka. Langkah-langkah praktis, seperti perubahan gaya hidup, dukungan sosial, dan konsultasi medis yang tepat, dapat meningkatkan kesejahteraan wanita selama menopause (Moser, Chodick, Bar-On, & Shalev, 2020). Edukasi tentang menopause juga penting untuk meningkatkan

kesadaran dan pemahaman di masyarakat (Moser, Chodick, Bar-On, & Shalev, 2020). Ajakan untuk lebih meningkatkan kesadaran dan edukasi menopause dalam masyarakat sangat penting, mengingat dampak signifikan yang dapat ditimbulkan oleh menopause pada kesehatan dan kualitas hidup wanita (Moser, Chodick, Bar-On, & Shalev, 2020).

M. Referensi

- Akbarzadeh, M., Ebrahimi, A., & Tayebi, N. (2020). Investigation Of The Role Of Herbal Medicine, Acupressure, And Acupuncture In The Menopausal Symptoms: An Evidence-Based Systematic Review Study. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 9(6), 2638. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_1094_19.
- Alchalidi Alchalidi, N. V. (2022). Edukasi Untuk Menurunkan Keluhan Wanita Menopause Berdasarkan Skor Menopausal Rating Scale Di Desa Sidodadi Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 5(2), 303-310.
- Ariani, N. K., & Teja, N. M. (2021). Tingkat Pengetahuan Tentang Menopause Dengan Kualitas Hidup Wanita Perimenopause di Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida. *Jurnal Media Kesehatan*, 14(1), 46-53.
- Bove, R., Healy, B. C., & Musallam, A. (2015). Exploration Of Changes In Disability After Menopause In A Longitudinal Multiple Sclerosis Cohort. *Multiple Sclerosis Journal*, 22(7), 935-943. <https://doi.org/10.1177/1352458515606211>.
- Coppus, A., Evenhuis, H. M., & Verberne, G.-J. (2010). Early Age At Menopause Is Associated With Increased Risk Of Dementia And Mortality In Women With Down Syndrome. *Journal of Alzheimer S Disease*, 19(2), 545-550. <https://doi.org/10.3233/jad-2010-1247>.
- Donohoe, F., O'Meara, Y. M., & Roberts, A. (2022). Using Menopausal Hormone Therapy After A Cancer Diagnosis In Ireland. *Irish Journal of Medical Science (1971 -)*, 192(1), 45-55. <https://doi.org/10.1007/s11845-022-02947-6>.
- Hogan, K. (2024). Postmenopausal Hormone Therapy Was Associated With Later Age Of Onset Among Glaucoma Cases. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, 65(10), 31.
- Kamilie, I., Koesma, R. E., & Zamralita, Z. (2020). Pengaruh Kecemasan Terhadap Penyesuaian Pernikahan Pada Wanita Perimenopause. *Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora Dan Seni*, 4(2), 516.
- Khoeriyah, N. (2024). Aktifitas Fisik Dan Kualitas Hidup Wanita Menopause : Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (Mppki)*, 7(3), 613-619.

- Letourneau, J. M., Ebbel, E., & Katz, P. (2011). Acute Ovarian Failure Underestimates Age-Specific Reproductive Impairment For Young Women Undergoing Chemotherapy For Cancer. *Cancer*, 118(7), 1933-1939. <https://doi.org/10.1002/cncr.26403>.
- Marino, J. L., Saunders, C., & Emery, L. (2014). Nature And Severity Of Menopausal Symptoms And Their Impact On Quality Of Life And Sexual Function In Cancer Survivors Compared With Women Without A Cancer History. *Menopause the Journal of the North American Menopause Society*, 21(3), 267-274. <https://doi.org/10.1097/gme.0b013e3182976f46>.
- Moser, S. S., Chodick, G., Bar-On, S., & Shalev, V. (2020). Healthcare Utilization And Prevalence Of Symptoms In Women With Menopause: A Real-World Analysis. *International Journal of Women S Health, Volume 12*, 445-454.
- Nainggolan, W. (2024). Pemberian Terapi Akupresur Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Tidur Dan Kadar Estrogen Pada Wanita Menopause. *Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health)*, 10(1), 214-221.
- Panay, N., Anderson, R. A., & Nappi, R. E. (2020). Premature Ovarian Insufficiency: An International Menopause Society White Paper. *Climacteric*, 23(5), 426-446. <https://doi.org/10.1080/13697137.2020.1804547>.
- Panda, S., Das, A., & Singh, A. S. (2014). Vaginal Ph: A Marker For Menopause. *Journal of Mid-Life Health*, 5(1), 34. <https://doi.org/10.4103/0976-7800.127789>.
- Prior, J. C. (2011). The Endocrinology Of Perimenopause Need For A Paradigm Shift. *Frontiers in Bioscience-Elite*, S3(2), 474-486.
- Rahmansyah, M., Hairunisa, N., & Imran, Y. (2023). Peran Ketebalan Tunika Intima Media Karotis Terhadap Fungsi Kognitif Pada Wanita Menopause. *Majalah Kedokteran Neurosains Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia*, 39(2), 39-45.
- Rahmayani, L., Abdat, M., & Harira, S. (2023). Gambaran Kehilangan Gigi Pada Pasien Yang Beresiko Osteoporosis Paska Menopause Di RSGM Universitas Syiah Kuala. *Cakradonya Dental Journal*, 13(2), 137-143.
- Sari, A. N., & Istighosah, N. (2019). Hubungan Olahraga, Kopi dan Merokok dengan Kualitas Hidup Wanita Menopause yang Tinggal di Wilayah Pedesaan. *urnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 6(3), 326-332.
- Simangunsong, D. E., & Marlisa, M. (2022). Pelatihan Prevensi Peningkatan Berat Badan Wanita Menopause Pada Kader Kesehatan. *Poltekita Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 747-757.
- Sulistyowati, I., & Susilawati, D. (2021). Hubungan Sindrom Menopause Dengan Kualitas Hidup Wanita Menopause Di Kelurahan Genuk Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Keperawatan Maternitas*, 4(2), 29-37.

- Susanti, E. T., & Indrajati, U. (2022). Tingkat Pengetahuan Tentang Menopause Dengan Kesiapan Menghadapi Menopause Pada Ibu Premenopause. *Jurnal Keperawatan Karya Bhakti*, 8(2), 78-84.
- Vahidroodsari, F., Ayati, S., Yousefi, Z., & Saeed, S. (2010). Comparing Serum Follicle-Stimulating Hormone (FSH) Level With Vaginal PH In Women With Menopausal Symptoms. *Oman Medical Journal*, 25(1), https://www.omjournal.org/OriginalArticles/FullText/201001/FT_ComparingSerumFollicle-StimulatingHormone.html.
- Widjayanti, Y. (2022). Increasing The Knowledge Of Menopause Women & Families Through Tlakshow "Healthy And Happy In The Menopause Period". *urnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan*, 8(4), 351-355.

N. Glosarium

FSH : follicle- stimulating hormone
HRT : hormone replacement therapy
LH : lutenizing-hormone
WUS = Wanita Usia Subur

CHAPTER 3

KESEHATAN REPRODUKSI PADA WANITA REMAJA: EDUKASI MENSTRUASI DAN PENGELOLAAN MASALAH REPRODUKSI

Machria Rachman, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Masa remaja adalah periode kritis di mana individu mengalami berbagai perubahan signifikan yang memengaruhi kesehatan reproduksi mereka. Salah satu perubahan yang terjadi adalah menstruasi. Menstruasi merupakan proses biologis yang normal dan dialami oleh perempuan pertama kali saat masa pubertas (*menarche*). Proses ini menandai kemampuan reproduksi yang mulai matang, namun sering kali diiringi oleh tantangan fisik, emosional, dan sosial. Remaja lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi. Kurangnya pengetahuan dan akses terhadap informasi yang akurat mengenai kesehatan reproduksi dapat meningkatkan risiko perilaku berisiko, infeksi menular seksual, dan masalah menstruasi.

Secara global, sebanyak 1,8 miliar perempuan di dunia berada pada usia reproduktif, dan banyak di antaranya menghadapi hambatan dalam mengelola menstruasi dengan cara yang sehat dan bermartabat. Ketidaktahuan mengenai menstruasi dapat menyebabkan stres, kecemasan, stigma sosial, serta kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti sekolah atau kegiatan sosial (UNESCO, 2018). Di Indonesia, hasil survei SDKI 2017 menunjukkan bahwa pengetahuan remaja perempuan tentang kesehatan reproduksi, termasuk menstruasi, masih rendah. Banyak remaja yang mengandalkan informasi dari teman sebaya atau sumber yang tidak kredibel, sehingga meningkatkan risiko kesalahpahaman dan praktik yang kurang higienis (BPS, 2020).

Kebutuhan remaja akan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai kesehatan reproduksi sangat penting. Edukasi yang tepat dapat membantu mereka memahami perubahan yang terjadi dalam tubuh mereka, mengelola menstruasi dengan baik, dan menghindari perilaku berisiko. Selain itu, pengetahuan yang memadai dapat memberdayakan remaja untuk membuat keputusan yang sehat dan bertanggung jawab terkait kesehatan reproduksi mereka.

B. Kesehatan Reproduksi pada Remaja Perempuan

Kesehatan reproduksi pada remaja perempuan merujuk pada kondisi kesehatan organ reproduksi, termasuk fungsi, proses, dan sistem yang berhubungan. Kesehatan reproduksi yang baik mencakup bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelainan, tetapi juga keadaan yang sehat dari segi fisik, mental, dan sosial (WHO, 2018). Remaja perempuan mengalami fase perubahan drastis yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu pubertas, ditandai oleh berbagai perubahan yang terjadi secara simultan pada tubuh, pikiran, dan interaksi sosial mereka. Perubahan dimulai dari fisik yaitu muncul tanda seks sekunder (payudara membesar, melebarnya pinggul, dan tumbuhnya bulu kemaluan) dan primer (menstruasi untuk pertama kali); perubahan psikologis seperti timbul dorongan seksual, emosi tidak stabil, pencarian identitas; serta sosial yaitu remaja mulai mengeksplorasi hubungan interpersonal, baik dengan teman sebaya maupun dengan lawan jenis, dan adaptasi dengan kelompok sering memengaruhi perilaku dan keputusan mereka (UNESCO, 2018).

Pada remaja, kesehatan reproduksi melibatkan kesiapan fisik, pemahaman emosional, dan edukasi yang memadai untuk mendukung perkembangan mereka. Komponen utama kesehatan reproduksi remaja meliputi: 1) Kesehatan Fisik: yaitu terkait pemeliharaan organ reproduksi yang sehat; 2) Kesehatan Mental: mengenai pemahaman yang baik tentang perubahan tubuh dan emosi selama pubertas; dan 3) Kesehatan Sosial adalah Kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan tanpa terpengaruh oleh stigma atau tekanan terkait reproduksi.

Kesehatan reproduksi pada remaja merupakan salah satu aspek penting dalam tahap perkembangan mereka. Pemahaman yang komprehensif tentang kesehatan reproduksi tidak hanya membantu remaja menjalani pubertas dengan baik tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang bertanggung jawab terkait kesehatan seksual dan reproduksi mereka

C. Edukasi Menstruasi

Menstruasi adalah proses fisiologis yang normal dan merupakan bagian dari perkembangan reproduksi perempuan. Pemahaman yang komprehensif tentang menstruasi sangat penting bagi remaja untuk membantu mereka memahami perubahan tubuh, mengurangi kecemasan, dan mendeteksi masalah kesehatan reproduksi sejak dini. Dalam konteks remaja, edukasi mengenai menstruasi tidak hanya penting untuk mengatasi ketidaktahuan, tetapi juga untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal. Berikut adalah komponen penting dalam pemberian edukasi menstruasi pada remaja:

1. Pengetahuan Dasar tentang Menstruasi

Pengetahuan dasar tentang menstruasi adalah fondasi penting yang harus dipahami oleh remaja untuk memastikan kesehatan fisik, mental, dan sosial selama periode ini. Beberapa aspek utama yang perlu ditekankan yaitu:

a. Definisi dan Proses Menstruasi

Menstruasi adalah proses alami yang terjadi pada perempuan usia reproduktif, yaitu pelepasan lapisan endometrium dari rahim melalui vagina sebagai hasil dari siklus menstruasi. Proses ini terjadi jika tidak ada pembuahan yang menyebabkan kehamilan (UNICEF, 2019). *Menarche*, atau menstruasi pertama pada remaja perempuan, biasanya terjadi antara usia 10 hingga 16 tahun, dan rata-rata pada usia 12-13 tahun di populasi dengan status gizi baik (*American College of Obstetricians and Gynecologists* [ACOG], 2015). *Menarche* sering kali terjadi 2-3 tahun setelah dimulainya perkembangan payudara (*thelarche*), yaitu saat remaja mencapai tahap IV perkembangan payudara berdasarkan skala Tanner. Sebanyak 98% remaja perempuan mengalami *menarche* sebelum usia 15 tahun (ACOG, 2015). Usia *menarche* dapat dipengaruhi faktor genetik, nutrisi, kondisi sosial ekonomi dan kesehatan umum (WHO & UNICEF, 2018). Siklus menstruasi rata-rata berlangsung selama 28 hari, meskipun siklus normal berkisar antara 21 hingga 35 hari (Sommer et al., 2016). Pada tahap awal *menarche*, siklus menstruasi sering kali tidak teratur. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon dan maturasi sumbu hipotalamus-hipofisis-ovarium yang belum sempurna, yang mengakibatkan anovulasi. Siklus menstruasi normal pada remaja adalah 21-45 hari. Siklus yang lebih panjang atau lebih pendek dapat terjadi tetapi umumnya bersifat sementara. Dalam tiga tahun setelah *menarche*, sebagian besar siklus akan berkisar antara 21-34 hari, seperti pada orang dewasa (ACOG, 2015). Durasi Menstruasi biasanya berlangsung selama 2-7 hari dengan penggunaan rata-rata 3-6 pembalut atau tampon per hari.

Pemantauan siklus menstruasi, baik secara manual maupun dengan aplikasi digital, direkomendasikan untuk mendeteksi kelainan sejak dini. Edukasi mengenai hal ini penting untuk mengurangi kecemasan remaja yang mungkin khawatir dengan ketidakteraturan siklus mereka (Sommer et al., 2016).

b. Perubahan Fisik dan Hormonal

Menstruasi melibatkan perubahan hormonal yang signifikan dalam tubuh perempuan. Selama fase folikular awal, kadar estrogen meningkat, mempersiapkan tubuh untuk ovulasi. Setelah ovulasi, kadar progesteron meningkat, yang membantu mempersiapkan rahim untuk kemungkinan implantasi embrio (UNICEF, 2019). Perubahan hormonal ini tidak hanya

memengaruhi fungsi tubuh, tetapi juga suasana hati, energi, dan fungsi kognitif remaja. Sebagian remaja mungkin mengalami gejala seperti nyeri perut (dismenore), kelelahan, atau perubahan suasana hati (Sommer et al., 2016). Pemahaman tentang hubungan antara hormon dan perubahan tubuh dapat membantu remaja mengelola gejala ini dengan lebih baik.

c. Dampak Sosial dan Psikologis Menstruasi

Menstruasi sering kali menjadi sumber stigma sosial, terutama di masyarakat yang masih menganggap menstruasi sebagai topik tabu. Akibatnya, banyak remaja perempuan merasa malu, cemas, atau terisolasi selama menstruasi (UNICEF, 2019). Di beberapa budaya, mitos seperti "perempuan menstruasi tidak boleh menyentuh makanan" atau "tidak boleh beribadah" masih banyak ditemukan, yang dapat memengaruhi harga diri dan partisipasi sosial remaja (Sommer et al., 2016). Edukasi yang baik dapat membantu mengurangi stigma ini. Pendekatan inklusif yang melibatkan laki-laki dalam edukasi menstruasi juga penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi remaja perempuan (WHO & UNICEF, 2018).

d. Nutrisi dan Kesehatan Selama Menstruasi

Nutrisi memainkan peran penting dalam mendukung kesehatan selama menstruasi, terutama bagi remaja perempuan yang sedang mengalami perkembangan fisik dan hormonal. Kebutuhan nutrisi yang tercukupi dapat membantu mengurangi gejala menstruasi, mencegah defisiensi nutrisi, dan mendukung kesejahteraan emosional. Menstruasi menyebabkan kehilangan darah yang dapat meningkatkan risiko anemia, terutama pada remaja dengan asupan zat besi yang rendah. Oleh karena itu, pola makan sehat yang kaya zat besi (daging merah, ayam, dan ikan; bayam, kacang-kacangan, dan sereal), folat, dan vitamin B12 sangat penting untuk mendukung kesehatan selama menstruasi (Sommer et al., 2016). Diet yang kaya buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak, biji-bijian utuh, dan lemak sehat dapat mendukung keseimbangan hormonal dan kesehatan reproduksi. Mengonsumsi makanan dalam porsi kecil tetapi sering juga dapat membantu menjaga energi sepanjang hari dan mencegah kelelahan. Selain itu, hidrasi yang cukup dapat membantu meringankan gejala seperti nyeri kepala atau kelelahan.

e. Pemahaman tentang Ketidaknormalan Menstruasi

Penting bagi remaja untuk mengenali tanda-tanda ketidaknormalan menstruasi, seperti:

1) Amenore primer

Tidak adanya menstruasi pada usia 15 tahun, atau 3 tahun setelah *thelarche*. Penyebabnya meliputi kelainan genetik (misalnya sindrom Turner), gangguan hormon, atau malformasi organ reproduksi

2) Menorrhagia

Pendarahan menstruasi yang sangat banyak atau berkepanjangan. Ditandai dengan perdarahan yang memerlukan penggantian pembalut setiap 1-2 jam atau perdarahan yang berlangsung lebih dari 7 hari. Menorrhagia dapat mengindikasikan gangguan koagulasi seperti penyakit von Willebrand.

3) Siklus Tidak Teratur

Anovulasi adalah penyebab umum siklus tidak teratur pada tahun-tahun awal *menarche*. Namun, jika terjadi lebih dari 3 bulan tanpa menstruasi, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk kondisi seperti PCOS atau gangguan tiroid

4) Dismenore Berat:

Nyeri saat menstruasi biasanya dialami pada hari ke 1-3 yang sangat parah sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

Jika tanda-tanda ini muncul, remaja perlu diarahkan untuk mencari bantuan medis guna mencegah komplikasi lebih lanjut (Sommer et al., 2016). Remaja perempuan dan keluarga mereka sering kali tidak memahami apa yang dianggap sebagai pola menstruasi normal. Hal ini dapat menyebabkan kecemasan, terutama ketika menstruasi pertama kali dimulai (ACOG, 2015). Oleh karena itu Orang tua dan guru harus dilibatkan dalam memberikan informasi dasar tentang menstruasi sebelum *menarche* terjadi. Pada setiap kunjungan kesehatan, tenaga medis disarankan untuk menanyakan pola menstruasi remaja sebagai bagian dari pemeriksaan vital karena menstruasi mencerminkan status kesehatan secara keseluruhan.

2. Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM)

Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) adalah proses menjaga kebersihan dan kesehatan selama menstruasi dengan memastikan penggunaan material yang aman, menjaga kebersihan tubuh, dan membuang produk menstruasi secara layak. WHO dan UNICEF (2012) mendefinisikan MKM sebagai kemampuan perempuan untuk menggunakan material bersih untuk menyerap darah menstruasi, menggantinya secara privat, menggunakan sabun dan air untuk mencuci tubuh, serta memiliki fasilitas untuk membuang produk menstruasi secara aman. MKM bukan hanya tentang kebutuhan fisik, tetapi juga terkait dengan hak perempuan untuk menjalani menstruasi secara sehat, aman, dan bermartabat.

Aspek utama MKM meliputi:

a. Penggunaan Produk Menstruasi yang Tepat

Pemilihan produk menstruasi yang tepat adalah komponen penting dalam MKM. Produk yang umum digunakan meliputi pembalut, tampon, dan cangkir menstruasi. Produk menstruasi yang baik harus aman, nyaman, terjangkau, dan mudah diakses.

- 1) Pembalut: Produk ini banyak digunakan karena mudah ditemukan dan sederhana dalam penggunaannya. Namun, remaja perlu mengetahui cara mengganti pembalut setiap 4-6 jam untuk mencegah iritasi kulit atau infeksi.
- 2) Tampon: Tampon memberikan fleksibilitas lebih dalam beberapa aktivitas, seperti olahraga. Namun, penggunaannya harus disertai edukasi yang memadai untuk mencegah sindrom syok toksik (toxic shock syndrome).
- 3) Cangkir Menstruasi (*menstrual cup*): Sebagai alternatif yang ramah lingkungan, cangkir menstruasi mulai populer. Namun, penggunaannya memerlukan pelatihan awal untuk memastikan kenyamanan dan kebersihan (Sommer et al., 2016).

Selain itu, penting untuk mendidik remaja tentang pentingnya mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti produk menstruasi. Hal ini mencegah penyebaran bakteri dan menjaga kesehatan reproduksi (UNICEF, 2019).

b. Kebersihan Diri selama Menstruasi

Kebersihan diri selama menstruasi melibatkan pembersihan area genital secara teratur dengan air bersih dan sabun tanpa pewangi. Pewangi dapat menyebabkan iritasi atau mengganggu pH alami vagina (Sommer et al., 2016). Cara cebok yang tepat yaitu dari arah depan genitalia ke belakang juga penting diperhatikan. Penelitian menunjukkan bahwa praktik kebersihan yang buruk, seperti tidak mencuci tangan atau mengganti pembalut terlalu jarang, dapat meningkatkan risiko infeksi saluran reproduksi (Dasgupta & Sarkar, 2020). Selain itu, menggunakan pakaian dalam yang bersih dan menyerap keringat membantu menjaga kebersihan dan mencegah iritasi kulit.

c. Pembuangan Produk Menstruasi secara Aman

Pembuangan produk menstruasi sering kali menjadi tantangan, terutama di wilayah dengan fasilitas sanitasi yang tidak memadai. Menurut UNICEF (2019), remaja perempuan perlu diberi edukasi tentang cara membuang produk menstruasi dengan aman untuk menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini termasuk: membungkus produk dengan kertas sebelum membuangnya ke tempat sampah tertutup, dan menghindari membuang produk menstruasi ke toilet, yang dapat menyebabkan saluran air tersumbat.

Di beberapa daerah, kurangnya fasilitas pembuangan yang layak menjadi kendala besar. WHO dan UNICEF (2018) merekomendasikan pembangunan fasilitas sanitasi di sekolah yang ramah remaja, termasuk toilet terpisah dengan tempat sampah tertutup untuk membuang produk menstruasi.

MKM) merupakan aspek krusial dalam kesehatan reproduksi perempuan. Namun, implementasinya di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai tantangan dalam pelaksanaan MKM diantaranya:

a. Stigma dan Mitos Sosial

Menstruasi sering dianggap sebagai topik tabu di banyak budaya, termasuk di Indonesia. Stigma ini menyebabkan kurangnya diskusi terbuka tentang menstruasi, remaja perempuan enggan membicarakan atau mencari solusi untuk masalah kebersihan menstruasi, yang berdampak pada minimnya pengetahuan mengenai MKM yang baik dan benar (Sommer et al., 2016). Penelitian oleh Anjum et al. (2019) menunjukkan bahwa stigma sosial terkait menstruasi menghambat akses perempuan terhadap informasi dan fasilitas yang memadai untuk MKM.

b. Kurangnya Fasilitas Sanitasi yang Memadai

Banyak sekolah dan tempat umum di Indonesia tidak dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang memadai untuk mendukung MKM. Di banyak wilayah, terutama pedesaan, akses terhadap air bersih dan toilet yang layak masih terbatas. Penelitian WHO & UNICEF (2018) menunjukkan bahwa 69% sekolah di negara berkembang tidak memiliki fasilitas sanitasi dasar, yang sangat memengaruhi kemampuan remaja perempuan untuk mengelola menstruasi mereka dengan layak. Hal ini mencakup kurangnya akses terhadap air bersih, toilet yang layak, dan tempat pembuangan produk menstruasi. Studi oleh Sigiyo (2018) menemukan bahwa minimnya fasilitas sanitasi di sekolah menghambat praktik MKM yang baik di kalangan remaja perempuan.

c. Kurangnya Edukasi dan Informasi

Minimnya edukasi formal mengenai menstruasi dan MKM menyebabkan remaja perempuan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola menstruasi mereka dengan baik. Penelitian oleh Dasgupta dan Sarkar (2020) menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan yang tidak memadai berkontribusi pada praktik MKM yang buruk di kalangan remaja perempuan.

d. Keterbatasan Akses terhadap Produk Menstruasi

Di beberapa daerah, akses terhadap produk menstruasi yang aman dan terjangkau masih menjadi masalah. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, distribusi yang tidak merata, dan kurangnya informasi mengenai pilihan

produk yang tersedia. Studi oleh Anuttami (2021) menyoroti bahwa keterbatasan akses terhadap produk menstruasi yang layak menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan MKM yang efektif.

Beberapa intervensi yang direkomendasikan untuk meningkatkan MKM antara lain:

a. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran

Memberikan edukasi yang komprehensif mengenai menstruasi dan MKM kepada remaja perempuan dan masyarakat luas dapat mengurangi stigma dan meningkatkan praktik MKM yang baik. Program edukasi yang melibatkan guru, orang tua, dan tenaga kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap positif terhadap menstruasi. Penelitian oleh Sitohang dan Adella (2020) menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa tentang MKM.

b. Penyediaan Fasilitas Sanitasi yang Memadai

Membangun dan memperbaiki fasilitas sanitasi di sekolah dan tempat umum, seperti toilet yang bersih, akses air bersih, dan tempat pembuangan produk menstruasi, sangat penting untuk mendukung MKM. Intervensi ini dapat meningkatkan kenyamanan dan kesehatan remaja perempuan selama menstruasi. Studi oleh Sigiro (2018) menekankan pentingnya fasilitas sanitasi yang memadai dalam mendukung MKM di sekolah.

c. Penyediaan Produk Menstruasi yang Terjangkau dan Aman

Memastikan ketersediaan produk menstruasi yang aman, terjangkau, dan ramah lingkungan dapat membantu remaja perempuan mengelola menstruasi mereka dengan lebih baik. Program subsidi atau distribusi gratis produk menstruasi di sekolah dapat menjadi solusi efektif (Dasgupta & Sarkar, 2020). Penelitian oleh Anuttami (2021) menunjukkan bahwa intervensi yang memastikan akses terhadap produk menstruasi dapat meningkatkan praktik MKM.

d. Pelatihan Guru dan Tenaga Kesehatan

Melatih guru dan tenaga kesehatan mengenai MKM memungkinkan mereka untuk memberikan informasi yang akurat dan dukungan yang diperlukan kepada remaja perempuan. Hal ini juga membantu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan bebas stigma di sekolah dan komunitas. Studi oleh Dasgupta dan Sarkar (2020) menekankan pentingnya peran tenaga pendidik dan kesehatan dalam edukasi MKM.

e. Kampanye Publik dan Advokasi

Melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya MKM dan menghapus stigma terkait menstruasi dapat

menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi remaja perempuan. Advokasi kepada pembuat kebijakan untuk memasukkan MKM dalam agenda kesehatan dan pendidikan nasional juga penting. Penelitian oleh Anjum et al. (2019) menyoroti efektivitas kampanye publik dalam mengatasi stigma menstruasi.

3. Pendekatan Holistik

a. Integrasi Edukasi Menstruasi ke dalam Kurikulum Sekolah

Edukasi menstruasi yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah merupakan langkah strategis untuk memastikan remaja mendapatkan informasi yang benar dan komprehensif sejak dini. Pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah tidak hanya membahas aspek biologis menstruasi tetapi juga melibatkan aspek sosial, psikologis, dan praktis manajemen menstruasi.

Menurut UNICEF (2019), pendidikan kesehatan reproduksi yang mencakup edukasi menstruasi dapat membantu remaja memahami proses biologis tubuh mereka, mempersiapkan mereka menghadapi menarche, dan mengurangi kecemasan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Sommer et al. (2016) menunjukkan bahwa sekolah merupakan platform ideal untuk menyampaikan informasi terkait menstruasi karena menjangkau populasi remaja yang luas, termasuk yang berasal dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi.

Dalam penerapan kurikulum ini, penting untuk: 1) Mengintegrasikan materi ke pelajaran wajib: Topik menstruasi dapat dimasukkan dalam pelajaran biologi atau pendidikan jasmani untuk memastikan cakupan luas, 2) Menyusun Modul yang Sensitif Gender, yaitu materi harus disusun agar sesuai dengan usia, budaya, dan kebutuhan remaja, serta mempertimbangkan sensitivitas gender, dan 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan: pemerintah dan pihak sekolah perlu memantau efektivitas program melalui survei siswa, guru, dan orang tua.

b. Pelatihan Guru, Tenaga Kesehatan, dan Orang Tua

Guru, tenaga kesehatan, dan orang tua memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan kesehatan reproduksi. Pelatihan khusus bagi mereka diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada remaja akurat dan tidak memperkuat stigma atau mitos. Guru sebagai pendidik utama di sekolah perlu dilatih untuk mengajarkan topik menstruasi dengan percaya diri. Penelitian Dasgupta dan Sarkar (2020) menyebutkan bahwa guru yang mendapatkan pelatihan cenderung lebih mampu menjelaskan informasi tentang menstruasi dengan cara yang tidak menghakimi dan lebih sensitif. Tenaga kesehatan dapat dilibatkan dalam memberikan seminar di sekolah, menyediakan layanan konseling, dan memastikan akses terhadap produk menstruasi. Edukasi kepada

orang tua juga penting untuk memastikan mereka mendukung remaja perempuan di rumah. Mereka juga perlu dilibatkan dalam kampanye untuk mengatasi stigma dan mitos menstruasi di lingkungan keluarga.

4. Penguatan Psikososial

- a. Mendukung rasa percaya diri dan kenyamanan remaja perempuan selama menstruasi

Menstruasi sering kali disertai dengan perubahan emosional yang dapat memengaruhi kepercayaan diri remaja perempuan. Faktor seperti stigma, mitos, dan rasa malu dapat menurunkan harga diri mereka. Oleh karena itu, pendekatan psikososial yang berpusat pada remaja sangat penting, meliputi:

- 1) Pemberdayaan Remaja Perempuan

Menurut Sommer et al. (2016), program pemberdayaan yang melibatkan diskusi kelompok, pelatihan keterampilan hidup, dan konseling dapat membantu remaja membangun rasa percaya diri selama menstruasi.

- 2) Penyediaan Ruang Aman

Sekolah dan komunitas perlu menyediakan ruang aman bagi remaja perempuan untuk berbicara tentang menstruasi tanpa rasa malu. Program seperti kelompok diskusi atau dukungan sebaya dapat mendorong remaja berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain (UNICEF, 2019).

- b. Melibatkan Laki-Laki Remaja dalam Edukasi Menstruasi untuk Mengurangi Stigma Gender

Melibatkan laki-laki remaja dalam edukasi menstruasi adalah langkah penting untuk mengurangi stigma yang sering dikaitkan dengan menstruasi. Banyak laki-laki remaja yang tidak memahami proses menstruasi karena mereka tidak pernah diajarkan, yang sering kali memperkuat mitos dan diskriminasi terhadap perempuan. Pendidikan yang melibatkan laki-laki remaja dapat memberikan mereka pemahaman tentang menstruasi sebagai proses biologis yang alami. Hal ini dapat mengurangi sikap diskriminatif dan meningkatkan dukungan mereka terhadap perempuan (Dasgupta & Sarkar, 2020). Selain itu, kampanye di sekolah dan komunitas yang melibatkan laki-laki remaja sebagai agen perubahan dapat membantu mematahkan stigma sosial. Misalnya, program di beberapa sekolah di Kenya yang melibatkan laki-laki sebagai "champion of change" menunjukkan hasil positif dalam mengubah pandangan dan sikap mereka terhadap menstruasi (Sommer et al., 2016).

Edukasi tentang menstruasi memberikan remaja alat untuk mengelola proses ini dengan percaya diri dan sehat. Melalui edukasi yang komprehensif, stigma dapat dikurangi, dan kesehatan remaja perempuan dapat ditingkatkan.

Selain itu, pendekatan tersebut juga berkontribusi pada penguatan hak perempuan dan kesetaraan gender.

D. Pengelolaan Masalah Reproduksi pada Remaja

1. Masalah Umum pada Kesehatan Reproduksi Remaja

Remaja perempuan menghadapi berbagai masalah kesehatan reproduksi yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka. Beberapa masalah yang paling sering dijumpai adalah dismenore, sindrom pramenstruasi (PMS), dan menstruasi tidak teratur. Masalah-masalah ini sering kali tidak mendapat perhatian yang memadai karena stigma, kurangnya edukasi, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk membantu remaja mengelola kondisi ini secara optimal.

a. Dismenore (Nyeri Haid)

Dismenore adalah nyeri haid yang terjadi akibat kontraksi uterus, biasanya dipicu oleh peningkatan kadar prostaglandin selama menstruasi. Kondisi ini diklasifikasikan menjadi:

1) Dismenore Primer

Dismenore primer adalah nyeri menstruasi yang tidak terkait dengan kelainan struktural pada organ reproduksi. Biasanya dimulai beberapa tahun setelah menarche, ketika siklus ovulasi mulai teratur. Nyeri umumnya dirasakan di perut bagian bawah dan dapat menjalar ke punggung bawah atau paha. Dismenore primer sering disertai gejala lain seperti mual, muntah, dan sakit kepala (Jamieson, 2015).

2) Dismenore Sekunder

Dismenore sekunder disebabkan oleh kondisi medis tertentu, seperti endometriosis, fibroid rahim, atau penyakit radang panggul. Kondisi ini umumnya terjadi pada perempuan yang lebih tua atau memiliki riwayat gangguan ginekologis (FIGO, 2021).

Penanganan dismenore primer sering kali melibatkan penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID), seperti ibuprofen atau naproxen, yang bekerja dengan menghambat produksi prostaglandin. Kombinasi kontrasepsi oral (COC) juga efektif dalam mengurangi intensitas nyeri dengan menghambat ovulasi dan menurunkan produksi prostaglandin (Jamieson, 2015). Studi yang dilakukan oleh FIGO (2021) merekomendasikan penanganan dismenore sekunder dengan pendekatan yang lebih kompleks, termasuk terapi hormon atau pembedahan, tergantung pada penyebab yang mendasari. Pada terapi suportif, pemenuhan nutrisi disarankan remaja mengonsumsi makanan tinggi antioksidan, seperti buah beri dan teh hijau, dapat membantu

mengurangi peradangan yang berkontribusi pada nyeri menstruasi. Omega-3 yang ditemukan dalam ikan berlemak, seperti salmon, juga memiliki efek antiinflamasi yang dapat mengurangi nyeri dismenore (Ghorbani et al., 2021). Magnesium memiliki peran dalam mengurangi nyeri menstruasi dengan menekan kontraksi otot yang disebabkan oleh prostaglandin. Studi oleh Abbasi et al. (2019) menunjukkan bahwa suplementasi magnesium dapat secara signifikan mengurangi intensitas nyeri dismenore. Sumber makanan kaya magnesium meliputi kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran hijau.

b. Sindrom Premenstruasi / *Pre Menstrual Syndrome* (PMS)

Sindrom premenstruasi adalah kumpulan gejala fisik, emosional, dan perilaku yang terjadi pada fase luteal akhir siklus menstruasi dan hilang dengan dimulainya menstruasi. Gejala umum meliputi: Nyeri payudara, Kembung, Gangguan tidur, Perubahan suasana hati, seperti mudah marah atau depresi. Menurut American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), sekitar 20-30% perempuan mengalami PMS dengan tingkat keparahan yang memengaruhi aktivitas sehari-hari (ACOG, 2015).

Beberapa pendekatan untuk menangani PMS yaitu:

1) Perubahan Gaya Hidup

Pola makan sehat yang kaya karbohidrat kompleks, serat, dan protein dapat membantu mengurangi gejala. Diet rendah gula dan tinggi serat dapat membantu mengatur kadar gula darah dan mencegah perubahan suasana hati yang sering terjadi selama PMS. Menurut Balik et al. (2017), suplementasi vitamin B6 juga dapat membantu mengurangi gejala emosional PMS, seperti kecemasan dan depresi. Vitamin B6 membantu mengatur neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, yang dapat memengaruhi suasana hati selama PMS. Makanan yang kaya vitamin B6 meliputi pisang, kentang, dan ikan tuna. Konsumsi kalsium dan vitamin D juga dapat membantu mengurangi gejala fisik dan emosional PMS. Sebuah studi oleh Shobeiri et al. (2017) menemukan bahwa perempuan yang mengonsumsi kalsium dalam jumlah yang cukup memiliki risiko lebih rendah mengalami nyeri dan gangguan suasana hati selama menstruasi. Sumber kalsium termasuk susu, keju, dan sayuran hijau. Menghindari kafein dan alkohol juga disarankan, karena kedua zat ini dapat memperburuk gejala kecemasan dan insomnia. Latihan fisik secara teratur juga terbukti meningkatkan suasana hati dan mengurangi kembung.

2) Suplementasi

Suplementasi vitamin B6, magnesium, dan kalsium telah menunjukkan manfaat dalam mengurangi gejala PMS (Jamieson, 2015).

3) Pengobatan

Untuk kasus PMS yang berat, antidepresan golongan *Selective Serotonin Reuptake Inhibitors* (SSRI) dapat digunakan untuk mengurangi gejala emosional dan fisik.

4) Dukungan Psikologis:

Konseling dan terapi perilaku kognitif (CBT) dapat membantu remaja mengelola stres dan meningkatkan kesehatan mental.

c. Menstruasi Tidak Teratur

Ketidakteraturan menstruasi adalah hal yang umum terjadi pada remaja, terutama dalam 2-3 tahun pertama setelah *menarche*. Hal ini disebabkan oleh imaturitas sumbu hipotalamus-hipofisis-ovarium, yang mengakibatkan ovulasi yang tidak teratur. Namun, menstruasi tidak teratur juga dapat menjadi indikasi gangguan lain, seperti:

- 1) Sindrom Ovarium Polikistik (PCOS) yaitu ditandai dengan siklus menstruasi yang jarang, hiperandrogenisme, dan ovarium polikistik pada ultrasonografi. PCOS sering dikaitkan dengan resistensi insulin dan obesitas (Jamieson, 2015).
- 2) Gangguan Tiroid meliputi hipotiroidisme atau hipertiroidisme dapat menyebabkan gangguan siklus menstruasi.

Dalam mengelola masalah menstruasi tidak teratur dilakukan beberapa tatalaksana berikut:

1) Pengobatan Hormon

Pemberian kombinasi kontrasepsi oral sering digunakan untuk mengatur siklus menstruasi dan mengurangi gejala terkait, seperti jerawat atau pertumbuhan rambut berlebih pada PCOS.

2) Modifikasi Gaya Hidup

Untuk remaja dengan PCOS, perubahan gaya hidup seperti olahraga teratur dan pola makan sehat dapat membantu mengelola gejala.

3) Diagnosis dan Perawatan Penyebab yang Mendasari

Pemeriksaan lebih lanjut seperti tes kadar hormon atau ultrasonografi diperlukan untuk menentukan penyebab ketidakteraturan dan menentukan intervensi yang sesuai (FIGO, 2021).

2. Pendekatan Holistik dalam Pengelolaan Masalah Reproduksi pada Remaja

Pengelolaan masalah reproduksi pada remaja membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup aspek medis, psikologis, dan edukasi. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk mengobati gejala tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, membantu remaja memahami perubahan

dalam tubuh mereka, dan mendorong keputusan yang sehat terkait kesehatan reproduksi.

a. Pendekatan Medis

1) Pemeriksaan Klinis dan Diagnosis

Pemeriksaan fisik dan riwayat menstruasi adalah langkah awal yang penting untuk mengevaluasi masalah reproduksi remaja. Pencatatan rinci tentang durasi, intensitas, dan pola menstruasi dapat membantu mendeteksi kelainan seperti dismenore, sindrom ovarium polikistik (PCOS), atau amenore (Jamieson, 2015). Pemeriksaan laboratorium, seperti kadar hormon tiroid, prolaktin, dan ultrasonografi, juga sering diperlukan untuk menegaskan diagnosis dan menentukan penyebab masalah. Menurut FIGO (2021), pemeriksaan diagnostik pada remaja harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan emosional mereka, mengingat stigma dan kecemasan yang sering terkait dengan masalah reproduksi.

2) Terapi Farmakologis

Terapi medis memainkan peran utama dalam pengelolaan masalah reproduksi. Pemberian obat-obatan seperti: NSAID (*Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs*) untuk mengurangi nyeri dismenore dengan menekan produksi prostaglandin yang menyebabkan kontraksi uterus (Jamieson, 2015); kombinasi kontrasepsi oral (COC) yang efektif dalam mengatur siklus menstruasi, mengurangi gejala PMS, dan menurunkan risiko hiperplasia endometrium pada remaja dengan menstruasi tidak teratur (ACOG, 2015); serta terapi hormon lainnya, yaitu pada kasus yang lebih kompleks, misal PCOS, dapat digunakan untuk mengelola ketidakseimbangan hormonal.

3) Rujukan ke Spesialis

Jika masalah tidak dapat diatasi dengan terapi awal, remaja perlu dirujuk ke spesialis ginekologi atau endokrinologi remaja. FIGO (2021) merekomendasikan agar dokter spesialis memberikan pendekatan multidisiplin yang melibatkan ahli gizi, psikolog, dan konselor untuk mendukung kebutuhan remaja secara menyeluruh.

b. Pendekatan Psikologis

1) Konseling Remaja

Konseling adalah bagian penting dari pendekatan holistik, yang membantu remaja memahami perubahan tubuh mereka dan mengatasi kecemasan yang mungkin timbul. Menurut WHO (2018), konseling yang ramah remaja harus dilakukan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari stigma. Konseling juga membantu remaja mengembangkan keterampilan

manajemen stres, terutama bagi mereka yang mengalami gangguan seperti PMS berat atau dismenore kronis. Dukungan emosional ini dapat mengurangi rasa takut dan memperbaiki kualitas hidup mereka (Jamieson, 2015).

2) Dukungan Keluarga

Peran keluarga sangat penting dalam pengelolaan masalah reproduksi. Edukasi kepada orang tua tentang kondisi kesehatan reproduksi remaja dapat meningkatkan dukungan mereka dalam membantu anak-anak mereka menjalani perubahan hormonal dengan lebih percaya diri (FIGO, 2021).

c. Edukasi

Edukasi dapat diberikan melalui pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah dan penyediaan informasi yang akurat. Mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum sekolah adalah langkah penting untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang menstruasi, kebersihan, dan risiko kesehatan reproduksi lainnya. Menurut UNICEF (2019), program ini harus mencakup informasi tentang anatomi tubuh, siklus menstruasi, dan pentingnya menjaga kebersihan menstruasi. Studi menunjukkan bahwa pendidikan yang komprehensif dapat membantu remaja perempuan memahami tubuh mereka dengan lebih baik dan mengurangi risiko penyakit reproduksi (Sommer et al., 2016). Selain itu, remaja membutuhkan akses ke informasi berbasis bukti yang sesuai usia dan budaya. Informasi ini dapat disampaikan melalui program sekolah, media sosial, atau klinik kesehatan remaja. WHO (2018) merekomendasikan penyediaan materi edukasi yang ramah remaja dan dapat diakses dengan mudah untuk mengurangi hambatan terhadap informasi.

3. Pencegahan Penyakit Menular Seksual dan Kehamilan Tidak Diinginkan

Remaja adalah kelompok usia yang sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi, termasuk penyakit menular seksual (PMS) dan kehamilan tidak diinginkan. Faktor-faktor seperti kurangnya edukasi seksual, akses terbatas terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan pengaruh sosial budaya sering memperburuk risiko ini. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan yang holistik sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini, antara lain:

a. Edukasi Seksual Komprehensif

Edukasi seksual adalah langkah fundamental dalam pencegahan. Pendidikan yang komprehensif tidak hanya memberikan informasi tentang risiko PMS dan kehamilan tidak diinginkan, tetapi juga mengajarkan keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan, dan negosiasi yang diperlukan untuk hubungan yang sehat. Edukasi seksual yang mencakup anatomi reproduksi, risiko penyakit

menular seksual (PMS), dan pentingnya kontrasepsi dapat membantu remaja membuat keputusan yang lebih baik terkait kesehatan reproduksi mereka. Sebuah meta-analisis oleh UNESCO (2018) menemukan bahwa program edukasi seksual di sekolah efektif dalam mengurangi risiko perilaku seksual berisiko dan meningkatkan penggunaan kondom di kalangan remaja. Menurut Jamieson (2015), pendekatan ini harus dimulai sejak dini untuk mengurangi risiko kehamilan tidak diinginkan dan penularan PMS.

b. Akses ke Layanan Kesehatan Reproduksi

Layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja memainkan peran penting dalam pencegahan dan pengelolaan masalah reproduksi. Layanan ini harus menyediakan konseling, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan untuk PMS, dan akses ke kontrasepsi termasuk kondom, pil KB, dan kontrasepsi darurat. WHO (2018) menekankan bahwa layanan ini harus bebas dari stigma, mudah diakses, dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan remaja. Studi di Kenya menunjukkan bahwa klinik ramah remaja yang menawarkan layanan ini berhasil meningkatkan akses dan kepuasan remaja terhadap kesehatan reproduksi mereka (Sommer et al., 2016)

c. Distribusi Alat Kontrasepsi

Penyediaan alat kontrasepsi seperti kondom, pil kontrasepsi, dan kontrasepsi darurat dapat membantu mengurangi risiko kehamilan tidak diinginkan dan penularan PMS. Kondom tidak hanya mencegah kehamilan tetapi juga melindungi terhadap sebagian besar PMS, termasuk HIV/AIDS. Menurut UNAIDS (2020), peningkatan penggunaan kondom di kalangan remaja dapat menurunkan prevalensi HIV sebesar 30% dalam satu dekade. Distribusi alat ini harus disertai dengan edukasi tentang penggunaan yang benar untuk memastikan efektivitasnya (FIGO, 2021).

d. Kampanye Kesadaran Publik

Kampanye berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat, media, dan remaja dapat mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan seksual.

E. Kesimpulan

Kesehatan reproduksi remaja merupakan fondasi penting bagi kesehatan jangka panjang dan kesejahteraan individu. Pemahaman yang komprehensif tentang perubahan fisik, psikologis, dan sosial selama pubertas, serta dukungan yang memadai untuk mengatasi tantangan budaya dan stigma, sangat krusial. Melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan manajemen medis, dukungan

psikologis, dan edukasi kesehatan, kita dapat membantu remaja perempuan mengelola menstruasi dan masalah reproduksi lainnya dengan lebih baik.

Program edukasi menstruasi yang efektif, yang melibatkan kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berbasis komunitas, telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap remaja terhadap menstruasi. Dengan memberdayakan remaja perempuan, melibatkan laki-laki remaja, dan menciptakan lingkungan yang mendukung, dapat mengatasi stigma seputar menstruasi dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.

Sebagai kesimpulan, investasi dalam kesehatan reproduksi remaja adalah investasi pada masa depan. Dengan menyediakan layanan kesehatan yang ramah remaja, mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum sekolah, dan meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, dapat membantu remaja mencapai potensi optimal dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap kesehatan reproduksi remaja tidak hanya penting untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan.

F. Referensi

- Abbasi, B., Koushkie Jahromi, M., Keshavarzian, H., & Fakheri, G. (2019). The effect of magnesium supplementation on primary dysmenorrhea: A randomized clinical trial. *Gynecological Endocrinology*, 35(1), 12–16.
- Agarwal, A., Mishra, S., & Verma, M. (2020). Iron deficiency and anemia in adolescents: Assessment and treatment. *Journal of Pediatric Hematology/Oncology*, 42(7), 533–538.
- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2015). *Menstruation in Girls and Adolescents: Using the Menstrual Cycle as a Vital Sign. Committee Opinion No. 651*. *Obstet Gynecol*, 126(6), e143–146. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000001215>
- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2015). Premenstrual Syndrome (PMS). ACOG Practice Bulletin.
- American Academy of Pediatrics. (2018). Health Care for Adolescents and Young Adults.
- Anjum, Z., Pouramin, P., Glickman, T., & Nagabhatla, N. (2019). A Synthesis Report Analyzing Menstrual Hygiene Management Within a Humanitarian Crisis. *OIDA International Journal of Sustainable Development*.
- Balik, G., Ustüner, I., Kağıtçı, M., & Sahin, F. K. (2017). The association between premenstrual syndrome and vitamin B6 levels. *Gynecological Endocrinology*, 33(8), 624–628.

- BPS. (2020). Laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017.
- Dasgupta, A., & Sarkar, M. (2020). Menstrual hygiene: How hygienic is the adolescent girl? *Indian Journal of Community Medicine*, 33(2), 77-80.
- FIGO. (2021). Adolescent Reproductive Health and Menstrual Disorders: FIGO Guidelines. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 152(1), 1-8.
- Ghorbani, Z., Shariati-Bafghi, S. E., & Heydari, S. T. (2021). Omega-3 fatty acids and their role in menstrual health: A review. *International Journal of Reproductive BioMedicine*, 19(5), 425–432.
- Jamieson, M. A. (2015). Disorders of Menstruation in Adolescent Girls. *Pediatric Clinics of North America*, 62(4), 855-871.
- Shobeiri, F., Arasteh, F., & Nazari, M. (2017). The effect of calcium on premenstrual syndrome and dysmenorrhea. *Obstetrics and Gynecology International*, 2017, 4690417. <https://doi.org/10.1155/2017/4690417>
- Sommer, M., Caruso, B. A., Sahin, M., Calderon, T., Cavill, S., & Mahon, T. (2016). A Time for Global Action: Addressing Girls' Menstrual Hygiene Management Needs in Schools. *PLOS Medicine*, 13(2), e1001962. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001962>
- UNAIDS. (2020). *Global HIV & AIDS Statistics — Fact Sheet*.
- UNESCO. (2018). *International Technical Guidance on Sexuality Education*.
- UNICEF. (2019). *Guidance on Menstrual Health and Hygiene*. UNICEF Programme Division.
- United Nations Population Fund. (2019). *Sexual and Reproductive Health for Adolescents*.
- WHO. (2018). *Recommendations on Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights*. WHO Publications.
- WHO & UNICEF. (2018). *Joint Monitoring Programme for Drinking Water, Sanitation, and Hygiene*.
- World Health Organization. (2020). *Adolescent Health*.
- World Health Organization (WHO). (2019). *Nutritional Anemia: Tools for Effective Prevention and Control*. WHO Publications.

G. Glosarium

MKM = Manajemen Kebersihan Menstruasi

CHAPTER 4

PERAWATAN KESEHATAN SESKUAL WANITA

Januar Dwi Christy, SST., Bd., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Upaya perawatan Kesehatan seksual Wanita, terutama Pencegahan penyakit menular seksual dan Edukasi Kontrasepsi sangatlah penting , di jaman yang semakin maju , di era globalisasi dan era pasca pandemic covid 19,

Menurut hasil penelitian yang dilakukan, pada tahun 2020 terdapat sedikitnya 600 Wanita Pekerja Seks (WPS) yang bekerja pada lokasi di Kabupaten Batang dengan 80% diantaranya terinfeksi penyakit infeksi Menular Seksual , sedangkan berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang kasus penularan penyakit IMS di Kabupaten Batang khususnya HIV/AIDS terus naik di setiap tahunnya. Di tahun 2020 di bulan Mei tercatat 1.200 kasus HIV/AIDS ditemukan 67 kasus antara bulan Januari sampai Mei (berita.batang.go.id,2020).

Pandemic Covid-19 di tahun 2020-2022 tidak hanya berdampak terhadap perubahan arah kebijakan pemerintahan pada sektor Kesehatan saja namun merubah kehidupan dan kebiasaan masyarakat khususnya dalam aspek sosial, bahkan yang lebih miris mengakibatkan disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial merupakan suatu proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dalam tatanan struktur masyarakat yang terjadi karena adanya perubahan dalam kehidupan (Soerjono Soekanto,1982).

Salah satu yang menyebabkan angka kejadian semakin melonjak dengan pesat adalah kurangnya pengetahuan dan edukasi terlebih pada saat di berlakukannya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sehingga membuat masyarakat kurang mendapatkan edukasi karena keterbatasan sumber informasi digital tentang permasalahan penyakit menular seksual , edukasi pencegahan HIV/AIDS yang biasa dilakukan oleh tenaga Kesehatan adalah secara masal.

Dengan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, membuat dunia Kesehatan harus mengikuti perkembangan dan mengikuti tren isu yang sedang terjadi,

B. Memelihara Kesehatan Reproduksi

Untuk tetap menjaga organ reproduksi banyak hal yang harus diperhatikan antara lain gaya hidup sehat, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan rutin berolahraga, makanan dan minuman baik untuk menjaga kesehatan organ reproduksi adalah :

1. Ikan , terutama ikan tengiri dan salmon yang mengandung asam lemak omega - 3 dan protein lain yang baik untuk Kesehatan reproduksi.
2. Telur, Telur kaya protein, vitamin D, lemak sehat dan kolin.
3. Kacang-kacangan
4. Buah – buahan
5. Sayuran
6. Susu dan produk Olahannya

Senyawa makanan dan kesuburan Wanita.

Karbohidrat

Sensitivitas insulin maupun metabolisme glukosa dapat memengaruhi ovulasi dan kesuburan Wanita secara signifikan. Dalam hal karbohidrat, indeks glikemik dan beban sangat penting.

Insulin mengatur metabolisme tetapi juga fungsi reproduksi; insulin dapat memodulasi steroidogenesis ovarium serta hyperinsulinemia yang berkorelasi positif dengan hiperandrogenisme dan gangguan ovulasi. Insulin juga merupakan pengatur utama produksi sex hormone-binding globulin (SHBG) di antara Wanita dengan sindrom ovarium polikistik (PCOS). (Skoracka et al., 2021)

Berdasarkan penelitian (Skoracka et al., 2021) menyarankan bahwa omega 3 FA memperpanjang umur reproduksi. Dan menunjukkan bahwa konsumsi ikan, merupakan sumber omega 3 FA yang baik, dikaitkan dengan kemungkinan kelahiran hidup yang lebih tinggi.

Peningkatan asupan protein dapat meningkatkan keseimbangan karbohidrat-insulin, yang tampaknya penting dalam mengobati infertilitas akibat kurangnya ovulasi. Pentingnya untuk diperhatikan bahwa protein memiliki sifat mengenyangkan tertinggi, memengaruhi termogenesis yang diinduksi oleh diet dan massa otot (Skoracka et al., 2021)

C. Cara pencegahan penyakit menular seksual.

Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah infeksi yang menular melalui hubungan seksual, seperti sperma, darah, dan cairan vagina. PMS dapat memengaruhi Kesehatan fisik, emosional, dan sosial pada penderita.

Penyakit menular seksual yang berbahaya dan dapat disebabkan komplikasi serius adalah HIV/AIDS, Kutil Kelamin, dan klamidia. Kondisi ini terjadi akibat perilaku seks yang tidak aman, baik vaginal, oral dan anal.

Penyebab penyakit menular seksual terjadi karena sering bergantian lebih dari satu pasangan. PMS menyerang sekitar alat kelamin tapi gejalanya dapat muncul dan menyerang mata, mulut, saluran pencernaan, hati, otak, dan organ tubuh lainnya.

PMS merupakan penyakit yang penularannya secara langsung maupun tidak langsung hal ini dapat diartikan penularan langsung yaitu penularan melalui kontak fisik (seksual dan French kissing) dan penularan tidak langsung melalui transfusi darah, makanan dan alat suntik.

Penyakit dapat menyebabkan infeksi alat reproduksi yang dianggap serius. Bila tidak di obati secara tepat , infeksi ini dapat menjalar dan menyebabkan penderitaan, sakit berkepanjangan, kemandulan dan bahkan kematian. Wanita lebih beresiko untuk terkena PMS lebih besar dari pada laki-laki sebab mempunyai alat reproduksi yang lebih rentan, dan seringkali berakibat lebih parah karena gejala awal tidak segera dikenali, sedangkan penyakit melanjut ke tahap lebih parah. Oleh karena letak dan bentuk kelaminnya menonjol , gejala pada laki-laki lebih mudah dikenali, dilihat dan dirasakan, sedangkan pada perempuan Sebagian besar gejala yang timbul hamper tidak dirasakan.

D. Tanda dan gejala PMS

Gejala PMS pada laki-laki antara lain. :

1. Berupa bintil-bintil berisi cairan
2. Lecet atau borok pada penis
3. Luka tidak sakit
4. Keras dan berwarna merah pada kelamin,
5. Adanya kutil atau tumbuh daging seperti jengger ayam.
6. Rasa gatal yang hebat sepanjang alat kelamin,
7. Rasa sakit yang hebat pada saat kencing,
8. Kencing nanah atau darah yang berbau busuk,
9. Bengkak panas dan nyeri pada pangkal paha yang kemudian berubah.

Gejala PMS pada perempuan Sebagian besar tanpa gejala sehingga sering kali tidak disadari. Jika ada gejala, berupa :

1. Rasa sakit atau nyeri pada saat kencing atau berhubungan seksual.
2. Rasa nyeri pada perut bagian bawah,
3. Pengeluaran lendir pada vagina / alat kelamin.

4. Keputihan berwarna putih susu,bergumpal dan disertai gatal dan kemerahan pada alat kelamin atau sekitarnya,
5. Keputihan yang berbusa, kehijauan, berbau busuk, dan gatal.
6. Timbulnya bercak-bercak darah setelah berhubungan seksual.
7. Bintil -bintil berisi cairan,
8. Lecet atau borok pada alat kelamin.

E. Faktor – faktor resiko bisa terkena PMS.

1. Seks tanpa pelindung

Penggunaan kondom merupakan cara terbaik untuk menghindarkan anda dari infeksi.

2. Berganti-ganti pasangan

Berganti-ganti pasangan menjadi penularan paling beresiko , dikarenakan orang yang suka berganti pasangan cenderung memilih pasangan yang suka berganti pasangan pula.

3. Mulai aktif secara seksual sejak dini

Kaum muda lebih besar kemungkinannya untuk terkena PMS daripada orang yang lebih tua. Ada beberapa alasannya, yaitu Wanita muda khususnya lebih rentan terhadap PMS karena tubuh mereka lebih kecil dan belum berkembang sempurna sehingga lebih mudah terinfeksi.

4. Mengonsumsi alkohol dan obat.

Konsumsi alkohol dapat berpengaruh terhadap Kesehatan seksual, dikarenakan orang yang biasa minum alcohol bisa kurang selektif memilih pasangan seksual dan menurunkan Batasan. Pemakaian obat terlarang juga memudahkan orang lain memaksa seseorang tanpa sadar melakukan perilaku seksual yang jika dalam keadaan sadar tidak akan dilakukan .

Penggunaan jarum suntik secara bergantian juga merupakan penularan yang sangat beresiko, dikarenakan jarum suntik mempunyai ruang hampa udara yang membuat virus HIV / AIDS dapat hidup, begitu pula dengan virus dan bakteri yang dapat menyebabkan PMS.

F. Penyakit Menular Seksual Gonorea.

Gonorea merupakan semua penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Neisseria gonorrhoeae* yang bersifat purulen dan dapat menyerang permukaan mukosa manapun di Tubuh manusia.

Etiologi gonorea adalah infeksi menular seksual pada epitel dan umumnya bermanifestasi sebagai cervicitis, urethritis, proctitis dan conjungtivitis. Bila tidak diterapi, infeksi ini dapat menimbulkan komplikasi lokal seperti endometritis,

salpingitis, TOA, bartolinis perihepatitis dan periuretritis dan epididimistis pada pasien pria, dan oftalmia neonatorum pada neonatus.

Penyebab dari Gonorea adalah kuman *Neisseria gonorrhoeae*, adalah kuman gram negative bentuk diplokokus yang merupakan penyebab infeksi saluran urogenitalis.

Perantara dari kuman ini adalah manusia, tempat kuman keluar berasal dari penis, vagina, anus, mulut, cara penularan dari penyakit ini adalah dengan kontak seksual secara langsung.

Kuman ini bersifat fastidious dan untuk tumbuhnya perlu media yang lengkap serta baik. Akan tetapi ia juga rentan terhadap kepanasan dan kekeringan sehingga tidak dapat bertahan hidup lama di luar hostnya.

Penularan umumnya secara kontak seksual dan masa inkubasi terjadi sekitar 2-5 hari. Pada pria awalnya terdapat rasa gatal dan panas di sekitar uretra, saluran yang menghantarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Selanjutnya terdapat rasa nyeri saat buang air kecil dan keluar secret kental dan keruh. Selain itu terdapat nyeri pada waktu ereksi dan terkadang terdapat pembesaran kelenjar getah bening di selangkangan.

Pada Wanita gejalanya sangat ringan sehingga penderita tidak menyadarinya. Sebanyak 30%-60% Wanita penderita gonore tidak memberikan gejala. Gejala yang timbul saat buang air kecil, menjadi lebih sering dan kadang-kadang menimbulkan rasa nyeri pada panggul bawah. Terdapat pengeluaran sekret kental dan keruh yang keluar dari vagina. Bila menyadari mempunyai gejala-gejala tersebut, segera memeriksakan ke dokter. Jika menderita gonorea, hindari hubungan seksual sampai pengobatan antibiotik selesai.

Penderita gonore dapat terjangkit Kembali walaupun sudah dinyatakan sembuh oleh dokter.

Pencegahan Gonorea;

1. Tidak melakukan hubungan seksual baik vaginal, anal dan oral dengan orang yang terinfeksi.
2. Pemakaian kondom dapat mengurangi tetapi tidak dapat menghilangkan sama sekali resiko penularan penyakit ini.
3. Hindari hubungan seksual sampai pengobatan antibiotik selesai.
4. Sarankan juga pasangan seksual kita untuk diperiksa guna mencegah infeksi lebih jauh dan mencegah penularan.
5. Wanita tuna Susila agar selalu memeriksakan dirinya secara teratur, sehingga jika terkena infeksi dapat segera diobati dengan benar.
6. Pengendalian penyakit menular seksual ini adalah dengan meningkatkan keamanan kontak seks dengan menggunakan upaya pencegahan.

G. Keputihan (Vaginitis)

Pada wanita keputihan bersifat normal dan dapat juga menjadi gejala awal suatu penyakit. Keputihan yang lazim terjadi disaat sebelum menstruasi dan pada saat terjadi ovulasi (masa subur dipertengahan siklus menstruasi). Pada fase ini kadar hormone menyebabkan produksi cairan vagina juga dipengaruhi oleh kondisi stress emosi, status nutrisi, kehamilan, aktivitas seksual, dan siklus menstruasi.

Cairan vagina yang normal/fisiologis berwarna bening dengan konsistensi sedang atau tidak terlalu pekat. Dalam kondisi normal, pada vagina hidup mikroba yang berfungsi untuk melawan invasi dari pathogen asing.

Umumnya microbiota vagina normal terdiri atas kumpulan mikroorganisme aerob maupun anaerob. Namun 90% microbiota vagina itu tersusun atas *lactobacilli*. *Lactobacilli* berperan penting dalam melindungi ekosistem vagina dari serangan pathogen melalui produksi lendir dan senyawa antimikroba seperti asam laktat dan hydrogen peroksida. (Putu Prihandini Utami & Putu Dewi Sri Wahyuni, 2021)

Keputihan yang tidak normal ditandai dengan perubahan volume, warna, bau dan konsistensi dan kadang kala di tambah dengan gejala lain seperti gatal, nyeri saat berkemih, nyeri perut atau kemerahan disekitar vagina.

Pada remaja wanita keputihan yang sering terjadi disebabkan infeksi jamur (Candidiasis). Ditandai dengan rasa gatal di daerah di vagina.

Perubahan pH di aera kewanitaan karena lembab beresiko tinggi terkena infeksi bakteri (Bacterial vaginosis). Perubahan yang terjadi pada pH vagina dapat disebabkan oleh adanya microbiota pathogen yang hidup dan menginfeksi ekosistem vagina, contohnya adalah Bakteri spp dan protozoa parasit T. (Putu Prihandini Utami & Putu Dewi Sri Wahyuni, 2021)

Efek infeksi dari pathogen tersebut dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan rasa sakit serta gangguan fungsi organ tersebut.

50-75 % Wanita akan mengalami vaginitis, satu kali dalam hidupnya. Penyebab utama vaginitis 70% umumnya akibat bakteri *vaginosis*, *candidiasis vulvovaginitis*, dan 15-20% akibat *trichomonas vaginitis* (Putu Prihandini Utami & Putu Dewi Sri Wahyuni, 2021)

Didalam vagina wanita yang telah mengalami menopause atau premenopause akan terdapat bakteri *Doderlein lactobacillus* yang berperan sebagai flora dominan dan memiliki kemampuan untuk mengubah glikogen menjadi asam laktat yang kemudai akan menjaga keseimbangan pH vagina. Hidrogen peroksida juga dihasilkan kombinasi keduanya akan membantu menekan potensi infeksi vagina akibat pathogen lain.

Selain itu faktor lain yang dapat mempengaruhi keparahan gejala genital adalah Wanita yang tidak pernah melahirkan secara normal.

Wanita yang tidak pernah melahirkan melalui pervaginam cenderung lebih beresiko dibandingkan dengan Wanita yang telah mengalami peregangan vulvovaginal. (Putu Prihandini Utami & Putu Dewi Sri Wahyuni, 2021)

H. Kutil kelamin (Kondiloma Akuminata)

Kondiloma Akuminata merupakan salah satu bentuk IMS yang disebabkan oleh Human papilloma virus (*HPV*). Kelainan ini berupa kutil di sekitar alat kelamin, bahkan sampai bagian liang vagina dan leher Rahim.

Kelainan berupa tonjolan kulit berbentuk jengger ayam yang berwarna seperti kulit, ukurannya bervariasi.

Penyebab Kutil Kelamin terjadi melalui :

1. Hubungan seksual, baik melalui vagina, mulut atau dubur.
2. Kontak langsung dari kulit ke kulit misalnya bila penderita kutil kelamin menyentuh kelaminnya sendiri, lalu menyentuh kelamin pasangannya.
3. Berbagi penggunaan alat bantu seks (*Sex toys*) dengan penderita kutil kelamin.
4. Walaupun jarang terjadi , kutil kelamin juga dapat menular ke bayi dari ibu yang terinfeksi virus.
5. Penyakit ini tidak menular melalui ciuman, pertukaran alat makan, handuk dan toilet duduk.

Faktor-faktor yang meningkatkan resiko seseorang terkena kutil kelamin, yaitu:

1. Sedang hamil.
2. Merokok , alcoholic
3. Memiliki daya tahan tubuh lemah, misalnya karena menderita HIV/AIDS atau menggunakan obat-obatan tertentu.
4. Aktif berhubungan sejak dini.
5. Pernah menderita infeksi menular seksual jenis lainnya.

Gejala Kutil Kelamin.

1. Rasa gatal , rasa tidak nyaman pada alat genetalia
2. Sensasi seperti terbakar.
3. Nyeri dan perdarahan saat berhubungan intim.
4. Kutil kelamin berukuran kecil dengan warna serupa kulit atau sedikit lebih gelap sehingga terkadang sulit terlihat langsung.
5. Kutil kelamin dapat tumbuh tunggal, atau berkelompok seperti kembang kol.

Pada Wanita kutil kelamin tumbuh :

1. Dinding vagina
2. Bagian luar vagina (vulva)

3. Bagian diantara vagina dan anus (perineum)
4. Didalam vagina atau didalam anus.
5. Leher Rahim (serviks)

Pada pria, kutil kelamin dapat tumbuh :

1. Batang atau ujung penis
2. Kantung buah zakar (skrotum)
3. Selangkangan
4. Paha bagian atas
5. Sekitar atau didalam anus

Selain pada alat kelamin, kutil kelamin juga bisa tumbuh di lidah, bibir, mulut, dan tenggorokan. Kondisi ini dapat terjadi karena seks oral dengan penderita kutil kelamin walaupun angka kejadiannya rendah (Arbyn et al., 2018).

Untuk menentukan diagnosis harus dijalankan pemeriksaan lebih lanjut.

1. Pap smear
2. Kolposkopi
3. Tes HPV-DNA

Sebagai Langkah awal penanganan kutil kelamin, dapat dalam bentuk krim atau salep:

1. Asam trikloroasetat, untuk membakar kutil kelamin.
2. Imiquimod, untuk mengatasi kutil kelamin dengan meningkatkan daya tahan tubuh.
3. *Podophylin*, untuk menghancurkan jaringan kutil kelamin.
4. *Sinecatechin*, untuk menangani kutil kelamin di bagian luar, dalam atau sekitar anus.

Operasi dapat dilakukan jika pemberian obat kutil kelamin tidak efektif, atau bila kutil kelamin berukuran besar. Metode operasi untuk mengatasi kutil kelamin meliputi :

1. Eksisi
2. Electrocautery
3. Krioterapi
4. Operasi dengan sinar laser.

Pencegahan penyakit menular seksual ini sama seperti pencegahan pada penyakit menular seksual lainnya. Selain itu dapat dicegah dengan menjalani vaksinasi HPV, Vaksin HPV diberikan 2-3 kali pada orang yang belum aktif secara seksual, yaitu pada usia 10-18 tahun hal ini sudah dibuktikan dengan riset penelitian.

I. *Herpes simplek (HSV)*

Gejalanya seperti terbakar atau gatal dikelamin diikuti timbulnya bintil-bintil berisi air di atas kulit dengan warna dasar kemerahan. Dalam beberapa hari bintil ini akan pecah, menimbulkan luka lecet terbuka dan terasa nyeri.

Terdapat dua macam virus herpes simplex (HSV) yang dapat menyebabkan penyakit ini, yaitu HSV I dan HSV II. Herpes genital lebih kerap terjadi akibat infeksi HSV II, sedangkan HSV I lebih sering mengakibatkan herpes oral yang gejalanya ditemukan pada area bibir dan mulut.

HSV I dan HSV II sama-sama dapat menyebabkan herpes genital ataupun oral. Dari pemeriksaan fisik saja tidak bisa dibedakan herpes yang disebabkan oleh virus HSV I atau HSV II, tetapi terdapat perbedaan diantara kedua virus tersebut. Salah satunya herpes genital akibat infeksi HSV II lebih mungkin terjadi berulang kali.

Herpes genital dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup pasien, terlebih ada kemungkinan gejala gatal dan luka di area genital dapat sering kambuh.

Gejala Herpes Simplek :

Setelah terkena pajanan virus HSV , mungkin tidak ada gejala yang langsung muncul. Gejala dapat muncul dalam hitungan hari, bulan bahkan beberapa tahun kemudian. Gejala herpes genital yang umum ditemukan meliputi :

1. Lenting , lepuh atau luka diarea genital dan sekitarnya, biasanya disertai rasa gatal dan dapat pecah serta mengeluarkan cairan atau darah disertai nyeri.
2. Keropeng yang muncul setelah lepuh pecah.
3. Nyeri dan ketidaknyamanan yang bersumber dari area kelamin, panggul dan paha.
4. Pembengkakan kelenjar getah bening di area kelamin yang disertai rasa nyero.
5. Demam, kelelahan, sakit kepala, dan gejala seperti flu lainnya.
6. Nyeri saat buang air kecil.
7. Keluar cairan dari vagina.(Whitley & Hook, 2022)

Gejala-gejala ini akan timbul Ketika virus herpes simplex yang bernaung di dalam tubuh aktif. Selama dalam kondisi dorman (tidak aktif), gejala tidak akan muncul.

Penyebab herpes genital adalah virus herpes simplex. Penularan terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh atau luka terbuka dari individu yang terinfeksi. Sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko terinfeksi virus herpes simplex meliputi :

1. Kontak seksual tanpa kondom.
2. Memiliki banyak pasangan seksual

3. Sistem imun lemah, misalnya orang yang memiliki gangguan autoimun atau hidup dengan HIV.
4. Ibu hamil yang terinfeksi dapat menularkan bayinya saat proses persalinan dan menyebabkan komplikasi kehamilan.

Cara mendiagnose :

1. Wawancara medis untuk mencari tahu informasi tentang Riwayat Kesehatan dan faktor resiko yang mungkin dialami.
2. Pemeriksaan fisik mencakup pengamatan visual terhadap tanda herpes genital berupa lepuh atau luka di area kelamin.
3. Pemeriksaan reaksi berantai polimerase (PCR) dengan sampel dari cairan luka atau lepuh untuk mengidentifikasi materi genetik virus.
4. Pemeriksaan darah untuk mendeteksi antibody yang diproduksi ketika terjadi infeksi virus.
5. Kultur virus, yakni menumbuhkan virus dari sampel cairan luka pada media khusus untuk menunjang diagnose.

Cara mengatasi

Sampai saat ini belum ada obat yang dapat memusnahkan virus yang dorman (tidak aktif). Obat antivirus, yang meliputi asiklovir, famsiklovir, dan valasiklovir, dapat digunakan untuk :

1. Mempercepat penyembuhan pada saat gejala muncul.
2. Menurunkan frekuensi kambuhnya gejala.
3. Mengurangi tingkat keparahan dan durasi kemunculan gejala.
4. Mencegah terjadinya komplikasi.
5. Meminimalkan resiko menulari pasangan.

Komplikasi yang dapat terjadi walaupun jarang terjadi adalah meningitis atau infeksi selaput otak, yang ditandai dengan demam, sakit kepala dan leher terasa kaku. Resiko komplikasi serius juga dapat terjadi pada ibu hamil, Yaitu bayi lahir premature dan ikut tertular pada saat proses persalinan. Penyandang herpes genital juga lebih rentan mengalami infeksi menular lainnya, terutama Ketika daya tahan tubuh menurun atau system imunnya lemah.(Chatroux et al., 2021)

J. HIV and AIDS

HIV (*Human immunodeficiency virus*) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit.

HIV yang berkembang , tidak tertangani dan menjadi kondisi serius yang disertai dengan penyakit komplikasi lainnya disebut *AIDS*. Pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya.

Penularan HIV terjadi melalui kontak cairan tubuh penderita , seperti darah, cairan vagina, cairan anus, sperma. Untuk air liur dan ASI penularannya relative kecil , HIV tidak menular melalui udara, air keringat, air mata, gigitan nyamuk dan sentuhan fisik, karena Virus HIV akan mati jika terkena udara.

Penularan HIV tidak akan langsung Nampak pada saat terpapar, karena virus HIV menyerah CD4 dan ada Window period (Masa jendela) untuk penularan tersebut, lama masa jendela tergantung dengan keadaan imunitasi orang yang terpapar, jika imunitas tubuhnya bagus maka bisa terdeteksi sampai dengan 4 tahun setelah terpapar.

Pengobatan HIV dan AIDS

Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus menyandang penyakit itu seumur hidupnya dan harus mengkonsumsi obat secara rutin. Pengobatan itu disebut ARV (antiretroviral) yang bekerja mencegah virus HIV berkembang biak

ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4.

Beberapa jenis obat ARV adalah:

1. Dolutegravir.
2. Efavirenz.
3. Etravirine.
4. Nevirapine
5. Lamivudin
6. Zidovudin
7. Emtricitabine-tenofovir.

Selama mengkonsumsi obat ARV dokter akan selalu memonitor viral load dan sel CD4 untuk menilai respons tubuh pasien terhadap pengobatan.

Penghitungan sel CD4 akan dilakukan setiap 3-6 bulan, sedangkan pemeriksaan Viral Load dilakukan sejak awal pengobatan dan dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama masa pengobatan.

K. Referensi

Arbyn, M., Xu, L., Simoens, C., & Martin-Hirsch, P. P. (2018). Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2020(3). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009069.pub3>

- Chatroux, I. C., Hersh, A. R., & Caughey, A. B. (2021). Herpes Simplex Virus Serotyping in Pregnant Women With a History of Genital Herpes and an Outbreak in the Third Trimester of Pregnancy. *Obstetrics & Gynecology*, 137(1), 63–71. <https://doi.org/10.1097/AOG.00000000000004181>
- Putu Prihandini Utami, L., & Putu Dewi Sri Wahyuni, N. (2021). INFEKSI PADA VAGINA (VAGINITIS). In *Ganesha Medicina Journal* (Vol. 1).
- Skoracka, K., Ratajczak, A. E., Rychter, A. M., Dobrowolska, A., & Krela-Kaźmierczak, I. (2021). Female Fertility and the Nutritional Approach: The Most Essential Aspects. In *Advances in Nutrition* (Vol. 12, Issue 6, pp. 2372–2386). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/advances/nmab068>
- Whitley, R. J., & Hook, E. W. (2022). Shedding Patterns of Genital Herpes Simplex Virus Infections. *JAMA*, 328(17), 1710. <https://doi.org/10.1001/jama.2022.18930>

CHAPTER 5

GANGGUAN MENSTRUASI PADA WANITA: DIAGNOSA DAN PENGELOLAAN

Selvy Apriani. SST., M.Biomed.

A. Pendahuluan/Prolog

Gangguan menstruasi merupakan suatu kondisi adanya kelainan atau anomali terkait menstruasi yang dialami termasuk gangguan pada siklus menstruasi, volume dan lama menstruasi serta terkait menstruasi lainnya, seperti siklus menstruasi yang terlalu panjang atau terlalu pendek (Wardani et al., 2022). Gangguan menstruasi yang merupakan keluhan yang dialami oleh sebagian wanita yang berkaitan dengan menstruasi yaitu (Harnani et al., 2019):

1. Kelainan dalam banyaknya darah dan lamanya perdarahan menstruasi

a. Hipermenorea (menoragia)

Hipermenorea (menoragia) adalah perdarahan menstruasi yang terjadi lebih banyak dari normal atau lebih lama dari normal (lebih dari 8 hari)

b. Hipomenorea

Hipomenorea adalah perdarahan menstruasi yang terjadi lebih pendek atau lebih kurang dari biasanya.

2. Kelainan dalam siklus menstruasi

a. Polimenorea

Polimenorea adalah terjadinya siklus menstruasi yang lebih pendek dari biasanya (kurang dari 21 hari)

b. Oligomenorea

Oligomenorea adalah siklus menstruasi yang lebih panjang (lebih dari 35 hari)

c. Amenorea

Amenorea adalah keadaan tidak terjadinya menstruasi untuk sedikitnya 3 bulan berturut-turut

3. Perdarahan di luar menstruasi

Metroragia adalah Perdarahan yang terjadi di luar menstruasi, bersifat bercak dan terjadi terus menerus (perdarahan menstruasi berkepanjangan)

4. Gangguan lain yang ada hubungan dengan menstruasi

a. Dismenorea

Dismenorea adalah kram atau nyeri di perut bagian bawah yang sering disertai dengan berkeringat, takikardia, sakit kepala, mual, muntah, diare dan gemetar, hal ini terjadi beberapa hari sebelum atau selama menstruasi Premenstrual syndrome

b. Premenstrual syndrome adalah

Keluhan yang biasanya mulai satu minggu sampai beberapa hari sebelum datangnya haid, dan menghilang sesudah haid datang atau terkadang dapat berlangsung hingga menstruasi berhenti.

c. Mastalgia

Mastalgia adalah rasa nyeri dan pembesaran pada payudara sebelum haid.

d. Mittelschmerz (rasa nyeri pada ovulasi)Mittelschmerz (rasa nyeri pada ovulasi) adalah nyeri antara haid yang terjadi kira-kira sekitar pertengahan siklus haid (pada saat masa ovulasi).

B. Menoragia (Hiperemenorea)

1. Diagnosa

Anamnesis terinci untuk merinci volume, pola dan durasi perdarahan menstruasi. Anamnesis yang dilakukan dimulai dengan pertanyaan terkait panjang siklus, keluarnya bekuan darah yang banyak, banyaknya darah keluar, berapa kali mengganti pembalut, sering sampai mengotori pakaian atau seprei dan perdarahan yang membatasi secara sosial yang menunjukkan adanya menoragia. Selanjutnya gejala anemia seperti sesak napas dan pusing. serta gejala penyerta yang berkaitan dengan kemungkinan penyebab menoragia seperti tekanan panggul dan frekuensi kencing, nyeri panggul/ dispareunia, perdarahan berkepanjangan setelah mengalami luka lecet ringan (Corcoran & Burke, 2018)

Tes laboratorium yang dilakukan adalah pemeriksaan darah lengkap untuk menyingkirkan anemia dengan cek hemoglobin, ingkat rombosit karena kondisi seperti yang menyebabkan trombositopenia yang menyebabkan menoragia dan kemungkinan koagulopati seperti penyakit Von Willebrands paling besar pada seseorang dengan anemia berat (<10 g/dL) dan kadar ferritin rendah. Selanjutnya, pada pemeriksaan USG diindikasikan dalam hal temuan pada abnormal ketebalan endometrium. Ketebalan endometrium bervariasi secara substansial sepanjang siklus menstruasi dan ketebalan endometrium normal berkisar dari 4 mm pada fase folikular hingga 16 mm pada fase luteal akhir. Ketika

hasil USG ketebalan endometrium lebih dari 10 mm menunjukkan adanya patologi (Corcoran & Burke, 2018)

Biopsi endometrium harus dilakukan pada wanita berusia 45 tahun atau lebih dengan mengalami menoragia untuk menyingkirkan diagnosis karsinoma atau hiperplasia endometrium dan harus dilakukan pada wanita di bawah 4 tahun yang mengalami menoragia yang berhubungan dengan obesitas atau PCOS (Polycystic Ovary Syndrome)/ peningkatan paparan estrogen secara kronis sebagai risiko kanker endometrium. Selanjutnya pada pemeriksaan Histeroskopi dilakukan bila ada perdarahan vagina teratur yang tidak terjadwal (perdarahan intermenstrual atau pasca-koitus), bila ultrasonografi menunjukkan adanya polip endometrium, atau bila karsinoma endometrium dicurigai pada penilaian ultrasonografi (Corcoran & Burke, 2018).

2. Faktor Risiko

Faktor risiko menoragia yang termasuk adalah peningkatan usia, premenopause leiomyomata, polip endometrium, paritas, indeks massa tubuh, olah raga, tingkat pendidikan, merokok (R. P. Smith, 2018). Selain itu, faktor risiko yang juga dapat meningkatkan untuk mengalami menoragia adalah (Moore, 2011):

- a. Wanita menjelang menopause atau wanita yang belum memiliki siklus menstruasi teratur
- b. Ketidakseimbangan hormon (estrogen dan progesteron)
- c. Infeksi pada alat kelamin atau saluran kemih termasuk penyakit menular seksual
- d. Penyakit ginjal, hati atau tiroid
- e. Tumor hipofisis, sindrom ovarium polikistik atau masalah pembuluh darah
- f. Kehamilan ektopik atau keguguran
- g. Disfungsi ovarium (ovarium tidak menghasilkan sel telur)
- h. Fibroid (tumor rahim jinak)
- i. Endometriosis atau hiperplasia endometrium
- j. Polip serviks atau Rahim
- k. Alat kontrasepsi dalam rahim (!UD) non hormonal
- l. Gangguan perdarahan
- m. Obat-obatan (steroid, pengencer darah, dan antikanker)
- n. Obesitas atau kelebihan berat badan
- o. Kanker rahim atau leher rahim

3. Pengelolaan

Penatalaksanaan menoragia yaitu (Corcoran & Burke, 2018):

a. Farmakologi

- 1) Secara non hormonal: obat anti inflamasi nonsteroid (NSAID), Obat
- 2) Secara hormonal: istem intrauterin pelepasan levonorgestrel (Levonorgestrel-Releasing Intrauterine System/LNG-IUS) atau kontrasepsi IUD, ntrasepsi oral kombinasi yang mengandung 30 hingga 35 mcg ethinyl estradiol, norethisterone (progesteron diberikan dengan dosis hingga 15 mg setiap hari dari hari ke 5 sampai 26 dari siklus menstruasi yang mengakibatkan penghambatan ovulasi dan atrofi, endometrium), kontrasepsi Depo-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) yang diberikan sebagai injeksi intramuskular 150 mg setiap 3 bulan dengan menghambat ovulasi dan efek atrofi langsung pada endometrium, dan dengan agonis GnRH digunakan untuk memberikan pengurangan fibroid atau volume rahim sebelum operasi miomektomi atau histerektomi yang diresepkan hanya sebagai bagian dari manajemen berbasis rumah sakit.

b. Perawatan bedah non histerektomi untuk menoragia

1) Ablasi Endometrium

Ablasi endometrium merupakan suatu prosedur pembedahan dengan merusak lapisan endometrium uterus untuk mengurangi aliran darah menstruasi (Hartono, 2022). Ablasi endometrium direkomendasikan pada penderita menoragia dengan rongga rahim normal, termasuk adanya fibroid dengan diameter maksimum hingga 3 cm yang menyebabkan distorsi rongga rahim. Pilihan perawatan ini hanya cocok jika tidak menginginkan kesuburan di masa depan.

2) Miomektomi

Miomektomi (prosedur pembedahan pengangkatan fibroid) dikaitkan dengan kehilangan darah yang jauh lebih besar dan risiko transfusi darah daripada histerektomi dan akibatnya biasanya dilakukan untuk wanita yang merencanakan kehamilan di masa depan

3) Embolisasi Arteri Uterina (Uterine Artery embolization/UEA)

Embolisasi arteri uterus adalah injeksi arteri uterina dengan menggunakan butiran polyvinyl alkohol melalui kateter yang nantinya akan menghambat aliran darah ke mioma dan menyebabkan nekrosis (Sari et al.,

4) Histerektomi

Histerektomi (prosedur bedah pengangkatan rahim) direkomendasikan pada wanita dengan, fibroid rahim yang tidak memiliki keinginan untuk hamil di masa depan atau yang strategi manajemen lain untuk fibroid tidak berhasil.

C. Hipomenorea

1. Diagnosa

Tanda dan gejala hipomenorea adalah (Setyarini et al., 2023):

- a. Mengganti pembalut 1-2 kali dalam sehari
 - b. Durasi menstruasi hanya membutuhkan waktu 1-2 hari
 - c. Pada jumlah darah kurang dari 35 cc dan terkadang hanya tetesan saja
- Beberapa karakteristik dari gejala hipomenorea, yaitu (Dreisler & Kjer, 2019; InformedHealth.org, 2020; Long, 1990):
- a. Menggunakan pembalut yang sangat sedikit
 - b. Memiliki sedikit aliran darah yang tetap konsisten sepanjang periode
 - c. Memiliki periode yang lebih pendek dari tiga hari
 - d. Perdarahan dapat menyerupai bercak

Periode yang jarang atau hipomenorea merupakan gejala dari ketidakseimbangan mendasar dalam tubuh. Dengan demikian dapat disertai dengan gejala spesifik penyebab lainnya, termasuk (Dreisler & Kjer, 2019; InformedHealth.org, 2020; Long, 1990):

- a. Hot flashes
- b. Jerawat
- c. Sakit kepala
- d. Masalah pencernaan
- e. Perubahan Suasana hati
- f. Kelelahan
- g. Faktor Risiko
- h. Beberapa

2. faktor risiko

- a. Keturunan
Seseorang dengan riwayat keluarga hipomenorea akan berisiko lebih tinggi mengalami hipomenorea
- b. Penggunaan pil kontrasepsi secara teratur
Seseorang yang sering menggunakan kontrasepsi berisiko lebih tinggi mengalami hipomenorea dibandingkan yang tidak
- c. Usia
Usia berperan penting dalam menentukan aliran darah saat menstruasi....
- d. Latihan Fisik
- e. Diabetes
- f. Penyalahgunaan narkoba dan merokok
- g. Obesitas

h. Nutrisi yang buruk

3. Pengelolaan

Menstruasi yang sedikit karena penyebab abnormal tidak memerlukan manajemen, Sedangkan hipomenorea dengan penyebab abnormal perlu dilakukan penanganan dengan fokus umum pada pemulihan keseimbangan hormonal dan pengaturan pola menstruasi. Pada penyesuaian gaya hidup, yaitu (Dreisler & Kjer, 2019; InformedHealth.org, 2020; Long, 1990):

- a. Diet seimbang dengan makanan kaya fitoestrogen, lemak sehat, dan karbohidrat
- b. Olahraga teratur yang terdiri dari olahraga intensitas rendah hingga sedang selama 150 menit seminggu
- c. Pereda stres berupa latihan pernapasan dalam, aromaterapi, meditasi atau yoga.

Obat alternatif, yaitu Dreisler & Kjer, 2019; nformedHealth.org, 2020; Long, 1990):

- a. Suplemen nutrisi, seperti zat besi, folat, dan vitamin B12 untuk membantu mengatasi anemia
- b. Suplemen fitoestrogen, seperti semanggi merah untuk meningkatkan keseimbangan hormon dengan menyediakan estrogen nabati
- c. Suplemen pengatur hormon, yang merangsang kelenjar endokrin untuk mengoptimalkan produksi hormon sendiri dan mengatur menstruasi

Terapi konvensional, yaitu (Dreisler & Kjer, 2019; InformedHealth.org, 2020; Long, 1990):

- a. Obat-obatan, seperti pil KB yang dapat digunakan untuk mengatur siklus menstruasi dan menormalkan aliran menstruasi
- b. Psikoterapi

D. Polimenorea

1. Diagnosa

Siklus pendek dan mengalami menstruasi sering adalah gejala yang berhubungan dengan polimenorea sebagai gejala dari ketidakseimbangan yang mendasari dalam tubuh. Selain itu, dapat disertai dengan gejala lainnya termasuk jerawat, menoragia, kelelahan, kehilangan libido. kram, hot flashes, kecemasan penambahan berat badan (Albers et al., 2004; Bull et al., 2019; Elmaoğullari & Aycan, 2018; D. Shah & Nagarajan, 2013),

2. Faktor Risiko

Beberapa faktor risiko yang mempengaruhi ketidakaturan siklus menstruasi adalah (Yolandiani et al., 2021):

a. Stres

Keadaan stres mempengaruhi produksi hormone prolaktin yang berhubungan langsung dengan hormon kortisol dan penurunan hormon LH yang mempengaruhi siklus menstruasi

b. Status gizi

Gizi kurang dapat menyebabkan kadar GnRH menurun yang disekresikan oleh LH dan FSH. Hal ini menyebabkan kadar estrogen menurun dapat mempengaruhi siklus menstruasi dan masa ovulasi.

c. Durasi tidur

Durasi tidur yang buruk dapat menghambat sintesis hormon melatonin yang mempengaruhi produksi dan sintesis hormon estrogen.

d. Aktivitas fisik

Aktivitas fisik dengan intensitas yang tinggi mempengaruhi hormon FSH dan LH dan aktivitas yang rendah dapat mempengaruhi cadangan energi oksidatif. Energi oksidatif dibutuhkan dalam proses reproduksi.

3. Pengelolaan

Siklus menstruasi yang pendek adalah normal bagi wanita dan tidak memerlukan pengobatan, namun hal itu selama penyebab yang mendasarinya telah disingkirkan. Bagi wanita dengan siklus menstruasi pendek dapat diakibatkan dari gaya hidup yang tidak sehat atau kondisi medis yang belum terselesaikan, pengobatan sebagian besar akan ditujukan untuk mengendalikan penyebab yang mendasarinya dan menghilangkan ketidakseimbangan hormon. Perawatan yang dilakukan termasuk (Albers et al., 2004; Bull et al., 2019; Elmaoğulları & Aycan, 2018; D. Shah & Nagarajan, 2013):

a. Penyesuaian gaya hidup

Diet seimbang yang kaya akan makanan yang mengandung fitoestrogen dan zat besi seperti bayam, kacang-kacangan,

b. Olahraga teratur yang terdiri dari olahraga

intensitas sedang selama 150 menit dalam seminggu.

c. Teknik menghilangkan stres yang mencakup

d. latihan pernafasan dalam, meditasi atau yoga.

e. Obat alternative Suplemen nutrisi, seperti zat besi, untuk mengatasi kekurangan yang mungkin terjadi di antara seringnya menstruasi.

f. Suplemen fitoestrogen, seperti buah beri murni, untuk meningkatkan keseimbangan hormone dengan memasok estrogen nabati

g. Suplemen pengatur hormon, seperti suplemen yang menutrisi kelenjar endokrin menjadi produksi hormon yang optimal.

- h. Pengobatan konvensional Obat-obatan, seperti pil KB yang diresepkan untuk mengurangi aliran menstruasi dan memperpanjang siklus
- i. Psikoterapi dianjurkan bagi yang mengalami gangguan makan atau kecemasan yang dapat memicu

E. Oligomenorea

1. Diagnosa

Hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda. Namun, jika menstruasi tiba-tiba menjadi berbeda dan tidak kembali normal selama sebagian besar masa menstruasi, maka penting untuk mencari tahu penyebab perubahan. Gejala oligomenorea antara lain (Davis & Sparzak, 2023):

- a. Siklus menstruasi akan lebih lama > 35 hari tanpa periode
- b. Memiliki < 9 periode dalam setahun
- c. Siklus menstruasi tidak teratur
- d. Menstruasi yang lebih ringan dari biasanya

Menstruasi yang terlewat dan tertunda adalah tanda oligomenorea yang paling umum, namun terdapat kemungkinan mengalami gejala lain tergantung pada apa yang menyebabkan oligomenorea. Gejala meliputi timbul jerawat, sakit kepala, hot flashes, sakit erut keputihan, gangguan penglihatan dan pertumbuhan rambut berlebih di wajah dan tubuh.

Diagnosis yang dilakukan (Gaete et al., 2010; He et al., 2020; Panidis et al., 2013):

a. Riwayat Kesehatan

Lacak informasi setidaknya selama dua bulan terakhir. Pertanyaan yang timbul termasuk:

- 1) Seperti apa periode menstruasi normal: untuk mengetahui berapa hari berlalu diantara periode, seberapa berat periode, dan lain-lain.
- 2) Riwayat medis keluarga: memiliki anggota keluarga dengan kondisi yang menyebabkan oligomenorea (misal: PCOS) dapat meningkatkan kemungkinan akan mengalaminya.
- 3) Kebiasaan dan gaya hidup: untuk mengetahui rutinitas yang menyebabkan jarangya menstruasi. Pertanyaan tentang hubungan seks tanpa kondom untuk mengesampingkan kemungkinan IMS yang dapat menyebabkan ketidakaturan menstruasi.
- 4) Obat yang diminum: kontrasepsi hormonal, antipsikotik, antiepilepsi dan steroid semuanya dikaitkan dengan oligomenorea

b. Pemeriksaan meliputi:

- 1) Pemeriksaan fisik: wajah, leher, payudara dan perut untuk memeriksa tanda-tanda kondisi yang menyebabkan oligomenorea.
- 2) Pemeriksaan rektovaginal: tenaga kesehatan dengan memasukkan satu jari ke dalam vagina dan satu lagi ke dalam rektum untuk merasakan massa di dalam tubuh
- 3) Pemeriksaan spekulum vagina: alat yang disebut spekulum dapat memperlebar vagina sehingga dapat memeriksa vagina dan leher rahim untuk melihat tanda-tanda perdarahan, pembengkakan atau jaringan parut yang mungkin menyebabkan masalah dan melakukan swab serviks untuk menguji infeksi
- 4) Pemeriksaan perut: untuk merasakan massa dan titik lunak di perut.

c. Prosedur Lanjutan

- 1) CT scan: mendeteksi massa yang mungkin menyebabkan perdarahan.
- 2) Ultrasonografi panggul dan perut: untuk menunjukkan tanda peradangan dan PCOS.
- 3) Magnetic resonance imaging (MRI): dapat memastikan diagnosis prolactinoma.

Tes darah dapat membantu memeriksa uji level kadar hormon dan gula darah, yaitu (Gaete et al., 2010; He et al., 2020; Panidis et al., 2013):

- 1) Hormon perangsang tiroid (TSH): penurunan kadar dapat mengindikasikan hipotiroidisme
- 2) Hormon perangsang folikel (FSH): peningkatan kadar FSH dapat mengindikasikan insufisiensi ovarium Primer.
- 3) Hormon luteinizing (LH): peningkatan kadar LH dengan FSH dapat membantu dalam kaitannya mendiagnosis PCOS
- 4) Prolaktin: peningkatan kadar prolaktin dapat mengindikasikan prolactinoma.
- 5) 17-OHP: level 17-OHP dapat membantu mendiagnosa hiperplasia adrenal kongenital.
- 6) Gula darah: tes HbA1c dapat membantu mendiagnosis diabetes

2. Faktor Resiko

Faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan oligomenorea adalah (Setyawati, 2018):

a. Berat Badan

Perubahan berat badan dapat mempengaruhi fungsi menstruasi. Gangguan menstruasi berhubungan erat dengan adanya gangguan hormon reproduksi wanita yaitu progesteron, estrogen, FSH dan LH. Adanya gangguan pada kerja

sistem hormonal ini berkaitan dengan status gizi. Selanjutnya, status gizi pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adanya infeksi dan asupan makanan.

b. Umur

Pada usia masa remaja muda yang baru mengalami haid ering terjadi ketidakaturan siklus menstruasi karena masih terjadi penyesuaian dalam tubuh. Setelah 1 atau 2 tahun setelah menarche, siklus menstruasi umumnya akan lebih teratur

c. Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik pada tingkat berat dapat merangsang inhibisi GnRH dan aktivitas gonadotropin sehingga menurunkan level serum estrogen

d. Stres

Stres menyebabkan perubahan sistemik tubuh berkaitan dengan sistem saraf dan hipotalamus yang dapat mempengaruhi elevasi kortisol basal dan menurunkan hormon LH.

3. Pengelolaan

Pengobatan untuk oligomenore tergantung pada penyebabnya (Gaete et al., 2010; He et al., 2020; Panidis et al., 2013):

- a. Terapi hormon: persiapan pil KB atau perawatan hormon lainnya jika oligomenore disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon.
- b. Pembedahan : untuk mengangkat tumor yang memproduksi androgen berlebih.
- c. Perubahan gaya hidup: perlu menyesuaikan pola makan dan aktivitas fisik jika kekurangan nutrisi dan aktivitas berat dapat menyebabkan masalah terkait menstruasi. Jika oligomenore terkait dengan sesuatu dalam gaya hidup seperti berat badan, rutinitas olahraga, atau tingka stres, hal yang dapat membantu dengan mendapatkan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Misal dengan menemukan Bahwa masalah menstruasi akan membaik dengan sendirinya setelah kembali liburan, memulai jadwal kerja baru atau menambah berat badan jika kekurangan berat badan (Davis & Sparzak, 2023).

F. Amenorea

1. Diagnosa

Gejala utama amenorea adalah kurangnya menstruasi. Gejala yang tergantung pada penyebabnya. Gejala yang mungkin dialami meliputi (NICHHD, 2017, Seaborg, 2017; Verma et al., 2021):

- a. Hot flashes

- b. Kekeringan vagina
- c. Sakit kepala
- d. Perubahan penglihatan
- e. Jerawat
- f. Pertumbuhan rambut berlebih di wajah dan tubuh

Jika melewati satu periode menstruasi, hal yang perlu diperhatikan tentang gejala dan riwayat kesehatan. Jika amenorea terjadi karena kehamilan bisa memulai perawatan prenatal. Jika terjadi menopause, ada pertolongan jika gejalanya tidak nyaman. Haid yang terlewat yang mengarah ke menopause biasanya dimulai pada usia 40-an (NICHD, 2017; Seaborg, 2017; Verma et al., 2021).

Tes yang perlu dilakukan untuk diagnosis amenorea adalah (NICHD, 2017; Seaborg, 2017; Verma et al., 2021):

- a. Tes kehamilan
- b. Tes darah untuk memeriksa kadar hormon dan mendeteksi gangguan kelenjar tiroid atau adrenal
- c. Tes genetik, jika memiliki insufisiensi ovarium primer dan lebih muda dari 40 tahun
- d. MRI, jika dicurigai adanya masalah dengan kelenjar hipofisis atau hipotalamus.

Mendiagnosis amenorea bisa menjadi menantang jika penyebab amenorea tidak jelas seperti kehamilan, sehingga perlu mencatat perubahan dalam siklus menstruasi. Riwayat menstruasi dapat membantu mengetahui diagnosis, menggunakan aplikasi atau catatan yang perlu diperhatikan adalah (NICHD, 2017; Seaborg, 2017; Verma et al., 2021):

- a. Berapa lama periode berlangsung
- b. Kapan periode terakhir.
- c. Obat-obatan yang dikonsumsi
- d. Perubahan dalam pola makan atau rutinitas olahraga.
- e. Tantangan emosional yang dialami, seperti stres.

2. Faktor Risiko

Faktor risiko untuk amenorea meliputi (NICHD, 2017; Seaborg, 2017; Verma et al., 2021):

- a. Riwayat keluarga amenorea atau menopause dini
- b. Kondisi genetik atau kromosom yang mempengaruhi siklus menstruasi
- c. Obesitas atau kekurangan berat badan
- d. Gangguan makan
- e. Berolahraga berlebihan
- f. Diet yang buruk

- g. Stres
- h. Penyakit kronis

3. Pengelolaan

Manajemen Terapi Jika menstruasi berhenti karena menopause atau kehamilan maka tidak perlu mengobatinya. Dalam kasus lain, perawatan diperlukan tergantung pada penyebabnya, termasuk (NICHD, 2017; Seaborg, 2017; Verma et al., 2021):

- a. Menurunkan berat badan melalui diet dan olahraga (jika penyebabnya adalah kelebihan berat badan)
- b. Menambah berat badan melalui rencana diet individual (jika penyebabnya adalah penurunan berat badan yang ekstrim)
- c. Teknik manajemen stress
- d. Mengubah tingkat latihan
- e. Perawatan hormonal (obat-obatan) seperti yang ditentukan oleh penyedia layanan kesehatan
- f. Pembedahan (dalam kasus yang jarang terjadi), pembedahan direkomendasikan jika memiliki masalah genetik atau kromosom; tumor hipofisis; atau jaringan parut.

Selain itu, rekomendasi beberapa perawatan untuk membantu mengatasi efek samping amenorea (NICHD, 2017; Seaborg, 2017; Verma et al., 2021):

- a. Terapi estrogen untuk meredakan hot flashes dan vagina kering.
- b. Suplemen kalsium dan vitamin D untuk menjaga tulang tetap kuat
- c. Latihan kekuatan.

G. Metroragia

1. Diagnosa

Perdarahan abnorma ditandai dengan perdarahan bervariasi dan tidak terduga dalam hal durasi dan jumlah, terutama terjadi selama perimenopause, dapat menyebabkan keluarnya gumpalan darah atau perdarahan yang cukup banyak sehingga berakibat pada kehilangan darah yang berlebihan (E & McCane, 2019). Beberapa faktor yang berhubungan dengan metroragia adalah (Zakir & Rosmadewi, 2013):

- a. Endometriosis

Endometriosis merupakan suatu keadaan adanya bercak-bercak darah dari jaringan endometrium yang tumbuh di luar cavum uteri, jika dalam keadaan normal pada lapisan endometrium hanya ditemukan pada permukaan cavum uteri. Pada siklus menstruasi, lapisan endometrium setiap bulannya akan luruh karena adanya penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron. Setiap

bulan ovarium menghasilkan hormone yang merangsang terjadinya penebalan pada lapisan endometrium (sebagai persiapan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan apabila adanya konsepsi). Sedangkan jika tidak terjadi konsepsi, lapisan endometrium akan luruh dalam bentuk terjadinya menstruasi. Pada endometriosis lapisan endometrium berada di luar cavum uteri, lapisan ini tidak mampu membersihkan dirinya dari jaringan dan terlepas selama menstruasi sehingga dapat menimbulkan terjadinya perdarahan ringan yang akan membaik dan kembali dirangsang pada siklus menstruasi berikutnya. Lapisan endometrium pada endometriosis ini terjadinya peluruhan tidak terpengaruh oleh hormonal, sehingga menyebabkan terjadinya perdarahan di luar menstruasi atau metroragia.

b. Polip Serviks

Polip serviks merupakan suatu adenoma maupun adenofibroma yang berasal dari selaput lendir endoserviks. Polip yang terjadi pada ektoserviks, endoserviks, endometrium atau vagina dapat terjadi jika mengalami inflamasi lokal yang menyebabkan hiperplasia dan proliferasi selular. Pertumbuhannya dapat distimulasi oleh penggunaan kontrasepsi oral. Epitel endoserviks dapat mengalami metaplasia yang menjadi lebih semakin kompleks. Bagian ujung pada polip dapat mengalami nekrosis serta mudah berdarah. Hal ini sering menimbulkan terjadinya metroragia.

c. Servitis

Servitis merupakan infeksi pada serviks uteri. Servitis sering terjadi karena luka kecil bekas persalinan yang tidak dirawat dan infeksi karena hubungan seks. Pada keadaan servitis kronis sering terdapat erosi porsio sekitar ostium uteri eksternum. Erosi mudah berdarah dan menimbulkan perdarahan kontak atau metroragia

d. Penggunaan Kontrasepsi Hormonal

Kontrasepsi hormonal umumnya terdiri dari hormon estrogen dan progesteron. Efek samping yang ditimbulkan jika kelebihan estrogen adalah rasa mual, retensi cairan, sakit kepala, nyeri pada mammae dan leukorrhea, sedangkan dalam keadaan rendahnya estrogen dapat mengakibatkan spotting dan breakthrough bleeding dalam masa intermenstruum. Selanjutnya efek samping yang ditimbulkan jika progesteron berlebihan dapat menyebabkan perdarahan tidak teratur bertambahnya nafsu makan disertai bertambah berat badan, akne, alopecia, kadang-kadang mammae mengecil, leukorrhea dan hipomenorea

e. Penggunaan AKDR

Penggunaan AKDR dapat menimbulkan efek samping berupa perdarahan di luar haid, hal terjadi biasanya setelah pemasangan yaitu perdarahan sedikit-sedikit dan cepat berhenti. Jika pemasangan dilakukan sewaktu haid, perdarahan sedikit-sedikit ini tidak diketahui oleh akseptor. Keluhan yang sering timbul ialah menoragia, spotting (metroragia)

2. Pengelolaan

Penatalaksanaan pada kasus perdarahan uterus disfungsi/metroragia dapat dilakukan setelah diketahui bahwa penyebab perdarahan abnormal bukan karena kondisi organik tetapi disebabkan oleh kurangnya ovulasi yang reguler. Pengobatan lini pertama untuk perdarahan menstruasi yang sering digunakan adalah obat anti inflamasi nonsteroid (OAINS) karena bekerja dengan mengurangi sintesis prostaglandin pada jaringan endometrium, menyebabkan asokonstriksi dan menurunkan perdarahan. OAINS atau nonsteroidal anti inflammatory drugs (NSAID) seperti asam mefenamat, naproxen dan ibuprofen. OAINS tidak efektif dalam mengendalikan perdarahan menstruasi selayaknya terapi hormon. Pemberian Asam traneksamat adalah inhibitor aktivator plasminogen yang mampu mengontrol HMB dengan menghambat pembubaran trombus. Penanganan umum lain yang dapat dilakukan meliputi pemberian PIL kontrasepsi oral yang mengandung estrogen dan progesteron penempatan kontrasepsi intrauterin levonorgestrel (levonorgestrel intrauterine device, LNG-IUD). Kontrasepsi LNG-IUD memiliki indikasi ganda dari FDA untuk mengontrol kelahiran dan menekan perdarahan menstruasi yang abnormal dengan melepaskan progesteron dalam jumlah stabil langsung kedalam uterus untuk menstabilkan dan menekan lapisan uterus. Kasus siklus anovulasi tidak selalu melibatkan kehilangan darah yang berlebihan sehingga disarankan untuk menjalani gaya hidup sehat, diet kaya zat besi dan suplemen (Bahamondes & Ali, 2015; Bielecka et al., 2019; E & McCane, 2019)

H. Dismenore

1. Klasifikasi *Dismenore*

a. *Dismenore* Primer

Dismenore primer, (disebut juga *dismenore* idiopatik, esensial, intrinsik) adalah nyeri menstruasi tanpa kelainan organ reproduksi (tanpa kelainan ginekologik). Terjadi sejak *menarche* dan tidak terdapat kelainan pada alat kandungan (Proverawati & Misaroh, 2009).

Dismenore primer terjadi sejak pertama haid, biasanya tidak ada kelainan alat kandungan, penyebab psikogen, penyakit kronis, penyempitan leher rahim dan hormonal (Nugroho, 2009)

b. i Skunder

Dismenore sekunder (disebut juga sebagai *dismenore ekstrinsik, acquired*) adalah nyeri menstruasi yang terjadi karena kelainan ginekologik, misalnya *endometriosis* (sebagian besar), *fibroids*, *adenomyosis*. Terjadi pada wanita yang sebelumnya tidak mengalami *dismenore* (Proverawati & Misaroh, 2009).

Dismenore sekunder terjadi biasanya karena ada kelainan yang disebabkan oleh infeksi, *mioma* uteri, *polip* dan *endometriosis* (Nugroho, 2010).

2. Gejala *Dismenore*

Gejala yang paling umum terjadi pada saat *dismenore* adalah kram atau spasma intermiten yang biasanya berpusat di area *supra pubik*. Gejala lainnya berupa nyeri yang menyebar ke ara punggung, kaki dan pinggang, kehilangan nafsu makan, lemas pusing, depresi, iritabilitas, gugup dan mengantuk. Selain itu *dismenore* juga dapat terjadi dengan gejala sistemik antara lain mual, muntah, diare demam dan nyeri kepala, sedangkan menurut Wiknjosastro (1999) mengatakan bahwa gejala dan tanda dari *dismenore* adalah nyeri pada bagian bawah yang bisa menjalar ke punggung bagian bawah dan tungkai. Nyeri dirasakan sebagai kram yang hilang timbul atau sebagai nyeri tumpul yang terus menerus ada. Biasanya nyeri mulai timbul sesaat sebelum atau selama menstruasi, *Dismenore* juga sering disertai oleh sakit kepala, mual, sembelit, diare, sering berkemih dan kadang terjadi sampai muntah.

Sedangkan menurut Proverawati dan Misaro (2009) gejala umum *dismenore* primer adalah terjadi beberapa waktu atau 6-12 bulan sejak menstruasi pertama (menarche). Rasa nyeri timbul sebelum menstruasi atau diawal menstruasi berlangsung beberapa jam namun ada kalanya beberapa hari datangnya nyeri hilang timbul, menusuk-nusuk pada umumnya diperut bagian bawah, kadang menyebar ke sekitarnya (pinggang dan paha depan) adakalanya disertai mual, muntah, sakit kepala dan diare.

3. Faktor penyebab Terjadinya *Dismenore*

a. Faktor Penyebab *Dismenore* Primer

Penyebab pasti *dismenore* primer hingga kini belum diketahui secara pasti (idiopatik), namun beberapa faktor diperkirakan sebagai pemicu terjadinya nyeri menstruasi diantaranya :

- 1) Faktor fisikis
- 2) Seseorang wanita remaja bahkan ibu-ibu yang emosinya tidak stabil lebih mudah mengalami nyeri menstruasi.

- 3) Faktor endokrin
 - 4) Timbulnya nyeri menstruasi diduga karena kontraksi rahim (uterus) yang berlebihan
 - 5) Faktor *prostaglandin* teori ini menyatakan bahwa nyeri menstruasi timbul karena peningkatan produksi prostaglandin (oleh dinding rahim) saat menstruasi.
 - 6) Faktor hormonal
 - 7) Faktor alergi
- b. Faktor Penyebab *Dismenore* Skunder
- 1) Endometriosis
 - 2) Fibroids (*myoma*)
- c. Faktor Kejiwaan
- Pada gadis-gadis yang secara emosional tidak stabil, apalagi jika mereka tidak mendapat penerangan yang baik tentang proses haid, mudah timbul *dismenore*. Wanita mempunyai emosional yang tidak stabil, sehingga mudah mengalami *dismenore* primer.
- d. Faktor Konstitusi
- Faktor konstitusi berhubungan dengan faktor kejiwaan sebagai penyebab timbulnya *dismenore* primer yang dapat menurunkan ketahanan seseorang terhadap nyeri antara lain :
- 1) Anemia

Anemia adalah defisiensi eritrosit atau hemoglobin atau dapat keduanya hingga menyebabkan kemampuan mengangkut oksigen berkurang. Sebagian besar penyebab anemia adalah kekurangan zat besi yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin, sehingga disebut anemia kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi ini dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan baik sel tubuh maupun sel otak dan dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang termasuk daya tahan tubuh terhadap rasa nyeri.
 - 2) Penyakit Menahun

Penyakit menahun yang diderita seorang perempuan akan menyebabkan tubuh kehilangan terhadap suatu penyakit atau terhadap rasa nyeri.
- e. Faktor *Obstruksi Kanalis Servikalis*
- Teori tertua menyatakan bahwa *dismenore* primer disebabkan oleh *stenosis kanalis servikalis*. Pada perempuan dengan uterus dalam *hiperantifleksi* mungkin dapat terjadi *stenosis kanalis servikalis*, akan tetapi hal ini sekarang tidak dianggap sebagai faktor yang penting sebagai penyebab *dismenore*. Banyak perempuan yang menderita *dismenore* tanpa *stenosis servikalis* dan

tanpa uterus dalam hiperantifleksi. Sebaliknya terdapat perempuan tanpa keluhan *dismenore*, walaupun ada *stenosis servikalis* dan uterus terletak dalam *hiperantifleksi* atau *hiperretofleksi*. *Mioma submukosum* bertangkai atau *polip endometrium* dapat menyebabkan *dismenore* karena otot-otot uterus berkontraksi keras dalam usaha untuk melainkan kelainan tersebut.

f. Faktor *Endokrin*

Kejang pada *dismenore* primer disebabkan oleh kontraksi yang berlebihan. Hal ini disebabkan karena endometrium dalam fase sekresi memproduksi prostaglandin $F2\alpha$ yang menyebabkan kontraksi otot-otot polos. Jika jumlah prostaglandin $F2\alpha$ berlebih akan dilepaskan dalam peredaran darah, maka selain *dismenore*, dijumpai pula efek umum, seperti diare, *nausea*, dan muntah.

g. Faktor Alergi

Teori ini dikemukakan setelah adanya asosiasi antara *dismenore* primer dengan urtikaria, migren atau asma bronkial. Smith menduga bahwa sebab alergi ialah toksin haid.

4. Derajat *Dismenore*

Setiap menstruasi menyebabkan rasa nyeri, terutama pada awal menstruasi namun dengan kadar nyeri yang berbeda-beda. *Dismenore* secara siklik dibagi menjadi tiga tingkat keparahan. Menurut Manuaba (2001) *dismenore* dibagi 3 yaitu:

a. *Dismenore* Ringan

Dismenore yang berlangsung beberapa saat dan dapat melanjutkan kerja sehari-hari.

b. *Dismenore* Sedang

Pada *dismenore* sedang ini penderita memerlukan obat penghilang rasa nyeri, tanpa perlu meninggalkan kerjanya.

c. *Dismenore* Berat

Dismenore berat membutuhkan penderita untuk istirahat beberapa hari dan dapat disertai sakit kepala, kram pinggang, diare dan rasa tertekan.

5. Pengelolaan

a. Secara Farmakologi

Menurut Potter dan Perry (2006) upaya farmakologi yang dapat dilakukan dengan memberikan obat analgesik sebagai penghilang rasa sakit. Penanganan nyeri yang dialami oleh individu dapat melalui intervensi farmakologi, dilakukan kolaborasi dengan dokter atau pemberi perawatan utama lainnya pada pasien. Obat-obatan ini dapat menurunkan nyeri dan menghambat produksi prostaglandin dari jaringan-jaringan yang mengalami trauma dan inflamasi yang menghambat reseptor nyeri untuk menjadi sensitif

terhadap stimulus menyakitkan sebelumnya, contoh obat anti inflamasi nonsteroid adalah aspirin, ibuprofen. Menurut Wiknjoksastro (1999), penanganan *dismenore* primer adalah:

1) Pemberian Obat Analgesik

Dewasa ini banyak beredar obat-obat analgesik yang dapat diberikan sebagai terapi simptomatik, jika rasa nyeri hebat diperlukan istirahat di tempat tidur dan kompres panas pada perut bawah untuk mengurangi penderita. Obat analgesik yang sering diberikan adalah preparat kombinasi aspirin, fansetin dan kafein. Obat-obatan paten yang beredar dipasaran antara lain novalgin, ponstan, acetaminophen dan sebagainya.

2) Terapi Hormonal

Tujuan terapi hormonal ialah menekan ovulasi, bersifat sementara untuk membuktikan bahwa gangguan benar-benar *dismenore* primer atau untuk memungkinkan penderita melakukan pekerjaan penting waktu haid tanpa gangguan. Tujuan ini dapat dicapai dengan memberikan salah satu jenis pil kombinasi kontrasepsi.

3) Terapi Dengan Obat Non Steroid Anti Prostaglandin

Endometasin, ibuprofen, dan naproksen, dalam kurang lebih 70% penderita dapat disembuhkan atau mengalami banyak perbaikan. Pengobatan dapat diberikan sebelum haid mulai satu sampai tiga hari sebelum haid dan dapat hari pertama haid.

4) Dilatasi Kanalis Servikalis

Dilatasi kanalis servikalis dapat memberikan keringanan karena dapat memudahkan pengeluaran darah dengan haid dan prostaglandin didalamnya. Neurektomi prasakral (pemotongan urat saraf sensorik antara uterus dan susunan saraf pusat) ditambah dengan neurektomi ovarial (pemotongan urat saraf sensorik pada diligamentum infundibulum) merupakan tindakan terakhir, apabila usaha-usaha lainnya gagal.

b. Secara Non Farmakologi

Menurut Potter dan Perry (2006); Proverawati dan Misaroh (2009) penanganan nyeri secara non farmakologi terdiri dari:

1) Stimulasi dan Masase Kutaneus

Masase adalah stimulus kutaneus tubuh secara umum, sering dipusatkan pada punggung dan bahu. Masase dapat membuat pasien lebih nyaman karena masase membuat relaksasi otot.

2) Terapi Es Dan Panas

Terapi es dapat menurunkan prostaglandin yang memperkuat sensitifitas reseptor nyeri dan subkutan lain pada tempat cedera dengan menghambat

proses inflamasi. Terapi panas mempunyai keuntungan meningkatkan aliran darah ke suatu area dan kemungkinan dapat turut menurunkan nyeri dengan mempercepat penyembuhan.

3) *Ransecutaneus Elektrikal Nerve Stimulaton* (TENS)

TENS dapat menurunkan nyeri dengan menstimulasi reseptor tidak nyeri (*non-neseptor*) dalam area yang sama seperti pada serabut yang menstimulasikan nyeri. TENS menggunakan unit yang dijalankan oleh baterai dengan elektroda yang di pasang pada kulit untuk menghasilkan sensasi kesemutan, menggetar atau mendengung pada area nyeri.

4) Distraksi

Distraksi adalah pengalihan perhatian dari hal yang menyebabkan nyeri, contoh: menyanyi, berdoa, menceritakan gambar atau foto dengan kertas, mendengar musik dan bermain satu permainan.

5) Relaksasi

Relaksasi merupakan teknik pengendoran atau pelepasan ketegangan. Teknik relaksasi yang sederhana terdiri atas nafas abdomen dengan frekuensi lambat, berirama (teknik relaksasi nafas dalam contoh: bernafas dalam-dalam dan pelan).

6) Imajinasi

Imajinasi merupakan hayalan atau membayangkan hal yang lebih baik khususnya dari rasa nyeri yang dirasakan.

7) Yoga dapat membantu mengurangi rasa sakit.

8) Latihan erobik seperti berjalan kaki, bersepeda atau berenang, membantu memproduksi bahan alami yang dapat memblokir rasa sakit .

9) Orgasme dapat meringankan kram menstruasi pada beberapa perempuan.

10) Tidur yang cukup sebelum dan selama periode menstruasi.

11) Akupresur

Terapi akupresur terbukti dapat membantu meningkatkan hormon endorfin otak secara alami dapat membantu menawarkan rasa sakit haid (Hartono, 2012). Terapi akupresur pada *dismenore* dapat menguatkan *yang* dan menimbulkan reaksi melemahkan *yin* pada titik-titik akupresur terpilih sehingga dapat mengatasi *dismenore* (Fengge, 2012)

I. Mestalgia

1. Diagnosa

Gejala nyeri payudara siklik, yaitu payudara terasa lembut, bengkak, berat dan sakit. Tingkat keparahan rasa sakit bisa berbeda untuk setiap individu, dan untuk beberapa orang mungkin juga menyebar ke ketiak dan bahu. Sedangkan

gejala nyeri payudara nonsiklik, yaitu (BreastCancer.Org, 2022; Eren et al., 2016; Healthwise Staff, 2021):

- a. Rasa sakit akan terbatas pada satu area tertentu di payudara
- b. Rasa sakit yang lebih tajam dan lebih akut
- c. Sensasi terbakar dan menusuk di satu area itu.

Gejala nyeri payudara nonsiklik dapat datang dan pergi seiring waktu atau menetap dalam waktu yang lebih lama (BreastCancer.Org, 2022; Eren et al., 2016; Healthwise Staff, 2021).

Pertanyaan yang muncul dalam mendiagnosis nyeri payudara meliputi sudah berapa lama mengalami nyeri payudara, tingkat keparahan serta frekuensi nyeri. Selama pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan payudara untuk kemungkinan adanya benjolan, mencondongkan tubuh ke depan selama pemeriksaan untuk menilai apakah rasa sakit itu berasal dari payudara atau dari dalam dada. Selanjutnya mammogram atau ultrasound diperlukan tergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis rasa sakit yang spesifik, temuan dari pemeriksaan payudara, umur dan lamanya waktu antara prosedur mammogram atau ultrasound terakhir (BreastCancer.Org, 2022; Eren et al., 2016; Healthwise Staff, 2021).

Faktor Risiko Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya mastalgia seperti (Bano et al., 2020; Bolat et al., 2021):

- a. Peningkatan BMI
- b. Kurangnya olahraga
- c. Gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi
- d. Merokok
- e. Konsumsi kafein dan coklat
- f. Jumlah kehamilan dan kelahiran
- g. Lama menyusui
- h. Status menstruasi
- i. Riwayat operasi payudara sebelumnya

2. Pengelolaan

Manajemen Terapi Nyeri payudara siklik tidak memerlukan banyak perawatan karena nyeri payudara siklik merupakan bagian rutin dari siklus menstruasi. Penggunaan obat pereda nyeri untuk membantu mengurangi gejala rasa sakit yang menjadi tidak terkendali pada nyeri payudara seperti acetaminophen, ibuprofen, natrium naproxen, aspirin dan diklofenak. Ada juga beberapa metode pengobatan lain yang dapat digunakan untuk membantu meredakan nyeri payudara, di antaranya (BreastCancer.Org, 2022; Eren et al., 2016; Healthwise Staff, 2021):

- a. Mengenakan bra yang ukuran pas dan mendukung (ukuran dan bentuk payudara berubah seiring waktu, jadi pastikan secara rutin memasang ukuran bra yang tepat).

- b. Mengonsumsi suplemen Vitamin E dan multivitamin lainnya
- c. Menghilangkan kafein dari diet.
- d. Menghindari produk tembakau.
- e. Menggunakan minyak evening primrose.
- f. Menerapkan panas ke area yang paling menyakitkan di payudara, pastikan untuk melindungi kulit
- g. Mengonsumsi suplemen magnesium. Jika meminumnya selama siklus menstruasi, kira-kira dua minggu sebelum menstruasi, ini dapat membantu meringankan beberapa gejala.
- h. Mengoleskan krim rolamine salicylate yang dijual bebas untuk meredakan sakit dan nyeri.
- i. Relaksasi dan terapi komplementer
- i. Jika menemukan penyebab yang mendasari rasa sakit pada gejala nyeri payudara nonsiklik (seperti fibroadenoma, kista, atau benjolan jinak), dapat dilakukan pengangkatan dan meringankan gejalanya (BreastCancer.Org, 2022; Eren et al., 2016; Healthwise Staff, 2021).
- j. Perawatan mastalgia dapat difokuskan pada konseling wanita yang lebih tua mengenai fisiologi normal payudara seiring bertambahnya usia dan pentingnya melakukan SADARI secara rutin sebagai cara untuk memantau gejala dan mencatat setiap perubahan yang dapat diamati dari waktu ke waktu (Pruthi & Ami, 2004).

Mastalgia siklik memiliki banyak penyebab, termasuk pembesaran siklik akibat menstruasi atau beberapa kista. Terapi nyeri payudara dapat dicapai dalam beberapa kasus dengan aspirasi kista (metode untuk mengeluarkan cairan dari kista), penurunan asupan kafein, atau analgesik. Obat rumahan untuk nyeri payudara termasuk 400 U vitamin E per hari, vitamin B6, analgesik, penurunan asupan lemak dan garam, penggunaan bra olahraga, dan minyak evening primrose. Dalam kasus ekstrim, progestin, danazol, tamoxifen, atau bromocriptine digunakan untuk meredakan mastodynia ("Clinical Breast Problems and Unusual Breast Conditions," 2011). Pendekatan langkah awal dalam penanganan mastalgia dengan perawatan farmakologis menggunakan obat pereda nyeri jenis NSAID, EPO, danazol dan sediaan hormonal seperti tamoxifen (Ali, 2020; Bano et al., 2020).

J. Kesimpulan

Gangguan menstruasi adalah kondisi yang mempengaruhi siklus menstruasi wanita, dapat menyebabkan gejala seperti nyeri, perdarahan berlebihan, atau tidak ada menstruasi sama sekali. Gangguan menstruasi mempengaruhi sekitar 30-50% wanita usia reproduksi.

1. Faktor Penyebab

- a. Hormonal: Ketidakseimbangan hormon reproduksi.
- b. Genetik: Faktor keturunan.
- c. Lingkungan: Faktor lingkungan seperti stres, polusi, dan gaya hidup tidak sehat.

2. Diagnosa

- a. Riwayat Kesehatan: Mengumpulkan riwayat kesehatan pasien.
- b. Pemeriksaan Fisik: Melakukan pemeriksaan fisik untuk memeriksa kondisi reproduksi.
- c. Tes Laboratorium: Melakukan tes laboratorium untuk memeriksa hormon dan kondisi lainnya.

3. Pengelolaan

- a. Pengobatan Hormonal: Menggunakan hormon untuk mengatur siklus menstruasi.
- b. Pengobatan Non-Hormonal: Menggunakan obat anti-inflamasi dan obat nyeri untuk mengurangi gejala.
- c. Perubahan Gaya Hidup: Mengubah gaya hidup seperti mengurangi stres, berolahraga teratur, dan makan makanan seimbang.
- d. Terapi Alternatif: Menggunakan terapi alternatif seperti akupunktur dan herbal untuk mengurangi gejala.

Gangguan menstruasi adalah kondisi yang mempengaruhi siklus menstruasi wanita. Diagnosa dan pengelolaan yang tepat dapat membantu mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Perlu dilakukan perubahan gaya hidup dan pengobatan yang tepat untuk mengatasi gangguan menstruasi.

K. Referensi

- Bahamondes, L., & Ali, M. (2015). Recent advances in managing and understanding menstrual disorders. 7(March). <https://doi.org/10.12703/P7-33>
- Bielecka, G. J., Mizgier, M., & Kedzia, W. (2019). Metrorrhagia iuenilis and Premenstrual Syndrome as frequent problems of adolescent gynecology with aspects of diet therapy. 0(7%), 423-429. <https://doi.org/10.5603/GP.20190072>
- Davis, E., & Sparzak, P. B. (2023). Abnormal Uterine Bleeding. StatPearls Publishing LLC.
- Fegge, A. (2012). *Terapi Akupresur Manfaat dan Teknik Pengobatan*. Yogyakarta: Crop Cirele Crop
- Gaete, X., Vivanco, M., Eyzaguirre, F. C., López, P., Rhumie, H. K., Unanue, N., & Codner, E. (2010). Menstrual ycle Itrregularities and Their Relationship

with HbA1c and Insulin Dose in Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus. Fertility and Sterility, 94(5), 1822-1826. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2009.08.039>

- Hartono, R, I, W. (2012). *Akupresur untuk Berbagai Penyakit*. Yogyakarta: Rafa Puplishing
- Manuaba, dkk. (2009). *Memahami kesehatan reproduksi wanita*. Jakarta: EGC
- NICHHD. 2017, J anuary 31). Amenorrhea. Unice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development. <https://www.nichd.nih.gov/health/topics/amenorrhea>
- E, H. S., & McCane, K. L. (2019). Buku Ajar Patofisiologi (S. D. Wahono, R. Ratnawati, & H. Sujuti, Eds.; Keenam). Elsevier.
- Nugroho. (2010). *Buku Ajar Ginekologi Untuk Mahasiswa Kebidanan*. Yogyakarta : Nuha Medika
- Panidis, D., Tziomalos, K., Chatzis, P., Papadakis, E., Delkos, D., Tsourdi, E. A., Kandaraki, E. A., & Katsikis, I. (2013). Association between Menstrual Cycle Irregularities and Endocrine and Metabolic Characteristics of the Polycystic Ovary Syndrome, *European Journal of Endocrinology*, 168(2), 145- 152. <https://doi.org/10.1530/EJE-12-0655>
- Potter dan Ferry. (2006). *Fundamental Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Proverawati dan Misaroh. (2009). *Menarche Menstruasi Pertama Penuh Makna*. Yogyakarta : Nuha Medika
- Seaborg, E. (2017, June). No Easy Answers: New Functional Hypothalamic Amenorrhea Treatment Guidelines Released. Endocrine Society <https://endocrinenews.endocrine.org/no-easy-answers-new-hypothalamic-amenorrhea-treatment-guidelines/>
- Setyawati, A. S. (2018). Pengaruh Status Gizi terhadap Oligomenorea pada Mahasiswi FK Unismuh Angkatan 2015 dan 2016. Tniversitas Muhammadiyah Makassar.
- Verma, A., Manea, A., Koci, T. M., & Eckert, K. L. (2021). Primary Amenorrhea and Hyperandrogenism: Presenting Features of a Growth Hormone Producing Pituitary Adenoma in a Female Adolescent. *Journal of the Endocrine Society*, 5(Supplement 1), A705-A705. <https://doi.org/10.1210/jendso/bvab048.1436>
- Wiknjosatro. (1999). *Ilmu Kandungan*. Jakarta .Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirowiharjo
- Zakir, M., & Rosmadewi. (2013). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Metroragia. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 197-205 . <https://doi.org/10.26630/jkep.v9i2.358>

CHAPTER 6

PERAWATAN KESEHATAN WANITA LANSIA: PENCEGAHAN PENYAKIT DEGENERATIF DAN PENANGANAN OSTEOPOROSIS

Dr. Devi Arista, SST., Bdn., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan menopause alami sebagai setidaknya 12 bulan amenorea berturut-turut yang bukan disebabkan oleh penyebab fisiologis dan patologis. Rata-rata usia menopause alami adalah 51 tahun di negara-negara industri, sedangkan 48 tahun di negara-negara miskin dan non industri (Sapre & Thakur, 2014). Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan di Indonesia sebesar 76 tahun. Dengan begitu, sebagian besar wanita akan menghabiskan sepertiga waktu hidup mereka setelah masa transisi menopause. Selain itu, karena populasi lansia berkembang pesat, maka jumlah wanita menopause pun akan meningkat. Wanita akan mengalami berbagai gejala yang cukup mengganggu selama transisi menopause, diantaranya hot flashes, keringat malam, rasa kering pada vagina, dispareunia, gangguan tidur dan perubahan suasana hati. Selain itu, kondisi yang paling umum terjadi pada wanita pascamenopause adalah osteoporosis. Osteoporosis merupakan penyakit umum yang terjadi pada lansia. Penyakit ini disebabkan karena meningkatnya kerapuhan tulang dan risiko patah tulang. Osteoporosis menyebabkan morbiditas yang signifikan diseluruh dunia.

Osteoporosis adalah penyakit yang mempengaruhi sistem muskuloskeletal dan sering terjadi pada orang dewasa yg lebih tua. Tanda dari penyakit ini adalah adanya kepadatan tulang yang rendah dan hilangnya massa dan kekuatan otot (Papadopoulou et al., 2021).

B. Pencegahan Penyakit Degeneratif

Penyakit degeneratif adalah suatu kelainan media ketika penyakit yang berhubungan dengan organ atau jaringan terus memburuk seiring berjalannya waktu. Penyakit ini disebabkan oleh perubahan pada sel-sel tubuh, yang pada akhirnya berdampak pada fungsi seluruh organ. Penyakit degeneratif semakin banyak terjadi akibat menurunnya aktivitas fisik, gaya hidup, dan gizi (Amila et al., 2021). Kualitas hidup seseorang dapat terpengaruh oleh penyakit degeneratif ini.

Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan sebelum terdiagnosa maupun setelah terdiagnosa. Pencegahan yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan kesadaran akan faktor risiko, menjauhi faktor risiko dan melakukan cek kesehatan secara teratur. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran adalah dengan memberikan edukasi secara langsung maupun menggunakan teknologi. Edukasi ini dapat meningkatkan motivasi pasien terkait manajemen diri (Mendoza et al., 2013).

C. Pengertian Osteoporosis

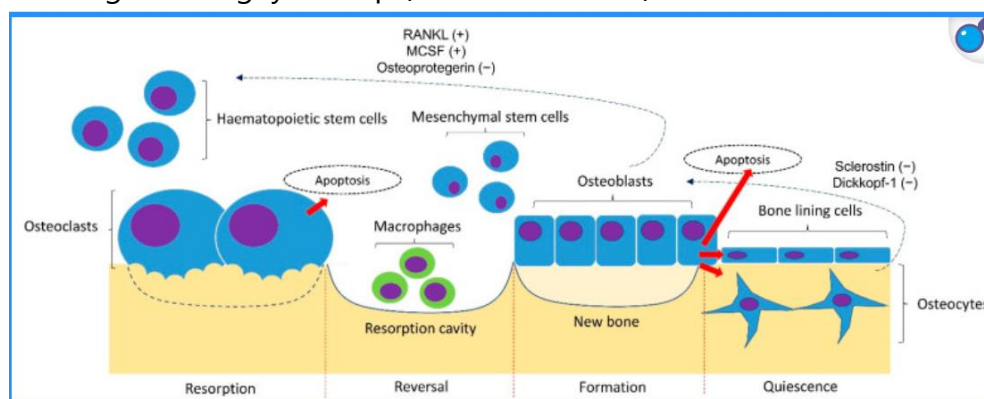
Osteoporosis adalah penyakit tulang yang ditandai dengan berkurangnya kekuatan tulang akibat memburuknya massa tulang dan mikroarsitektur tulang yang menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap terjadinya patah tulang (Lorentzon & Cummings, 2015). Osteoporosis ini tergantung pada massa kepadatan tulang. Pada masa menopause, terjadi penurunan hormon estrogen. Dimana hormon estrogen ini memiliki fungsi untuk mengontrol regenerasi tulang, sehingga wanita berisiko lebih besar untuk terkena osteoporosis daripada pria (Alswat, 2017).

Selain itu, osteoporosis juga dianggap sebagai penyakit yang tidak terlihat, karena umumnya tidak ada gejala yang ditimbulkan hingga terjadinya patah tulang.

Diseluruh dunia, sebanyak 200 juta orang menderita osteoporosis dan 8,9 juta patah tulang terjadi disetiap tahunnya. Prevalensi osteoporosis adalah 18,3% secara global dan lebih besar terjadi pada wanita daripada pria. Hal ini dikarenakan kejadian osteoporosis erat kaitannya dengan kehilangan hormon estrogen (Papadopoulou et al., 2021).

D. Patofisiologi Osteoporosis

Osteoporosis terjadi karena defisiensi estrogen pada wanita pascamenopause dan defisiensi vitamin D. Namun, pada dasarnya osteoporosis merupakan suatu penyakit multifaktorial yang disebabkan oleh interaksi kompleks faktor genetik, intristik, eksogen, dan gaya hidup (Grabowski, 2015).



Gambar 6.1 Gambaran osteoporosis

Sumber: (Ma et al., 2021)

Ada tiga komponen utama yang berperan pada remodeling tulang, yaitu osteoklas, osteoblas dan osteosit. Ketika terjadi kerusakan tulang, osteoklas yang berasal dari polikarion makrofag bermigrasi ke lokasi kerusakan dan melakukan resorpsi tulang. Pada akhir resorpsi tulang, osteoklas mengalami apoptosis dan menghasilkan badan apoptosis yang kemungkinan akan berperan dalam osteogenesis (Ma et al., 2021). Setelahnya, osteoblas yang berasal dari sel punca mesenkimal akan bermigrasi ke rongga dan melakukan pembentukan tulang (Xiao et al., 2015). Beberapa osteoblas akan tertanam didalam matriks tulang yang mereka sintesis dan berdiferensiasi menjadi osteosit. Osteosit bertindak sebagai mekanosensor dan memainkan peran regulasi dalam mengatur proses remodeling tulang melalui protein dan melalui remodeling perilakunar secara langsung (Ma et al., 2021).

Dengan kata lain, ketika fungsi osteoklas dan osteoblas tidak seimbang, proses remodeling tulang dapat sangat berubah, yang dapat mengakibatkan gangguan yang berhubungan dengan metabolisme tulang. Secara khusus, osteoporosis ditandai dengan peningkatan resorpsi tulang karena osteoklastogenesis yang berlebihan dan aktivitas osteoklastik yang tidak seimbang dengan pembentukan tulang yang dimediasi oleh osteoblas. Sehingga hal ini dapat menyebabkan peningkatan kerapuhan tulang dan risiko patah tulang.

Untuk menjaga homeostatis dan kekuatan mineral tulang, proses remodeling tulang diatur dengan cermat. Ligan reseptor aktivator faktor nuklir kappa-B (NF- κ B) (RANKL) dan faktor perangsang koloni makrofag (M-CSF) merangsang diferensiasi osteoklas, tetapi osteoprotegerin (OPG) yang dibuat oleh osteoblas dan osteosit dapat menghambat diferensiasi (Tobeiha et al., 2020). Kehilangan tulang dapat terjadi ketika laju pembentukan tulang lebih rendah daripada resorpsi tulang (Siddiqui & Partridge, 2016).

Proses pembentukan tulang dipengaruhi oleh banyak faktor. Tiga faktor dasar hilangnya tulang dalam banyak kondisi patologis diantaranya adalah defisiensi estrogen, peradangan dan stres oksidatif.

1. Defisiensi Estrogen

Defisiensi estrogen menjadi penyebab umum terjadinya osteoporosis yang berkaitan dengan menopause pada wanita, karena pada wanita menopause terjadi defisiensi estrogen. Defisiensi estrogen menginduksi percepatan kerapuhan tulang (Cano, 2017). Tulang trabekuler membentuk hingga 20 persen tulang, sedangkan tulang kortikal yang selalu mengalami proses pembentukan dan resorpsi tulang dalam unit remodeling tulang membentuk sebanyak 80 persen sisanya. Setiap tahun, sekitar 10 persen tulang dewasa diregenerasi.

Tingkat remodeling tulang yang tidak seimbang diperburuk oleh kekurangan estrogen, dimana aktivitas resorpsi tulang osteoklas secara signifikan lebih tinggi dibandingkan aktivitas pembentukan tulang osteoblas. Hal ini mengakibatkan penipisan kortikal tulang, yang berdampak pada penipisan tulang trabekuler dan hilangnya elemen trabekuler. Pada wanita pascamenopause, perubahan arsitektur ini terjadi dengan cepat, dan pengeroposan tulang berlangsung seumur hidup.

Estrogen mengatur homeostatis tulang melalui regulasi pada sistem kekebalan tubuh, stres oksidatif dan efek langsung tulang. Estrogen memiliki efek pada aktivitas remodeling tulang antara lain; menghambat aktivitas remodeling tulang dan inisiasi BMU, menghambat diferensiasi dan mempromosikan apoptosis osteoklas (Rizqa & Widani, 2023). Estrogen adalah pengatur penting metabolisme tulang dan memberikan peran pelindung tulang dengan mengurangi resorpsi tulang dan mempertahankan pembentukan tulang. Oleh karena itu, defisiensi estrogen pada wanita pascamenopause menyebabkan osteoporosis yang berhubungan dengan peningkatan resorpsi tulang yang berlebihan karena peningkatan jumlah dan aktivitas osteoklas dan apoptosis osteosit (Tatsumi et al., 2007).

2. Peradangan

Peradangan adalah respons defensif terhadap sinyal eksogen dan atau endogen. Kehilangan estrogen menyebabkan keadaan peradangan kronis dan meningkatkan kadar mediator proinflamasi, seperti sitokin dan kemokin, yang mempengaruhi fungsi sel tulang, yang berkontribusi pada perkembangan osteoporosis. Saat terjadi peradangan, sel makrofag memiliki peran penting dalam proses penyembuhan luka karena sel ini berkontribusi pada semua aspek pertumbuhan sel. Makrofag, sel utama yang terlibat dalam produksi sitokin dalam metabolisme tulang adalah sel fleksibel dengan kemampuan untuk mengubah fungsi sesuai dengan lingkungannya. Peningkatan yang terjadi pada rasio makrofag ini terdapat pada sumsum tulang dan defisiensi estrogen yang terjadi berkontribusi terhadap perubahan rasio ini dengan menginduksi diferensiasi makrofag menjadi osteoklas. Dengan demikian, inflamasi dapat meningkatkan jumlah osteoklastik, resorpsi tulang dan proses osteoporosis (Chuan, C. C., Sri, C. Muhammad, 2021).

3. Stres oksidatif

Stres oksidatif adalah ketidakseimbangan radikal bebas dan antioksidan dalam tubuh yang menyebabkan kerusakan sel. Stres oksidatif ini ditandai dengan peningkatan kadar spesies oksigen reaktif (ROS) intraseluler. Produksi ROS ini dalam keadaan fisiologis biasanya diimbangi oleh sistem antioksidan

yang memadai, termasuk vitamin E dan C, glutathione peroksidase, glutathione tereduksi, superoksida dismutase dan katalase (Tatsumi et al., 2007). Ketika produksi ROS dikendalikan, mereka akan bertindak mengatur dan mengaktifkan proses biologis seperti apoptosis, diferensiasi, proliferasi dan peradangan, termasuk juga perbaikan tulang dan remodeling tulang. Produksi ROS sangat penting dalam induksi osteoklastogenesis dan hal ini juga menunjukkan bahwa ROS bertindak sebagai mediator intraseluler untuk diferensiasi osteoklastik. Oleh karena itu, produksi fisiologis ROS dalam osteoklas cukup penting dalam memfasilitasi kerusakan dan remodeling tulang, karena osteoblas menghasilkan sistem antioksidan untuk menghilangkan ROS (Poljsak et al., 2013). Keadaan dimana kadar ROS yang tinggi karena oksidasi tertentu akan mengatasi sistem oksidan. Perubahan ini menyebabkan hilangnya massa tulang yang akan menyebabkan osteoporosis. Secara khusus, produksi ROS yang berlebihan akan meningkatkan osteoklastogenesis dan mengurangi osteoblastogenesis dan aktivitas osteoblastik yang mengakibatkan perubahan arsitektur tulang dan hilangnya tulang yang menjadi ciri terjadinya osteoporosis.

E. Diagnosis Osteoporosis

Diagnosis osteoporosis dapat dilakukan dengan adanya fraktur kerapuhan yang terjadi secara keseluruhan, dimana pengukuran menggunakan BMD dengan dual energy X-ray absorptiometry (DEXA). DEXA dapat mendiagnosis osteoporosis secara akurat sebelum fraktur terjadi (Curry et al., 2018). Osteoporosis terjadi ketika BMD turun dibawah 2,5 standar deviasi (SD) dibandingkan dengan BMD wanita muda yang sehat pada massa tulang puncak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setiap penurunan SD dalam skor-T BMD leher femur dikaitkan dengan peningkatan risiko fraktur pinggul sebesar 2,6 kali lipat. Demikian pula, setiap penurunan SD dalam skor-T BMD untuk tulang belakang dan radius distal meningkatkan risiko fraktur masing-masing sebesar 2,3 dan 1,7 kali lipat. Namun biaya pemeriksaan DEXA ini mahal dan memerlukan peralatan khusus dan staf terlatih.

F. Faktor Risiko Osteoporosis

1. Bone Mineral Density (BMD)

Bone Mineral Density (BMD) merupakan suatu biomerker untuk risiko fraktur yang digunakan untuk diagnosis dan evaluasi efek terapi pada osteoporosis. Perubahan kepadatan mineral tulang (BMD) merupakan prediktor penting untuk osteoporosis dan fraktur lainnya. Secara umum, BMD yang lebih rendah berhubungan dengan risiko fraktur yang lebih tinggi. Dalam beberapa

kondisi patologis, osteosit mengalami apoptosis berlebihan yang juga dikaitkan dengan hilangnya kepadatan mineral tulang (BMD) dan masa tulang yang dapat menyebabkan osteoporosis (Tatsumi et al., 2007).

2. Genetika

Faktor genetik memegang peranan penting dalam osteoporosis. Studi tentang saudara kembar dan keluarga telah menunjukkan bahwa osteoporosis sangat bersifat familial dan faktor genetik sebagian besar bertanggung jawab atas kemungkinan penyakit ini diturunkan dalam keluarga. Hal ini berlaku untuk berbagai macam fenotipe yang berhubungan dengan osteoporosis, termasuk BMD, pergantian tulang, dan dimensi rangka yang terkait dengan pertumbuhan dan risiko patah tulang (Duncan & Brown, 2008). Riwayat keluarga yang menderita osteoporosis merupakan faktor risiko penting yang tidak dapat dirubah untuk penyakit ini. Riwayat osteoporosis yang positif (biasanya diantara ibu) merupakan faktor prediktor kuat untuk penyakit yang sama (Bijelic et al., 2019).

3. Kondisi Menopause

Rendahnya kadar estrogen yang bersirkulasi berhubungan dengan risiko osteoporosis pascamenopause. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa waktu sejak menopause memiliki hubungan dengan osteopenia pascamenopause dan osteoporosis (Fistarol et al., 2019). Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa ada korelasi menopause dini antara usia 40 dan 45 tahun dengan BMD pada wanita pascamenopause. Terjadi peningkatan risiko osteoporosis, patah tulang rapuh dan mortalitas pada wanita dengan menopause sebelum usia 47 tahun (Svejme et al., 2012).

4. Berat Badan

Berat badan rendah merupakan faktor risiko osteoporosis yang terdokumentasi dengan baik, sedangkan kelebihan berat badan merupakan faktor protektif. Wanita dengan indeks masa tubuh (IMT) kurang dari 20kg/m² memiliki rasio risiko osteoporosis yang jauh lebih tinggi dibandingkan wanita dengan IMT antara 25 kg/m² dan 35 kg/m² (Journal et al., 2010).

5. Gaya Hidup

Kurangnya aktivitas fisik atau gaya hidup yang tidak banyak bergerak berhubungan positif dengan perkembangan osteoporosis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak digunakannya tubuh meninggalkan dampak yang signifikan pada massa trabekular pada kerangka yang menua dan kurang responsif terhadap efek pembuatan ulang mekanis (Cunningham et al., 2018).

6. Diabetes Melitus (DM)

Diabetes melitus (DM) merupakan faktor risiko untuk terjadinya osteoporosis. Secara umum, adipogenesis sumsum tulang yang berlebihan bersifat toksik bagi sel-sel tulang pada penderita DM yang berdampak buruk bagi kesehatan tulang (Sundararaghavan et al., 2017). Namun, fenotip BMD DM tipe 1 berbeda dengan BMD DM tipe 2. Pada DM tipe 1 terjadi BMD rendah sedangkan DM tipe 2 memiliki peningkatan BMD. BMD yang meningkat pada DM tipe 2 karena terjadi peningkatan sirkulasi insulin dan leptin, yang memberikan sinyal anabolik ke osteoblas. Obesitas yang terjadi pada penderita DM tipe 2 memberikan rangsangan mekanis terhadap pertumbuhan tulang. Namun, risiko patah tulang pada pasien DM tipe 2 masih tinggi.

G. Pengobatan Farmakologis Osteoporosis

1. Bisfosfonat

Bisfosfonat merupakan intervensi pilihan yang dapat dilakukan pada wanita berusia lebih dari 60 tahun. Bisfosfonat terdapat pada sebagian besar pengobatan osteoporosis dan tersedia dalam sediaan generik. Bisfosfonat bekerja dengan menghambat remodeling tulang, dan semua golongan bisfosfonat oral terbukti mengurangi risiko patah tulang. Namun, pada saat mengonsumsi bisfosfonat ini terkadang terjadi iritasi gastrointestinal dan nyeri otot. Ada dua efek samping namun jarang terjadi yaitu fraktur femur atipikal dan osteonekrosis rahang. Fraktur femur atipikal yaitu fraktur pada batang femur yang memiliki orientasi melintang dan fitur morfologi yang tidak hancur, menunjukkan penebalan kortikal lateral fokal, terjadi dengan trauma minimal dan mungkin bilateral. Sedangkan osteonekrosis rahang yaitu tulang yang terbuka di daerah maksilofasial yang tidak sembuh dalam delapan minggu. Risiko ini dapat terjadi pada penggunaan bisfosfonat jangka panjang dan rekomendasi penghentian obat dapat dilakukan setelah 1-2 tahun penggunaan (Yong EL, 2021).

Bisfosfonat secara signifikan dapat meningkatkan BMD tulang belakang lumbal panggul dan leher femur, karena bisfosfonat memiliki efek langsung pada penurunan pergantian tulang yang mengakibatkan peningkatan BMD (Uchida et al., 2009). Beberapa bentuk oral umum dari agen bisfosfonat meliputi alendronat, etidronat dan risedronat. Sedangkan obat bisfosfonat yang disuntikkan seperti asam zoledronat.

2. Kalsitonin

Kalsitonin adalah agen hormonal yang menghambat resorpsi tulang, tersedia dalam bentuk suntikan dan inhalasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kalsitonin meningkatkan BMD namun tidak memiliki efek terhadap reduksi

fraktur . karena respon maksimum yang rendah dan tindakan kurang efektif dibandingkan bisfosfonat, maka kalsitonin dianggap sebagai pengobatan utama dalam kondisi berkurangnya pembentukan tulang (Murphy, 2002).

3. Terapi Penggantian Hormon (HRT)

Terapi penggantian hormon (HRT) merupakan pengobatan yang dapat dilakukan pada osteoporosis akibat glukokortikoid (GIOP) dengan defisiensi hormon seks (Seibel et al., 2013). Estrogen telah terbukti meningkatkan BMD pada pasien GIOP dengan defisiensi hormon seks, namun peningkatan risiko penyakit kardiovaskular dan kanker payudara secara signifikan mengurangi manfaatnya bagi tulang. Selain itu, testosteron pada pria dengan hipogonadisme telah terbukti mencegah keropos tulang pada tulang belakang lumbar pada GIOP.

4. Romosozumab

Romosozumab adalah agen anabolik yang baru disetujui untuk manajemen osteoporosis karena meningkatkan pembentukan tulang. Obat ini menunjukkan keamanan dan kemanjuran yang lebih baik dalam meningkatkan BMD dibandingkan teriparatide. Namun, mengonsumsi romosozumab ini dapat meningkatkan risiko kardiovaskular tinggi pada pasien riwayat kardiovaskular. Oleh karena itu, didalam meresepkan romosozumab profil kardiovaskular pasien harus dipertimbangkan (Fixen & Tunoa, 2021).

5. Teriparatide

Pengobatan dengan teriparatide harus dipertimbangkan pada wanita pascamenopause dengan osteoporosis berat yang tidak dapat mentoleransi pengobatan lain atau mereka yang mengalami fraktur baru meskipun telah menjalani terapi antiresorptif (Khan et al., 2014). Kontraindikasi penggunaan obat teriparatide ini meliputi pasien dengan risiko osteosarkoma, hiperkalsemia, terapi radiasi sebelumnya atau riwayat keganasan tulang sebelumnya (Mendoza et al., 2013).

6. Denosumab

Denosumab bekerja mirip dengan osteoprotegerin endogen, yang mengurangi kehilangan tulang dan meningkatkan kepadatan tulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denosumab lebih unggul dalam meningkatkan BMD ditulang belakang lumbar dan pinggul dibandingkan dengan risedronat (Fixen & Tunoa, 2021). Terapi kombinasi denosumab dan teriparatide terbukti meningkatkan BMD di tulang belakang lumbar dan meregenerasi volume tulang kanselus dibandingkan dengan pemberian tunggal.

7. Strontium Ranelat

Strontium ranelat merupakan pengobatan alternatif untuk osteoporosis. Strontium ranelat terdiri dari garam strontium dari asam ranelat dan bekerja untuk meningkatkan BMD dengan meningkatkan pengendapan tulang baru oleh osteoblas dan mengurangi resorpsi tulang oleh osteoklas. Karena inti strontium hampir sama besarnya dengan kalsium, sehingga mudah dimasukkan kedalam tulang untuk meningkatkan pembentukan tulang. Strontium ranelat mendorong diferensiasi pre-osteoblas menjadi osteoblas dan merangsang osteoblas untuk memproduksi osteoprotegerin yang dapat memblokir aksi RANKL untuk menghambat diferensiasi preosteoklas menjadi osteoklas. Secara klinis dapat menurunkan risiko patah tulang belakang dan pinggul (Fixen & Tunoa, 2021).

H. Tindakan Nonfarmakologis Untuk Pencegahan dan Pengobatan Osteoporosis

1. Latihan

Mengingat bahwa fraktur merupakan hasil dari jatuh, meningkatkan tonus otot dan keseimbangan melalui latihan dapat mengurangi risiko jatuh. Latihan ketahanan memiliki efek rendah hingga sedang yang signifikan terhadap perubahan BMD pada wanita pascamenopause (Kemmler et al., 2020). Latihan ketahanan beban tinggi maupun rendah sama-sama efektif terhadap BMD leher femur dan tulang belakang lumbal pada wanita menopause (Souza et al., 2020). Tai chi dan yoga merupakan latihan keseimbangan yang dapat meningkatkan tonus otot dan kesehatan mental, yang mana kedua faktor ini mempengaruhi risiko osteoporosis seseorang. Namun, saat ini banyak sekali wanita yang tidak banyak bergerak dan olahraga ini mungkin dirasa tidak menyenangkan dilakukan pada daerah beriklim tropis. Tidak hanya itu, banyak wanita yang mengeluh nyeri sendi dan masalah lutut sehingga membuat olahraga ini tidak disukai (Yong EL, 2021).

Program latihan yang menargetkan tulang akan memberikan pengaruh positif terhadap kepadatan mineral tulang (BMD) dan kandungan mineral tulang (BMC) pada tulang yang diberi beban. Olahraga ini dapat mempengaruhi kekuatan dan massa tulang pada semua usia. Dengan demikian, aktifitas fisik yang teratur dapat mendorong peningkatan massa tulang dan optimalisasi geometri tulang selama masa kanak-kanak dan pubertas, sehingga akan berkontribusi pada pemeliharaan massa tulang selama masa dewasa, dan mengurangi penurunan kehilangan dan kekuatan massa tulang selama usia tua, sehingga dapat mencegah fraktur osteoporosis pada orang tua (Ackerman & Misra, 2011).

2. Kalsium dan Vitamin D

Penggunaan suplemen kalsium dan vitamin D dapat mengurangi risiko patah tulang total dan pinggul. Karena kedua nutrisi ini penting untuk kesehatan rangka yang optimal sepanjang siklus hidup. Kalsium adalah mineral dominan yang terdapat dalam tulang, sedangkan vitamin D penting untuk penyerapan kalsium yang efisien dan efisien untuk fungsi sel-sel tulang (Yong EL, 2021). Telah diketahui secara luas bahwa vitamin D dapat meningkatkan penyerapan kalsium dalam usus dan membantu mempertahankan konsentrasi kalsium serum yang memadai untuk memungkinkan mineralisasi tulang yang normal. Vitamin D juga dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang dan remodeling tulang oleh osteoblas dan osteoklas. Dengan demikian, kalsium dan vitamin D bekerja sama secara sinergis pada tulang dan mengkonsumsi keduanya dapat mengurangi risiko patah tulang.

3. Mengurangi Risiko Jatuh di Rumah

Selain latihan, menjaga lingkungan rumah terhadap adanya bahaya seperti penggunaan alas kaki yang tepat dan menghentikan konsumsi obat-obatan yang berisiko merupakan strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi potensi risiko jatuh. K+arena pada wanita menopause risiko patah tulang dapat terjadi jika mengalami jatuh.

I. Simpulan

Masalah kesehatan yang sering terjadi pada wanita menopause adalah penyakit osteoporosis. Salah satu yang menyebabkan hal ini terjadi dikarenakan defisiensi estrogen. Hormon estrogen mengatur homeostatis tulang dan memiliki efek terhadap aktivitas remodeling tulang. Salah satu faktor risiko terjadinya osteoporosis adalah gaya hidup. Kurangnya aktivitas fisik dan gaya hidup yang buruk berhubungan positif dengan perkembangan osteoporosis. Karena jika tubuh jarang bergerak maka akan berdampak pada massa trabekular pada kerangka yang menua dan mengurangi proses remodeling tulang.

Tindakan nonfarmakologis yang dapat dilakukan yaitu dengan latihan yang menargetkan tulang, karena pada latihan ini dapat mempengaruhi kepadatan mineral tulang (BMD) dan kandungan mineral tulang (BMC). Selain itu, dengan beraktifitas fisik yang teratur dapat mendorong peningkatan massa tulang selama kanan-kanan dan dewasa, dan berkontribusi pada pemeliharaan tulang di masa tua sehingga dapat mencegah terjadinya fraktur osteoporosis pada masa tua. Salah satu latihan yang banyak digunakan adalah thai chi dan yoga.

J. Referensi

- Ackerman, K. E., & Misra, M. (2011). Bone health and the female athlete triad in adolescent athletes. *Physician and Sportsmedicine*, 39(1), 131–141. <https://doi.org/10.3810/psm.2011.02.1871>
- Alswat, K. A. (2017). Gender Disparities in Osteoporosis. *Journal of Clinical Medicine Research*, 9(5), 382–387. <https://doi.org/10.14740/jocmr2970w>
- Amila, A., Sembiring, E., & Aryani, N. (2021). Deteksi Dini Dan Pencegahan Penyakit Degeneratif Pada Masyarakat Wilayah Mutiara Home Care. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 4(1), 102–112. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v4i1.3441>
- Bijelic, R., Milicevic, S., & Balaban, J. (2019). The Influence of Non-preventable Risk Factors on the Development of Osteoporosis in Postmenopausal Women. *Materia Socio-Medica*, 31(1), 62–65. <https://doi.org/10.5455/msm.2019.31.62-65>
- Cano, A. (2017). *Menopause: A Comprehensive Approach*. Springer International Publishing.
- Chuan, C. C., Sri, C. Muhammad, M. (2021). Development of Cholesterol Calculator Websites: Investigation on Food Cholesterol in Malaysia Using Web-Based Calculator. *Enhanced Knowledge in Sciences and Technology*, 1(2), 60–65.
- Cunningham, H. C., West, D. W. D., Baehr, L. M., Tarke, F. D., Baar, K., Bodine, S. C., & Christiansen, B. A. (2018). Age-dependent bone loss and recovery during hindlimb unloading and subsequent reloading in rats. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12891-018-2156-x>
- Curry, S. J., Krist, A. H., Owens, D. K., Barry, M. J., Caughey, A. B., Davidson, K. W., Doubeni, C. A., Epling, J. W., Kemper, A. R., Kubik, M., Landefeld, C. S., Mangione, C. M., Phipps, M. G., Pignone, M., Silverstein, M., Simon, M. A., Tseng, C. W., & Wong, J. B. (2018). Screening for osteoporosis to prevent fractures us preventive services task force recommendation statement. *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 319(24), 2521–2531. <https://doi.org/10.1001/jama.2018.7498>
- Duncan, E. L., & Brown, M. A. (2008). Genetic studies in osteoporosis - The end of the beginning. *Arthritis Research and Therapy*, 10(5), 1–8. <https://doi.org/10.1186/ar2479>
- Fistarol, M., Rezende, C. R., Figueiredo Campos, A. L., Kakehasi, A. M., & Geber, S. (2019). Time since menopause, but not age, is associated with increased risk of osteoporosis. *Climacteric*, 22(5), 523–526. <https://doi.org/10.1080/13697137.2019.1634046>

- Fixen, C., & Tunoa, J. (2021). Romosozumab: a Review of Efficacy, Safety, and Cardiovascular Risk. *Current Osteoporosis Reports*, 19(1), 15–22. <https://doi.org/10.1007/s11914-020-00652-w>
- Grabowski, P. (2015). Physiology of Bone. *Endocrine Development*, 28(3), 33–55. <https://doi.org/10.1159/000380991>
- Journal, T., North, T., Menopause, A., Vol, S., North, T., & Menopause, A. (2010). Management of osteoporosis in postmenopausal women: 2010 position statement of the north American menopause society. *Menopause*, 17(1), 25–54. <https://doi.org/10.1097/gme.0b013e3181c617e6>
- Kemmler, W., Shojaa, M., Kohl, M., Schoene, D., & Von Stengel, S. (2020). Dynamic Resistance Exercise and Bone Mineral Density at the Lumbar Spine in Postmenopausal Women: A systematic review and meta-analysis with special emphasis to exercise parameters. *Osteologie*, 29(3), 194–206. <https://doi.org/10.1055/a-1177-4031>
- Khan, A., Fortier, M., Reid, R., Abramson, B. L., Blake, J., Desindes, S., Dodin, S., Graves, L., Guthrie, B., Johnston, S., Rowe, T., Sodhi, N., Wilks, P., & Wolfman, W. (2014). Osteoporosis in Menopause. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, 36(9), 839–840. [https://doi.org/10.1016/S1701-2163\(15\)30489-8](https://doi.org/10.1016/S1701-2163(15)30489-8)
- Lorentzon, M., & Cummings, S. R. (2015). Osteoporosis: The evolution of a diagnosis. *Journal of Internal Medicine*, 277(6), 650–661. <https://doi.org/10.1111/joim.12369>
- Ma, Q., Liang, M., Wu, Y., Luo, F., Ma, Z., Dong, S., Xu, J., & Dou, C. (2021). Osteoclast-derived apoptotic bodies couple bone resorption and formation in bone remodeling. *Bone Research*, 9(1). <https://doi.org/10.1038/s41413-020-00121-1>
- Mendoza, N., Sánchez-Borrego, R., Villero, J., Baró, F., Calaf, J., Cancelo, M. J., Coronado, P., Estévez, A., Fernández-Moya, J. M., González, S., Llaneza, P., Neyro, J. L., Del Pino, J., Rodríguez, E., Ruiz, E., & Cano, A. (2013). 2013 Update of the consensus statement of the Spanish Menopause Society on postmenopausal osteoporosis. *Maturitas*, 76(1), 99–107. <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2013.05.021>
- Murphy, G. M. (2002). An update on glucocorticoid-induced osteoporosis. *Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine*, 18, 1–4.
- Papadopoulou, S. K., Papadimitriou, K., Voulgaridou, G., Georgaki, E., Tsotidou, E., Zantidou, O., & Papandreou, D. (2021). Exercise and nutrition impact on osteoporosis and sarcopenia—the incidence of osteosarcopenia: A narrative review. *Nutrients*, 13(12), 1–14. <https://doi.org/10.3390/nu13124499>
- Poljsak, B., Šuput, D., & Milisav, I. (2013). Achieving the balance between ROS and

antioxidants: When to use the synthetic antioxidants. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, 2013. <https://doi.org/10.1155/2013/956792>

- Rizqa, I., & Widani, D. I. (2023). Peran Estrogen Remodelling Tulang Pada Kasus Osteoporosis Post-Menopausal. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 4(3), 159–166. <https://doi.org/10.31862/9785426311961>
- Sapre, S., & Thakur, R. (2014). Lifestyle and dietary factors determine age at natural menopause. *Journal of Mid-Life Health*, 5(1), 3. <https://doi.org/10.4103/0976-7800.127779>
- Seibel, M. J., Cooper, M. S., & Zhou, H. (2013). Glucocorticoid-induced osteoporosis: Mechanisms, management, and future perspectives. *The Lancet Diabetes and Endocrinology*, 1(1), 59–70. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(13\)70045-7](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(13)70045-7)
- Siddiqui, J. A., & Partridge, N. C. (2016). Physiological bone remodeling: Systemic regulation and growth factor involvement. *Physiology*, 31(3), 233–245. <https://doi.org/10.1152/physiol.00061.2014>
- Souza, D., Barbalho, M., Ramirez-Campillo, R., Martins, W., & Gentil, P. (2020). High and low-load resistance training produce similar effects on bone mineral density of middle-aged and older people: A systematic review with meta-analysis of randomized clinical trials. *Experimental Gerontology*, 138, 110973. <https://doi.org/10.1016/j.exger.2020.110973>
- Sundararaghavan, V., Mazur, M. M., Evans, B., Liu, J., & Ebraheim, N. A. (2017). Diabetes and bone health: latest evidence and clinical implications. *Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease*, 9(3), 67–74. <https://doi.org/10.1177/1759720X16687480>
- Svejme, O., Ahlborg, H. G., Nilsson, J. Å., & Karlsson, M. K. (2012). Early menopause and risk of osteoporosis, fracture and mortality: A 34-year prospective observational study in 390 women. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 119(7), 810–816. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2012.03324.x>
- Tatsumi, S., Ishii, K., Amizuka, N., Li, M., Kobayashi, T., Kohno, K., Ito, M., Takeshita, S., & Ikeda, K. (2007). Targeted Ablation of Osteocytes Induces Osteoporosis with Defective Mechanotransduction. *Cell Metabolism*, 5(6), 464–475. <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2007.05.001>
- Tobeiha, M., Moghadasian, M. H., Amin, N., & Jafarnejad, S. (2020). RANKL/RANK/OPG Pathway: A Mechanism Involved in Exercise-Induced Bone Remodeling. *BioMed Research International*, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/6910312>
- Uchida, K., Nakajima, H., Miyazaki, T., Yayama, T., Kawahara, H., Kobayashi, S., Tsuchida, T., Okazawa, H., Fujibayashi, Y., & Baba, H. (2009). Effects of alendronate on bone metabolism in glucocorticoid-induced osteoporosis

measured by¹⁸F-fluoride PET: A prospective study. *Journal of Nuclear Medicine*, 50(11), 1808–1814.
<https://doi.org/10.2967/jnumed.109.062570>

Xiao, W., Wang, Y., Pacios, S., Li, S., & Graves, D. T. (2015). Cellular and Molecular Aspects of Bone Remodeling. *Frontiers of Oral Biology*, 18, 9–16.
<https://doi.org/10.1159/000351895>

Yong EL, L. S. (2021). Menopausal osteoporosis: screening, prevention and treatment. *Singapore Med J*, 62(4), 159–166.

K. Glosarium

WHO	: World Health Organization
AHH	: Angka Harapan Hidup
OPG	: Osteoprotegerin
DEXA	: Dual Energy X-ray Absorptiometry
BMD	: Bone Mineral Densitometry
SD	: Standar Deviasi
IMT	: Indeks Massa Tubuh
DM	: Diabetes Melitus
GIOP	: Glukokortikoid
HRT	: Terapi Pergantian Hormon

CHAPTER 7

PENTINGNYA OLAHRAGA DAN NUTRISI PADA WANITA DI SEMUA USIA

Elivne Ivana Kabuhung, SST., M.Kes

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan reproduksi pada wanita usia subur (WUS) dalam rentang usia 15-49 tahun sangat penting untuk diperhatikan karena memiliki berbagai permasalahan (Wati et al., 2023). Beragam permasalahan kesehatan yang dialami oleh perempuan meliputi pengaturan kesuburan (kontrasepsi), penyakit menular seksual, kekerasan berbasis seks dan gender, kehamilan dan persalinan, serta ketersediaan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan (Ardianti, 2019; Gagnon et al., 2002). Berbagai permasalahan kesehatan reproduksi perempuan tersebut akan memberikan dampak yang cukup serius terhadap status demografi negara, karena kesehatan reproduksi yang baik akan mempengaruhi kualitas demografi manusia (Meo & Nahak, 2020).

Berdasarkan penelitian bahwa 80.2% responden pertama kali mempunyai anak pada usia remaja akhir, 53.1% tidak menggunakan KB, 56.4% mempunyai anak lebih dari dua orang, 55% responden memiliki riwayat tidak aktif mengikuti Antenatal Care (ANC) dan 59% memiliki riwayat tidak memberikan ASI eksklusif (Meo & Nahak, 2020). Temuan utama dalam penelitian ini adalah primimuda dan rendahnya penggunaan kontrasepsi, sehingga kedua masalah ini berdampak pada tingginya angka fertilisasi dan mortalitas perempuan. Hasil penelitian lainnya membuktikan bahwa perempuan imigran secara paksa dapat meningkatkan fertilisasi, karena adanya dorongan dari pengungsi untuk 'repopulasi', atau mengisi kembali dan menggantikan jumlahnya yang hilang atau berkurang. Peningkatan jumlah penduduk pengungsi semakin diperburuk dengan ketidakterediaan kontrasepsi dan kurangnya pengetahuan terkait pemanfaatan kontrasepsi (Gagnon et al., 2002; Palareti et al., 2016). Temuan lainnya adalah rendahnya pemanfaatan pelayanan ANC. Masalah kesehatan selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan juga menjadi permasalahan yang dialami perempuan pengungsi, hal tersebut dikaitkan dengan kemiskinan yang berdampak pada status nutrisi dan hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang adekuat akibat perbedaan bahasa dan budaya antara perempuan pengungsi dan petugas kesehatan (Barnes & Harrison, 2004; Gagnon et al., 2002).

Masalah-masalah yang dialami oleh WUS ini mungkin dikarenakan kurangnya informasi dari petugas kesehatan, masih minimnya upaya pemerintah dalam memberikan informasi dan sosialisasi serta kurangnya upaya-upaya promotif dan preventif dalam mencegah masalah kesehatan reproduksi wanita. Selain itu kurangnya kesadaran dari WUS dan keluarga untuk berupaya mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi wanita, khususnya pada WUS. Faktor sosial ekonomi, budaya dan lingkungan, psikologis, dan biologis yang mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita (Ardianti, 2019). Faktor sosial ekonomi terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi disebut paling berpengaruh terhadap terjadinya masalah reproduksi pada wanita. Adapun faktor budaya dan lingkungan seperti praktek tradisional yang berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rezeki, informasi dari masyarakat dan keluarga yang diyakini dari generasi ke generasi yang berlawanan dengan informasi medis akan membingungkan. Anggapan bahwasanya masalah kesehatan reproduksi adalah urusan perempuan, dan tidak berhubungan dengan suami ataupun anggota keluarga yang lain.

B. Pentingnya Olahraga pada Wanita

Masa remaja (10 hingga 19 tahun) adalah masa unik yang tidak hanya ditandai oleh meningkatnya kapasitas fisik untuk aktif secara seksual dan mengandung anak, tetapi juga oleh kapasitas kognitif dan psikososial yang belum sepenuhnya berkembang untuk menilai konsekuensi yang tidak diinginkan dari aktivitas seksual dan menegosiasikan seks yang aman dan konsensual (Gray et al., 2013). Pengaruh perkembangan pada pengambilan keputusan seksual, bagi banyak remaja sangatlah rumit, karena dipengaruhi oleh tantangan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, pernikahan dini, pencapaian pendidikan yang rendah, terbatasnya kesempatan kerja, dan hambatan sosial budaya dan peraturan untuk mengakses informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Kombinasi faktor-faktor ini meningkatkan kehamilan remaja sekaligus menciptakan hambatan terhadap perilaku mencari perawatan. Kehamilan remaja meningkat di kalangan remaja perempuan dengan penyebab utama yaitu kehamilan diluar nikah dan keputusan untuk menikah di usia muda (Meo & Nahak, 2020).

Walaupun seks pranikah dan kehamilan di luar nikah tidak disetujui dan tidak ditoleransi oleh masyarakat di lingkungan pengungsi namun kontrol yang rendah dari orangtua menyebabkan banyak remaja jatuh dalam pergaulan bebas yang berdampak pada kehamilan di luar nikah. Risiko yang terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan mencakup aborsi yang tidak aman, perilaku ibu yang buruk

dalam mencari layanan kesehatan, kesehatan mental yang buruk, dan kemungkinan kematian ibu dan bayi, berisiko lebih tinggi terkena eklampsia, persalinan prematur, dan peningkatan morbiditas dan mortalitas neonatal (Mohamed et al., 2023).

Penyebab kedua tingginya angka kehamilan remaja adalah keputusan untuk menikah di usia muda. Remaja memilih untuk menikah di usia remaja karena menjadi ibu rumah tangga adalah pilihan karir satu-satunya setelah kemungkinan untuk sekolah sudah tertutup sebagai dampak dari kemiskinan. Anggapan melalui pernikahan seluruh kebutuhan perempuan akan menjadi tanggungjawab suaminya setelah pernikahan akan tetapi perempuan yang telah menikah tetap ikut andil dalam membantu perekonomian keluarga.

Terlepas dari alasan apapun, kehamilan remaja tetap memberikan dampak negatif bagi remaja. Reproduksi sehat untuk hamil dan melahirkan berkisar antara usia 20-30 tahun. Jika terjadi kehamilan di bawah atau di atas usia tersebut akan berisiko terjadinya kematian 2 hingga 4 kali lebih tinggi dari reproduksi sehat. Kematian ini kemungkinan besar disebabkan oleh kombinasi faktor biologis, akses yang lebih buruk terhadap perawatan antenatal, persalinan, dan pascanatal, serta lebih seringnya melakukan aborsi yang tidak aman. Bayi yang lahir dari perempuan usia remaja juga berisiko mengalami kematian neonatal 50% lebih tinggi pada minggu pertama dan 50% hingga 100% lebih tinggi selama bulan pertama kehidupan dibandingkan bayi yang dilahirkan perempuan usia 20-30 tahun. Angka kelahiran prematur yang lebih tinggi, persalinan yang rumit, dan berat badan lahir rendah, serta akses yang lebih rendah terhadap kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran, perawatan terampil saat melahirkan, dan perawatan pascanatal kemungkinan merupakan faktor yang berkontribusi. Kehamilan remaja membawa kerugian bagi kesehatan, kesejahteraan mental dan psikologi remaja, menghambat peluang karir dan peningkatan ekonomi, meningkatkan kemiskinan serta menghambat prospek masa depan remaja, remaja tersebut akan mengalami anemia, hipertensi gestasional, preeklampsia, prematuritas dan berat badan lahir rendah (Gray et al., 2013)

Kehamilan dini juga menambah beban sosial ekonomi bagi remaja itu sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat karena remaja akan diminta untuk meninggalkan sekolah saat hamil, atau mereka meninggalkan sekolah untuk menikah dan hamil. Capaian pendidikan yang lebih rendah dikaitkan dengan hasil kesehatan yang lebih buruk bagi anak perempuan dan anak-anak mereka, meningkatkan ketergantungan perempuan pada suami dan keluarga mereka, dan memperburuk ketidakadilan gender di komunitas mereka. Meninggalkan sekolah juga membatasi peluang mata pencaharian anak perempuan, yang memperkuat siklus kemiskinannya sendiri dan mengurangi produktivitas komunitasnya.

Intervensi yang diperlukan untuk menurunkan kehamilan usia remaja yaitu dengan memberikan akses terhadap keluarga berencana, perawatan antenatal dan postnatal yang berkualitas, perawatan terampil saat melahirkan, dan aborsi yang aman serta perawatan pasca aborsi. Namun, remaja mengalami hambatan unik dalam mengakses informasi dan perawatan kesehatan reproduksi dan tidak mungkin mendapat manfaat dari intervensi kesehatan reproduksi yang ditujukan pada keseluruhan populasi.

Menilik tingginya angka kehamilan remaja, perlu perhatian khusus pemerintah untuk mencegah kehamilan remaja dan mencegah kehamilan berulang pada ibu remaja. Selain itu, model pelayanan kesehatan yang diperlukan adalah konsep *youth friendly*. Konsep ini merujuk pada sikap petugas yang ramah, penuh perhatian dan tidak menggurui dalam memberikan pelayanan sehingga dapat mengatasi hambatan pemanfaatan pelayanan kesehatan remaja. Intervensi psikososial (KIE terkait kesehatan reproduksi), kunjungan rumah dan pendampingan keluarga muda, serta penguatan program keluarga berencana juga perlu untuk mencegah kehamilan berulang pada ibu remaja (Aslam et al., 2017; Yani et al., 2014).

Pedoman WHO, *mencegah kehamilan dini dan hasil reproduksi yang buruk di kalangan remaja di negara-negara berkembang*, memberikan seruan untuk bertindak dan memberikan arahan untuk penelitian di masa depan mengenai (WHO, 2011):

1. mencegah kehamilan dini: dengan mencegah perkawinan sebelum usia 18 tahun; dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya pencegahan kehamilan; dengan meningkatkan penggunaan kontrasepsi; dan dengan mencegah seks yang dipaksakan;
2. mencegah hasil reproduksi yang buruk: dengan mengurangi aborsi yang tidak aman; dan dengan meningkatkan penggunaan layanan antenatal, persalinan dan pasca melahirkan yang terampil.

Beberapa intervensi yang ditujukan untuk mencegah kehamilan usia dini terbagi menjadi dua kategori besar yaitu intervensi psikososial multi-elemen dan program kontrasepsi.

1. Intervensi Psikososial

Program psikososial menawarkan berbagai layanan, seperti manajemen kasus dan rujukan; edukasi tentang kehamilan, persalinan dan melahirkan, kontrasepsi dan kesehatan bayi; pelatihan perkembangan anak; fasilitasi kontak dengan sistem perawatan kesehatan; dan konseling individual. Sebagian besar program ini melibatkan kunjungan rumah, berbasis komunitas dan melibatkan konseling telepon dengan periode tindak lanjut juga berkisar antara 12 bulan hingga 24 bulan.

2. Intervensi berbasis rumah Intervensi berdasarkan kunjungan rumah melibatkan konselor, mentor, bidan, perawat atau pengunjung rumah terlatih yang direkomendasikan dari pemerintahan, atau yang direkrut dari masyarakat atau dari kelompok etnis yang sama memberikan intervensi kepada ibu muda di rumah mereka. Beberapa penelitian tentang intervensi psikososial berbasis rumah melaporkan efektivitas intervensi dalam mengurangi proporsi kehamilan remaja berulang. Program kunjungan rumah berulang memfasilitasi akses ke layanan, mengatasi kesenjangan dalam jaringan dukungan sosial, mempertahankan perubahan perilaku melalui kontak berulang dengan ibu muda, sehingga menurunkan resiko dari kehamilan berulang, dan memungkinkan mereka untuk mengekspresikan kebutuhan individu mereka. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memberikan intervensi ini adalah petugas kesehatan harus memiliki pengetahuan yang terus ditingkatkan dan lebih spesifik terkait permasalahan yang dialami pada kehamilan usia dini sehingga maksimal dalam memberikan saran tentang kontrasepsi untuk remaja muda dan perlu adanya pelatihan keterampilan hidup bagi ibu muda sehingga lebih tidak rentan untuk hamil lagi.

3. Intervensi berbasis komunitas

Intervensi berbasis komunitas yang terbukti efektif dalam mengurangi kehamilan usia dini berulang adalah program perawatan prenatal yang berpusat pada teman sebaya dan partisipasi kelompok yang mendapatkan dukungan dari kader kesehatan (Aslam et al., 2017). Faktor penunjang lainnya diperlukan oleh tenaga kesehatan adalah memerlukan transportasi ke dan dari lokasi dan ketersediaan makanan, minuman, dan fasilitas penitipan anak semuanya dapat meningkatkan keterlibatan dan meningkatkan tingkat kehadiran kader dan peer group dalam pelaksanaan pelatihan. Program 'sistem teman' atau kelompok dukungan sebaya dapat menawarkan pilihan yang memberdayakan wanita muda dan memberi mereka kepercayaan diri, serta memberi mereka kesempatan untuk menyatakan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Bagi kader atau peer group merasa beruntung dan dihargai untuk menjadi bagian dari kelompok sebaya.

4. Intervensi berbasis telepon Satu studi melaporkan intervensi pendampingan berbasis telepon yang disampaikan oleh konselor wanita muda dengan latar belakang etnis yang sama dengan wanita muda yang terlibat.

Kehamilan remaja dapat dicegah dengan mendorong remaja untuk menunda debut seksual mereka, menentang praktik pernikahan anak, meningkatkan konsistensi penggunaan kontrasepsi dan mendidik anak perempuan dan laki-laki tentang risiko kehamilan yang tidak diinginkan (Oringanje et al., 2016). Masyarakat

yang cenderung berhasil menerapkan pendekatan multifaset, yaitu menerapkan program pencegahan yang dilakukan pada tingkat primer, sekunder, dan tersier (Mohamed et al., 2023). Program-program ini berupaya untuk tidak hanya berfokus pada seks dan potensi konsekuensi dari melakukan hubungan seks yang tidak aman, namun juga mengatasi faktor-faktor kontekstual seperti norma-norma sosial, pemberdayaan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan pribadi. Selain itu, kelompok sasarannya tidak hanya terbatas pada remaja perempuan tetapi juga mencakup remaja laki-laki, orang tua, guru, dan tokoh masyarakat (Oringanje et al., 2016). Berdasarkan penelitian tentang pedoman berbasis bukti untuk mencegah kehamilan remaja, berhasil diidentifikasi beberapa strategi pencegahan kehamilan (Mohamed et al., 2023; D. Taylor & James, 2011), yaitu

1. Strategi Pencegahan Primer

Mencakup strategi yang mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Contohnya adalah lingkungan keluarga yang mendukung, pendidikan seksualitas yang komprehensif, kontrasepsi, serta pencegahan dan deteksi kekerasan seksual dan berbasis gender.

Pencegahan primer terdiri dari upaya yang ditujukan untuk mencegah timbulnya suatu kondisi tertentu salah satunya mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Tujuan dari pencegahan primer kehamilan yang tidak diinginkan adalah untuk membantu individu dalam mencapai niat kehamilannya dan meningkatkan outcome ibu, anak dan keluarga dengan meningkatkan kemungkinan bahwa setiap kehamilan adalah kehamilan yang diinginkan dan direncanakan (D. Taylor et al., 2010).

Banyak rekomendasi untuk kesehatan prakonsepsi yang sudah diketahui secara luas. Pengujian yang tepat untuk infeksi menular seksual untuk melindungi kesuburan di masa depan, dorongan suplementasi asam folat sebelum konsepsi untuk mencegah cacat tabung saraf, dan pentingnya perubahan gaya hidup sehat seperti berhenti merokok dan alkohol, olahraga teratur dan pola makan sehat adalah contohnya.

Evaluasi terhadap kesehatan prakonsepsi dan risiko kehamilan yang tidak diinginkan juga merupakan peluang untuk mengatasi pilihan gaya hidup yang mempengaruhi bidang penting lainnya dalam kesehatan reproduksi. Beresiko tinggi mengalami kehamilan yang tidak diinginkan terkait dengan masalah kesehatan penting lainnya termasuk obesitas, merokok, dan pesta minuman keras, terutama pada perempuan minoritas dan berpenghasilan rendah. Konseling prakonsepsi tidak boleh terbatas hanya pada diskusi tentang cara mengoptimalkan hasil kehamilan dan mencegah kehamilan yang tidak

diinginkan, namun juga memberikan cara untuk mengatasi masalah kesehatan preventif lainnya.

Pengetahuan tentang penggunaan kontrasepsi pasien merupakan komponen penting dalam pencegahan primer. Evaluasi rutin terhadap penggunaan kontrasepsi pasien mempunyai potensi untuk meningkatkan pelayanan pasien dan menormalkan pencegahan utama kehamilan yang tidak diinginkan dalam setiap kunjungan layanan kesehatan. Pencegahan primer kehamilan yang tidak diinginkan juga mencakup evaluasi kepuasan pasien terhadap metode kontrasepsinya pada kunjungan berikutnya. Strategi pencegahan primer untuk mengatasi kehamilan yang tidak diinginkan akan kurang efektif jika ditujukan hanya pada perempuan. Perempuan yang pasangannya sangat mendukung penggunaan kontrasepsi cenderung menggunakan kontrasepsi mereka secara efektif.

Kekerasan pasangan intim dikaitkan dengan peningkatan kehamilan yang tidak diinginkan dan hasil perinatal yang buruk. Bukti terbaru menunjukkan bahwa hubungan antara kekerasan pasangan intim dan kehamilan yang tidak diinginkan mungkin terkait tidak hanya dengan menurunnya kemampuan perempuan yang berada dalam hubungan yang penuh kekerasan untuk menegosiasikan praktik seks yang lebih aman, namun juga dengan pengendalian reproduksi langsung oleh pasangannya seperti sabotase kontrasepsi.

Strategi dan layanan pencegahan primer yang penting antara lain:

a. Strategi konseling

Metode konseling dipilih untuk melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan kontrasepsi serta pedoman bagi profesional kesehatan untuk membantu individu mencapai tujuan kontrasepsi mereka. Teknik lain untuk membantu penyedia layanan dalam memperkenalkan pencegahan prakonsepsi ke dalam kunjungan layanan primer. Teknik seperti ini memungkinkan penyedia layanan dan pasien mengembangkan rencana untuk mengoptimalkan potensi kesehatan setiap klien secara keseluruhan, berkontribusi terhadap pencegahan penyakit dan promosi kesehatan.

b. Strategi kegagalan kontrasepsi

Pencegahan primer harus mencakup rencana untuk mencegah kegagalan metode kontrasepsi. Strategi pencegahan utama yang dapat membantu keberhasilan penggunaan metode kontrasepsi yaitu memberikan paket kontrasepsi oral dalam jumlah lebih banyak kepada pasien dikaitkan dengan tingkat kelanjutan yang lebih tinggi dan penurunan kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi. Penggunaan kontrasepsi jangka panjang yang dapat dibalik seperti kontrasepsi implan atau kontrasepsi intrauterin

menggabungkan kemudahan penggunaan dan tingkat kemanjuran yang sangat tinggi untuk menciptakan tingkat kelanjutan yang lebih baik dibandingkan kontrasepsi oral. Metode-metode ini juga merupakan pilihan bagi perempuan yang mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan metode penghalang atau kontrasepsi oral secara konsisten. Dengan mendiskusikan rencana reproduksi pasien dan mengevaluasi metode yang tersedia, dokter mungkin akan lebih efektif dalam memberikan pencegahan primer terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Pencegahan primer kehamilan yang tidak diinginkan berpotensi bermanfaat sebagai metode penghematan biaya selain meningkatkan hasil perinatal.

Strategi pencegahan primer salah satunya adalah program berbasis sekolah yang disampaikan melalui platform sekolah terutama berfokus pada risiko psikososial dan faktor perlindungan yang melibatkan seksualitas (Mohamed et al., 2023). Strategi pencegahan primer ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja perempuan dan laki-laki tentang kesehatan reproduksi seksual mereka dan mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan (M. Taylor et al., 2014). Memanfaatkan platform sekolah untuk melakukan intervensi membantu memastikan bahwa siswa memiliki ruang yang aman untuk belajar tentang seksualitas mereka, pencegahan kehamilan dan penularan penyakit menular seksual, dan di mana mengakses layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Selain itu, program berbasis sekolah memungkinkan remaja untuk terlibat dengan topik-topik ini dalam forum yang dapat diterima secara sosial. Penyampaian pendidikan seks melalui sekolah memastikan lebih banyak remaja yang dijangkau sebelum debut seksual mereka (Mantell et al., 2006)

Selain itu pembelajaran berbasis klinik dan komunitas (yaitu, mendirikan klub kesehatan untuk mendidik tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas dan memfasilitasi rujukan ke klinik, klinik kesehatan keliling untuk remaja dan layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas di pusat remaja) cenderung memasukkan unsur-unsur program pendidikan, tidak seperti intervensi berbasis sekolah, sesi-sesi ini juga dapat diberikan secara terpisah sebagai intervensi yang berdiri sendiri baik di dalam klinik maupun di luar komunitas yang lebih luas, untuk mencakup remaja putus sekolah. Intervensi ini juga meningkatkan akses terhadap layanan keluarga berencana bagi remaja, meningkatkan pengetahuan remaja tentang metode dan menghilangkan kesalahpahaman. Kegiatan yang mempromosikan kontrasepsi di masyarakat juga dapat berupaya untuk mengubah norma-norma sosial dalam masyarakat yang menghambat penggunaan metode kontrasepsi, yang juga memfasilitasi penerimaan program

pendidikan seks di sekolah, penciptaan layanan ramah remaja dan promosi serta distribusi metode kontrasepsi (Ross et al., 2007)

Intervensi pembangunan remaja tidak hanya fokus pada kebutuhan kesehatan seksual dari populasi sasaran tetapi juga memenuhi kebutuhan ini dalam sebuah program yang mencoba mengatasi isu-isu lintas sektoral lainnya melalui pengembangan keterampilan dan pendampingan. Keberhasilan program-program ini bergantung pada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti sekolah, kelompok agama, masyarakat, petugas kesehatan dan remaja. Selain itu, pelaksana harus memastikan intervensi tersebut bersifat praktis, sesuai dengan budaya dan berbasis bukti (Oringanje et al., 2016).

Intervensi pencegahan kehamilan remaja yang mencakup pendidikan seks dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. Membangun keterampilan; *Intervensi yang memberikan instruksi, praktik atau kegiatan lain yang dirancang untuk membantu kelompok sasaran membangun dan meningkatkan keterampilan mereka, misalnya guru memberikan kelas SRH atau bimbingan akademis yang lebih baik untuk remaja.*
- b. Interaktif; *Intervensi didasarkan pada prinsip keterlibatan siswa, yang memerlukan keseimbangan antara suara siswa dan guru. Siswa dan guru sama-sama terlibat dalam pembelajaran.*
- c. Dipimpin oleh rekan sejawat; *Intervensi yang menggunakan metode pengajaran atau fasilitasi promosi kesehatan yang meminta masyarakat untuk menyampaikan pesan kesehatan tertentu kepada anggota komunitasnya.*
- d. Menunda debut seksual; *Intervensi bertujuan untuk mempengaruhi waktu atau membantu remaja dalam menunda inisiasi seksual.*
- e. Pantang; *Intervensi yang secara aktif menghambat seks sebelum menikah.*
- f. Penyuluhan; *Intervensi yang menggunakan terapi bicara dengan tenaga profesional terlatih untuk membantu klien mengatasi kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksinya.*
- g. Paparan tanggung jawab orang tua; *Intervensi yang memaparkan remaja pada realitas menjadi orang tua, yaitu mengasuh anak.*
- h. Pemberian informasi; *Intervensi yang terfokus pada pemberian informasi saja*
- i. Durasi, frekuensi dan intensitas intervensi pencegahan kehamilan remaja

2. Strategi Penatalaksanaan Sekunder

Pencegahan sekunder ditujukan untuk mendeteksi penyakit sebelum pasien menunjukkan gejala, melibatkan tes skrining, diagnosis kehamilan dini dan konseling mengenai pilihan kehamilan, termasuk akses terhadap layanan aborsi yang aman, mencakup intervensi untuk memungkinkan deteksi dini kehamilan dan membantu penyediaan layanan sedini mungkin pada kehamilan yang tidak

diinginkan, intervensi untuk menghindari terulangnya kondisi medis yang didiagnosis, perawatan juga akan diarahkan pada pencegahan terulangnya kehamilan yang tidak diinginkan. Selain pencegahan penyakit, pencegahan sekunder juga penting dalam meningkatkan kesehatan melalui konseling dan koordinasi perawatan yang memadai mengenai pilihan kehamilan yang tidak diinginkan.

Strategi dan layanan pencegahan sekunder yang penting yaitu:

- a. Strategi deteksi kehamilan dini. Pencegahan sekunder dengan tujuan deteksi dini kehamilan yang tidak diinginkan adalah penting bagi perempuan, apa pun pilihan hasil kehamilannya. Jika seorang perempuan tidak yakin dengan keputusannya, deteksi dini kehamilan akan memberinya waktu untuk mempertimbangkan informasi penting yang diberikan selama konseling pilihan. Deteksi dini kehamilan yang tidak diinginkan dan konseling pilihan yang menyeluruh dan cepat memberikan setiap perempuan kesempatan untuk mempertimbangkan dan memilih hasil (misalnya melanjutkan kehamilan, adopsi, atau penghentian kehamilan) yang terbaik bagi dirinya dan keluarga atau situasinya. Deteksi dini terhadap kehamilan yang tidak diinginkan memungkinkan seorang perempuan untuk menerima skrining dini yang tepat untuk mengetahui risiko atau paparan prakonsepsi atau memungkinkan seorang perempuan untuk mengakses aborsi, sebuah prosedur umum yang aman dan memiliki risiko yang lebih kecil jika dilakukan pada awal kehamilan. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap keterlambatan dalam melakukan upaya terminasi kehamilan adalah perempuan sering kali harus mengoordinasikan pembayaran untuk prosedur aborsi mereka, ketakutan akan prosedur aborsi, kesulitan menemukan penyedia aborsi, dan kurangnya kesadaran akan perlunya tes kehamilan (Kiley et al., 2010).
- b. Meningkatkan strategi interval kehamilan berulang.
Pencegahan sekunder yang efektif terhadap kehamilan yang tidak diinginkan tidak terbatas pada diagnosis, pilihan konseling, dan koordinasi perawatan. Kesadaran akan perlunya skrining kehamilan, terlepas dari apakah hasil tesnya positif atau negatif, memberikan kesempatan kepada penyedia layanan kesehatan primer untuk memberikan edukasi guna mendiskusikan faktor risiko kehamilan yang tidak diinginkan, rencana kehidupan reproduksi, dan pilihan kontrasepsi.

3. Strategi Penatalaksanaan Tersier

Pencegahan efek samping yang berhubungan dengan kehamilan yang tidak diinginkan, misalnya pengobatan aborsi tidak lengkap; akses terhadap layanan untuk trauma psikososial; dan pelayanan antenatal dan pelayanan bersalin untuk

mencegah kesakitan dan kematian ibu. Pencegahan tersier secara umum didefinisikan sebagai intervensi untuk meringankan gejala suatu penyakit klinis dan tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan gejala sisa dari suatu penyakit atau penyakit (D. Taylor et al., 2010; D. Taylor & James, 2011). Ketika diterapkan pada kehamilan yang tidak diinginkan, pencegahan tersier mencakup diagnosis dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kehamilan yang tidak diinginkan dan bukan hanya terjadi pada waktu yang tidak tepat diketahui memiliki risiko lebih besar terhadap hasil perinatal yang buruk seperti depresi ibu dan penelantaran bayi. Wanita dengan kehamilan yang tidak diinginkan pada usia lanjut kemungkinan besar memerlukan penilaian psikososial, konseling krisis dan/atau koordinasi perawatan untuk mengatasi kehamilan yang tidak diinginkan hingga cukup bulan. Bagi perempuan yang tidak ingin melanjutkan kehamilannya, rujukan dan pilihan mengenai terminasi kehamilan harus diberikan tepat waktu karena keterlambatan dalam mendapatkan perawatan dikaitkan dengan peningkatan risiko pada ibu.

Pencegahan tersier terhadap kehamilan yang tidak diinginkan adalah bidang di mana asuhan keperawatan dapat memberikan perbedaan penting pada hasil akhir pasien. Karena perawat mahir dalam pendidikan kesehatan, perawatan psikososial, dan koordinasi perawatan. Oleh karena itu, upaya pencegahan tersier tidak akan selesai jika seorang perempuan telah memilih hasil dari kehamilan yang tidak diinginkan. Mengoordinasikan dan memastikan perawatan dan/atau rujukan yang tepat sangatlah penting seperti kebutuhan kontrasepsi segera setelah melahirkan atau aborsi merupakan tanggung jawab spesialis kesehatan reproduksi dan penyedia layanan kesehatan primer. Pemasangan segera alat kontrasepsi intrauterin dan diskusi mengenai pilihan kontrasepsi dengan penyedia layanan pada periode pasca operasi atau pasca melahirkan meningkatkan kemungkinan seorang wanita akan memilih alat kontrasepsi yang sangat efektif dan menggunakannya dengan benar

C. Pentingnya Nutrisi pada Wanita di Semua Usia

Nutrisi adalah zat gizi yang didapatkan dari makanan dan minuman yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan sel dalam tubuh manusia. Nutrisi yang baik dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nutrisi terbagi menjadi dua kategori, yaitu makronutrien (zat gizi makro) dan mikronutrien (zat gizi mikro). Zat gizi makro dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar seperti karbohidrat, protein, lemak, dan serat yang dibutuhkan tubuh dalam satuan gram per hari. Sedangkan

zat gizi mikro dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil yaitu vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh dalam satuan milligram per hari.

Zat gizi makro diperlukan tubuh sebagai sumber energi, sedangkan zat gizi mikro diperlukan untuk membantu tubuh memproduksi enzim, hormon, dan zat lainnya. Jumlah kebutuhan zat gizi makro dan mikro setiap orang berbeda-beda tergantung pada usianya.

D. Kesimpulan

Permasalahan kesehatan reproduksi pada perempuan usia subur meliputi tingginya WUS usia remaja, rendahnya tingkat partisipasi penggunaan KB sehingga meningkatnya fertilisasi. Kehamilan remaja masih menjadi permasalahan utama di kalangan remaja pengungsi. Seks bebas dan keputusan menikah di usia muda menjadi alasan utama tingginya kehamilan remaja. Hal ini diperburuk dengan benturan budaya dan kesadaran menggunakan kontrasepsi yang masih rendah. Kompleksitas permasalahan kesehatan reproduksi yang disajikan dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan strategi yang efektif terkait penyediaan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif bagi komunitas perempuan. Oleh karena itu penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) Mengembangkan dan menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan kongruen secara budaya termasuk perawatan prenatal dan keluarga berencana; 2) Mengadvokasi lingkungan yang toleran untuk mengurangi stigmatisasi di komunitas pengungsi.

E. Referensi

- Kemenkes. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi untuk Masyarakat Indonesia.
- Kemenkes. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang.
- Ardianti, I. (2019). Pemberian Edukasi Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Wanita Usia Subur Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Humanis*, 3(1), 25–29.
- Aslam, R. W., Hendry, M., Booth, A., Carter, B., Charles, J. M., Craine, N., Edwards, R. T., Noyes, J., Ntambwe, L. I., Pasterfield, D., Rycroft-Malone, J., Williams, N., & Whitaker, R. (2017). Intervention Now to Eliminate Repeat Unintended Pregnancy in Teenagers (INTERUPT): A systematic review of intervention effectiveness and cost-effectiveness, and qualitative and realist synthesis of implementation factors and user engagement. *BMC Medicine*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12916-017-0904-7>
- Barnes, D. M., & Harrison, C. L. (2004). Refugee women's reproductive health in early

- resettlement. *JOGNN - Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing*, 33(6), 723–728. <https://doi.org/10.1177/0884217504270668>
- Biswas, K. K., Hossain, A., Chowdhury, R., Andersen, K., Sultana, S., Shahidullah, S. M., & Pearson, E. (2017). Using mHealth to support postabortion contraceptive use: Results from a feasibility study in urban Bangladesh. *JMIR Formative Research*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.2196/FORMATIVE.5151>
- Chen, H. H., Lee, C., Huang, J., Chi, L., & Hsiung, Y. (2021). Effect of an mHealth-Based Intervention on Excessive Gestational Weight Gain Prevention among Overweight and Obese Women : A Randomized Controlled Trial Table of Contents. *JMIR Preprints*.
- Drummond, P. D., Mizan, A., Brocx, K., & Wright, B. (2011). Barriers to accessing health care services for West African refugee women living in Western Australia. *Health Care for Women International*, 32(3), 206–224. <https://doi.org/10.1080/07399332.2010.529216>
- Fitriana Putri, U., Ratu, M., & Sri, S. (2020). Akses Pasangan Usia Subur (PUS) Miskin terhadap Informasi Keluarga Berencana (KB) di Kota Yogyakarta. *Populasi*, 28(1), 63. <https://doi.org/10.22146/jp.59620>
- Gagnon, A. J., Merry, L., & Robinson, C. (2002). A Systematic Review of Refugee Women's Reproductive Health. *Refugee*, 21(1), 6–17. <https://doi.org/10.25071/1920-7336.21279>
- Gray, N., Azzopardi, P., Kennedy, E., Willersdorf, E., & Creati, M. (2013). Improving adolescent reproductive health in Asia and the Pacific: Do we have the data? A review of DHS and MICS surveys in nine countries. *Asia-Pacific Journal of Public Health*, 25(2), 134–144. <https://doi.org/10.1177/1010539511417423>
- Harrington, E. K., Drake, A. L., Matemo, D., Ronen, K., Osoti, A. O., John-Stewart, G., Kinuthia, J., & Unger, J. A. (2019). An mHealth SMS intervention on Postpartum Contraceptive Use among Women and Couples in Kenya: A randomized controlled trial. *American Journal of Public Health*, 109(6), 934–941. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2019.305051>
- Indraswari, N., Sari, A. N., & Susanti, A. I. (2021). Gambaran Penggunaan Kontrasepsi Modern di Jawa Barat Berdasarkan Karakteristik Sosiodemografi dan Sumber Informasi. *Jurnal Menara Medika*, 3(1), 176–186. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menaramedika/article/view/2199&ved=2ahUKEwja66i_paDtAhU263MBHdUiAsUQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw0bUdEhasRIBe0InxidIHJo
- Janssens, K., Bosmans, M., Leye, E., & Temmerman, M. (2006). Sexual and reproductive health of asylum-seeking and refugee women in europe:

- Entitlements and access to health services. *Journal of Global Ethics*, 2(2), 183–196. <https://doi.org/10.1080/17449620600948002>
- Johnson, D., Juras, R., Riley, P., Chatterji, M., Sloane, P., Choi, S. K., & Johns, B. (2017). A randomized controlled trial of the impact of a family planning mHealth service on knowledge and use of contraception. *Contraception*, 95(1), 90–97. <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2016.07.009>
- Kiley, J. W., Yee, L. M., Niemi, C. M., Feinglass, J. M., & Simon, M. A. (2010). Delays in request for pregnancy termination: comparison of patients in the first and second trimesters. *Contraception*, 81(5), 446–451. <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2009.12.021>
- Mantell, J. E., Harrison, A., Hoffman, S., Smit, J. A., Stein, Z. A., & Exner, T. M. (2006). The Mpondombili Project: Preventing HIV/AIDS and Unintended Pregnancy among Rural South African School-Going Adolescents. *Reproductive Health Matters*, 14(28), 113–122. [https://doi.org/10.1016/S0968-8080\(06\)28269-7](https://doi.org/10.1016/S0968-8080(06)28269-7)
- Maslowsky, J., Frost, S., Hendrick, C. E., Trujillo Cruz, F. O., & Merajver, S. D. (2016). Effects of postpartum mobile phone-based education on maternal and infant health in Ecuador. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, 134(1), 93–98. <https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2015.12.008>
- McCarthy, O., Ahamed, I., Kulaeva, F., Tokhirov, R., Saibov, S., Vandewiele, M., Standaert, S., Leurent, B., Edwards, P., Palmer, M., & Free, C. (2018). Erratum: Correction to: A randomized controlled trial of an intervention delivered by mobile phone app instant messaging to increase the acceptability of effective contraception among young people in Tajikistan (Reproductive health (2018) 15 1 (28)). *Reproductive Health*, 15(1), 52. <https://doi.org/10.1186/s12978-018-0496-5>
- McCarthy, O. L., Zghayyer, H., Stavridis, A., Adada, S., Ahamed, I., Leurent, B., Edwards, P., Palmer, M., & Free, C. (2019). An intervention delivered by mobile phone instant messaging to increase acceptability and use of effective contraception among Young Women in Bolivia: Randomized controlled trial. *Journal of Medical Internet Research*, 20(228), 1–13. <https://doi.org/10.2196/14073>
- Meo, M. L. N., & Nahak, M. P. M. (2020). Problem Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur Eks Pengungsi Timor Timur. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkr.47128>
- Mohamed, S., Chipeta, M. G., Kamninga, T., Nthakomwa, L., Chifungo, C., Mzembe, T., Vellemu, R., Chikwapulo, V., Peterson, M., Abdullahi, L., Musau, K., Wazny, K., Zulu, E., & Madise, N. (2023). Interventions to prevent unintended pregnancies among adolescents: a rapid overview of systematic reviews. *Systematic Reviews*, 12(1), 1–19.

<https://doi.org/10.1186/s13643-023-02361-8>

- Oles, W., Alexander, M., Negron, R., Nelson, J., Iriarte, E., Airoidi, E. M., Christakis, N. A., & Forastiere, L. (2024). Maternal and child health intervention to promote behaviour change: a population-level cluster-randomised controlled trial in Honduras. In *BMJ Open* (Vol. 14, Issue 6). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-060784>
- Oringanje, C., Meremikwu, M. M., Eko, H., Esu, E., Meremikwu, A., Ehiri, J. E., & IGDP. (2016). Interventions for preventing unintended pregnancies among adolescents. *Cochrane Library*, 1–106. <https://doi.org/10.7196/SAMJ.2020.v110i1.14281>
- Palareti, G., Legnani, C., Cosmi, B., Antonucci, E., Erba, N., Poli, D., Testa, S., & Tosi, A. (2016). Comparison between different D-Dimer cutoff values to assess the individual risk of recurrent venous thromboembolism: Analysis of results obtained in the DULCIS study. *International Journal of Laboratory Hematology*, 38(1), 42–49. <https://doi.org/10.1111/ijlh.12426>
- Ross, D. A., Chagalucha, J., Obasi, A. I. N., Todd, J., Plummer, M. L., Cleophas-Mazige, B., Anemona, A., Everett, D., Weiss, H. A., Mabey, D. C., Grosskurth, H., & Hayes, R. J. (2007). Biological and behavioural impact of an adolescent sexual health intervention in Tanzania: A community-randomized trial. *Aids*, 21(14), 1943–1955. <https://doi.org/10.1097/QAD.0b013e3282ed3cf5>
- Shegaw, G., Mohammed, A. A., Nadew, K., Tamrat, K., Zeru, G., Desta, H., & Yinager, W. (2014). Long Acting Contraceptive Method Utilization and Associated Factors among Reproductive Age Women in Arba Minch Town, Ethiopia. *Greener Journal of Epidemiology and Public Health*, 2(1), 023–031. <https://doi.org/10.15580/gjeph.2014.1.070514294>
- Smith, C., Ngo, T. D., Gold, J., Edwards, P., Vannak, U., Sokhey, L., Machiyama, K., Slaymaker, E., Warnock, R., McCarthy, O., & Free, C. (2015). Effet d'une intervention par téléphone portable sur la contraception après avortement: Essai contrôlé randomisé au Cambodge. *Bulletin of the World Health Organization*, 93(12), 842–850. <https://doi.org/10.2471/BLT.15.160267>
- Smith, H. J., Portela, A. G., & Marston, C. (2017). Improving implementation of health promotion interventions for maternal and newborn health. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 17(1), 2–7. <https://doi.org/10.1186/s12884-017-1450-1>
- Taylor, D., & James, E. A. (2011). An Evidence-Based Guideline for Unintended Pregnancy Prevention. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs*, 40(6), 782–793. <https://doi.org/doi:10.1111/j.1552-6909.2011.01296.x>

- Taylor, D., Levi, A., & Simmonds, K. (2010). Reframing unintended pregnancy prevention: a public health model. *Contraception*, 81(5), 363–366. <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2010.01.023>
- Taylor, M., Jinabhai, C., Dlamini, S., Sathiparsad, R., Eggers, M. S., & De Vries, H. (2014). Effects of a Teenage Pregnancy Prevention Program in KwaZulu-Natal, South Africa. *Health Care for Women International*, 35(7–9), 845–858. <https://doi.org/10.1080/07399332.2014.910216>
- Unger, J. A., Ronen, K., Perrier, T., DeRenzi, B., Slyker, J., Drake, A. L., Mogaka, D., Kinuthia, J., & John-Stewart, G. (2018). Short message service communication improves exclusive breastfeeding and early postpartum contraception in a low- to middle-income country setting: a randomised trial. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 125(12), 1620–1629. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.15337>
- Wati, M., Mariati, N., Rahmah, A., & Prabawati, S. A. (2023). Edukasi Kesehatan Reproduksi Sebagai Upaya Peningkatan Kepedulian Terhadap Kesehatan Wanita Usia Subur. *Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 41–53. <https://doi.org/10.30651/hm.v4i1.16121>
- WHO. (2011). WHO Guidelines on Preventing Early Pregnancy and Poor Reproductive Outcomes. *World Health Organization*, 192. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502214_eng.pdf?ua=1
- World Health Organisation. (2005). Report of a WHO technical consultation on birth spacing. *Report of a WHO Technical Consultation on Birth Spacing*, 13(6), 1–44. http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/birth_spacing
- Yani, V. D., Emilia, O., & Kusnanto, H. (2014). Persepsi Remaja Terhadap Faktor Penghambat Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Di Puskesmas Gambok Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 1(1), 34–45. <https://doi.org/10.22146/jkr.4913>

F. Glosarium

WUS = Wanita Usia Subur

CHAPTER 8

PERAWATAN KESEHATAN WANITA HAMIL: PEMANTAUAN DAN EDUKASI SELAMA KEHAMILAN

Hardiningsih, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991-2020 yaitu dari 390 menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup (Kementrian Kesehatan RI, 2024). Meskipun terjadi kecenderungan penurunan angka kematian ibu tetap diperlukan upaya dalam percepatan penurunan AKI untuk mencapai target SDG's yaitu sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (Kementrian Kesehatan RI, 2024). Sedangkan untuk jumlah kematian ibu di tahun 2023 yaitu sebesar 4.482 jiwa, meningkat dari tahun 2022 yaitu sebesar 3.572 jiwa (Kementrian Kesehatan RI, 2024).

Salah satu lingkup kesehatan reproduksi yang penting dilakukan pemantauan adalah kesehatan ibu selama kehamilan (Permenkes, 2021). Berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 disampaikan bahwa proporsi faktor risiko kehamilan pada perempuan umur 10-54 tahun di Indonesia yaitu sebanyak 15,6% mempunyai faktor risiko, 58,1% tidak mempunyai faktor risiko dan sisanya sebanyak 26,3% tidak ada catatan. Faktor risiko kehamilan tersebut meliputi obesitas, anemia, diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, kekurangan energi kronis dan lainnya (Kementrian Kesehatan RI, 2023). Hipertensi dalam kehamilan merupakan salah satu penyebab kematian ibu terbanyak pada tahun 2023 yaitu sebanyak 412 kasus (Kementrian Kesehatan RI, 2024). Upaya percepatan penurunan AKI perlu dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti salah satunya adalah pelayanan kesehatan (pemantauan) ibu hamil (Kementrian Kesehatan RI, 2024).

Pelayanan kesehatan masa hamil seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2021 pasal 13 disebutkan bahwa pelayanan kesehatan masa hamil bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas (Permenkes, 2021). Ibu hamil harus mendapat pelayanan oleh

tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan (pemantauan) ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang jenis pelayanannya dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua dan trimester ketiga (Kementrian Kesehatan RI, 2024).

B. Pemantauan Selama Kehamilan

Pemantauan selama kehamilan dilakukan mulai sejak terjadinya masa konsepsi sampai dengan sebelum mulai persalinan, pemantauan selama kehamilan harus dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkualitas (Permenkes, 2021). Pemantauan selama kehamilan memiliki tujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil agar memperoleh pelayanan antenatal yang komprehensif dan berkualitas sehingga ibu hamil dapat menjalani kehamilan dan persalinan dengan pengalaman yang bersifat positif serta melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas (Permenkes, 2021). Pengalaman yang bersifat positif adalah pengalaman yang menyenangkan dan memberikan nilai tambah yang bermanfaat bagi ibu hamil dalam menjalankan perannya sebagai perempuan, istri dan ibu (Permenkes, 2021).

Pemantauan selama kehamilan melalui perawatan antenatal (ANC) yang berkualitas dapat digunakan untuk melakukan skrining dan identifikasi dini komplikasi terkait kehamilan seperti pre eklampsia, anemia dan diabetes gestasional, dengan adanya pemantauan ini maka kasus keterlambatan atau kegagalan diagnosis dapat dicegah sehingga angka morbiditas dan angka mortalitas pada ibu dapat dikurangi (Abejirinde et al., 2018). Pemantauan kehamilan merupakan peran tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan berkelanjutan yang diperlukan oleh ibu hamil selama perawatan kehamilannya (Abejirinde et al., 2018).

Pemantauan selama kehamilan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui pemeriksaan kehamilan. Ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan 3 dengan rincian sebagai berikut (Kemenkes, 2023) :

1. Satu kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester pertama kehamilan hingga usia kehamilan 12 minggu
2. Dua kali pemeriksaan pada trimester kedua)kehamilan di atas 12 minggu sampai 24 minggu)
3. Tiga kali pemeriksaan pada trimester ketiga (kehamilan di atas 24 minggu sampai 40 minggu), dengan salah satu diantaranya dilakukan oleh dokter.

Ibu hamil tidak semuanya bersedia melakukan pemantauan kehamilan atau kunjungan ANC sesuai dengan anjuran pemerintah. Hasil penelitian menyampaikan bahwa waktu yang tepat untuk melakukan ANC bergantung pada kepedulian ibu hamil tersebut terhadap kehamilannya. Ibu hamil yang menyadari kehamilannya

lebih awal, maka akan melakukan ANC sejak awal kehamilan (Jinga et al., 2019). Beberapa alasan mengenai ibu hamil terlambat melakukan pemantauan kehamilan melalui kunjungan ANC antara lain kebutuhan yang dirasakan oleh ibu hamil untuk merahasiakan kehamilan yang masih dini, adanya penundaan untuk ANC yang disengaja oleh wanita multigravida, kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan dan ANC, adanya biaya yang diperhitungkan oleh ibu hamil, adanya rasa enggan untuk memeriksakan di klinik karena kepadatan pasien dan adanya antrian sehingga membuat ibu hamil lebih memilih perawatan tradisional daripada ANC (Jinga et al., 2019). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 (Permenkes, 2021) pemantauan selama kehamilan tersebut perlu dilakukan karena kemungkinan akan muncul masalah yang akan dialami oleh ibu hamil antara lain :

1. Masalah gizi, seperti anemia, KEK (Kekurangan Energi Kronik), obesitas, kenaikan berat badan tidak sesuai standar
2. Faktor risiko, yaitu usia ibu ≤ 16 tahun, usia ibu ≥ 35 tahun, anak terkecil ≤ 2 tahun, hamil pertama ≥ 4 tahun, interval kehamilan > 10 tahun, persalinan ≥ 4 kali, gemelli/ kehamilan ganda, kelainan letak dan posisi janin, kelainan besar janin, riwayat obstetrik jelek (keguguran/ gagal kehamilan), komplikasi pada persalinan yang lalu (riwayat vakum/ forsep, riwayat perdarahan pascapersalinan dan atau transfusi), riwayat bedah sesar, hipertensi, kehamilan > 40 minggu
3. Komplikasi kebidanan yang meliputi : ketuban pecah dini, perdarahan pervaginam, hipertensi dalam kehamilan/ pre eklampsia/ eklampsia, ancaman persalinan prematur, distosia, placenta previa, dll
4. Penyakit tidak menular antara lain : hipertensi, diabetes melitus, kelainan jantung, ginjal, asma, kanker, epilepsi, gangguan autoimun, dll
5. Penyakit menular seperti HIV, sifilis, hepatitis, malaria, TB, demam berdarah, tifus abdominalis, dll
6. Masalah kejiwaan, misalnya : depresi, gangguan kecemasan, psikosis, skizofrenia

Selain pemantauan kehamilan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ANC, Ibu hamil juga dapat melakukan pemantauan sendiri kondisinya yang dilakukan setiap minggunya, sehingga jika menemukan masalah maka ibu hamil dapat segera menghubungi atau mengunjungi tenaga kesehatan atau tempat pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut antara lain (Kemenkes, 2023) :

1. Demam lebih dari dua hari
2. Pusing/ sakit kepala berat
3. Sulit tidur/ cemas berlebihan
4. Jantung berdebar-debar atau nyeri di dada
5. Risiko TB (terdapat batuk lebih dari 2 minggu atau kontak serumah dengan penderita TB)

6. Tidak ada gerakan janin atau gerakan janin < 10 kali dalam 12 jam
7. Mengalami nyeri perut hebat
8. Keluar cairan dari jalan lahir yang sangat banyak atau berbau
9. Sakit saat kencing atau keluar keputihan atau gatal di daerah kemaluan
10. Diare berulang

Pemantauan selama kehamilan melalui pelayanan pemeriksaan kehamilan ANC harus memenuhi standar pelayanan antenatal yang meliputi 10T yaitu (Permenkes, 2021) :

1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan
 - a. Mengukur tinggi badan ibu untuk menentukan status gizi dan risiko persalinan
 - b. Memantau kenaikan berat badan sesuai dengan grafik peningkatan berat badan
2. Ukur tekanan darah, untuk mengetahui ada/ tidaknya hipertensi (jika tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg)
3. Nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas/ LiLA), untuk mengetahui ibu hamil mengalami risiko Kurang Energi Kronik (KEK) jika LiLA <23,5 cm
4. Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri)
5. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ), untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan janin dan melihat kelainan letak janin atau masalah lainnya
6. Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan
7. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Tablet tambah darah yang dikonsumsi oleh ibu hamil harus mengandung sedikitnya 60 mg zat besi dan 400 mcg asam folat
8. Tes laboratorium yang meliputi tes kehamilan, kadar hemoglobin darah, golongan darah, tes triple eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B), malaria pada daerah endemis. Tes lainnya dapat dilakukan sesuai indikasi seperti glukoprotein urin, gula darah sewaktu, sputum Basil Tahan Asam (BTA), kusta, malaria daerah non endemis, pemeriksaan feses untuk kecacingan, pemeriksaan darah lengkap untuk deteksi dini talasemia dan pemeriksaan lainnya serta pemeriksaan USG untuk deteksi kondisi kehamilan dan janin
9. Tata laksana/ penanganan kasus sesuai kewenangan yaitu apabila ditemukan masalah maka segera ditangani atau lakukan rujukan
10. Temu wicara (konseling) yang dilakukan pada saat ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan. Informasi yang disampaikan saat konseling minimal meliputi hasil pemeriksaan, perawatan sesuai usia kehamilan dan usia ibu, gizi

ibu hamil, kesiapan mental, mengenali tanda bahaya kehamilan, persalinan dan nifas, persiapan persalinan, kontrasepsi pascapersalinan, perawatan bayi baru lahir, inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif

C. Edukasi Selama Kehamilan

1. Kelas Ibu Hamil

Kelas ibu hamil merupakan sarana belajar kelompok tentang kesehatan bagi ibu hamil dalam bentuk tatap muka/ online yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, persalinan, perawatan nifas dan perawatan bayi baru lahir melalui praktik dengan menggunakan buku KIA yang difasilitasi oleh petugas kesehatan dan kelas ibu hamil ini dapat diikuti oleh ibu hamil dengan semua usia kehamilan (Budiarti et al., 2018). Kelas ibu hamil merupakan solusi untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan ibu hamil tentang perawatan kehamilan dan risiko komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan, persalinan dan nifas (Patriajati & Sriatmi, 2019). Seperti hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil memiliki pengetahuan dan sikap yang lebih baik dibandingkan dengan ibu hamil yang enggan mengikuti kelas ibu hamil, ibu hamil yang aktif mengikuti kelas ibu hamil lebih memahami mengenai tanda bahaya kehamilan dan persiapan persalinan, ibu hamil akan lebih waspada terhadap kehamilannya dan akan segera mencari pertolongan jika terjadi sesuatu pada kehamilannya (Sasnitari & Puspitasari, 2017).

Kelas ibu hamil dilakukan sebanyak 4 kali selama kehamilan, pada masing-masing pertemuan akan membicarakan hal yang berbeda-beda selama kurang lebih 2 jam, untuk itu maka ibu hamil sebaiknya mengikuti setiap kelas secara lengkap agar kondisi kehamilan ibu dapat terus terpantau perkembangannya (Budiarti et al., 2018). Kegiatan kelas ibu hamil ini juga berorientasi untuk meningkatkan kepatuhan ibu dalam kunjungan perawatan antenatal secara rutin, serta kelas ibu hamil juga memiliki prinsip pemberdayaan masyarakat karena melibatkan peran dan partisipasi ibu hamil, keberhasilan kelas ibu hamil ditentukan oleh seberapa banyak ibu hamil yang hadir dan terlibat dalam berbagai kegiatan (Patriajati & Sriatmi, 2019). Jumlah peserta ibu hamil dalam satu kelas ibu hamil maksimal 10 orang melalui koordinasi dengan tenaga kesehatan di puskesmas (Budiarti et al., 2018).

Hasil penelitian di Semarang tentang keikutsertaan ibu hamil dalam kelas ibu hamil menunjukkan bahwa hanya 54,3% ibu yang mengikuti kelas ibu hamil, hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pengetahuan, dukungan petugas

kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana serta riwayat penyakit dan riwayat kehamilan sebelumnya (Patriaajati & Sriatmi, 2019).

Melihat pentingnya kelas ibu hamil, maka perlu membangun persepsi positif ibu hamil terhadap kelas ibu hamil, diperlukan dukungan petugas kesehatan melalui komunikasi persuasif, pendampingan dan model empati, puskesmas dapat memberikan pelatihan tentang kesehatan kepada petugas KIA, penyelenggara program kesehatan (khususnya program KIA) perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif dengan menggunakan media yang menarik dan atraktif, serta mereka perlu mengadvokasi dukungan fasilitas bagi para pemimpin masyarakat seperti pejabat daerah, pemimpin agama dan tokoh masyarakat setempat (Patriaajati & Sriatmi, 2019). Penelitian sejenis juga dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Krui Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023, penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 56,9% responden aktif mengikuti kelas ibu hamil dan sebanyak 54,9% responden memiliki pengetahuan baik, hal ini berarti ada hubungan antara keikutsertaan ibu dalam kelas ibu hamil dengan pembelajaran tentang kehamilan dan persalinan. Sehingga ibu hamil diharapkan dapat aktif mengikuti kelas ibu hamil untuk meningkatkan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan (Febrianti et al., 2023)

2. Tanda Bahaya Kehamilan

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu upaya untuk menilai derajat kesehatan masyarakat, salah satu masalah yang berkaitan dengan kematian ibu adalah masalah kehamilan yang sebaiknya dihindari. Masalah kehamilan seperti ini dapat dideteksi sejak dini dari adanya tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Oleh karena itu diperlukan edukasi tentang tanda bahaya kehamilan kepada ibu hamil (Triguno et al., 2021). Tanda-tanda bahaya pada kehamilan meliputi nyeri ulu hati dan atau mual muntah serta tidak mau makan; demam tinggi; sakit kepala dan atau pandangan kabur dan atau kejang disertai atau tanpa bengkak pada kaki, tangan dan wajah; janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya; air ketuban keluar sebelum waktunya dan terjadi perdarahan pada hamil muda atau hamil tua (Kemenkes, 2023). Jika ibu hamil menemui salah satu atau lebih tanda bahaya/ masalah lain pada masa kehamilan maka segera bawa ibu hamil ke tempat pelayanan kesehatan (rumah sakit) (Kemenkes, 2023).

Pemberian penyuluhan atau edukasi tentang tanda bahaya kehamilan dapat meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan pada ibu primipara dan multipara, edukasi ini diberikan dengan menerapkan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab dengan ibu hamil serta menggunakan media berupa leaflet yang juga dapat mempengaruhi keberhasilan pemberian materi tersebut kepada ibu hamil (Triguno et al., 2021). Edukasi tentang tanda-tanda

bahaya kehamilan juga dilakukan di Posyandu Sampar Maras Desa Kanar melalui penyuluhan, sebelum dilakukan penyuluhan terdapat 33% ibu hamil memiliki pengetahuan baik tentang tanda bahaya kehamilan dan setelah dilakukan penyuluhan terdapat peningkatan menjadi 80% dengan pengetahuan baik. Melalui edukasi tentang tanda bahaya kehamilan dapat meningkatkan pengetahuan pada ibu hamil, diharapkan ibu hamil apabila mengalami tanda bahaya kehamilan dapat terdeteksi secara dini sehingga mengurangi risiko komplikasi pada ibu hamil (Retnaningtyas, Siwi, et al., 2022).

3. Nutrisi pada Ibu Hamil

Seorang ibu hamil harus mempunyai status gizi yang baik dan mengonsumsi makanan yang beranekaragam baik proporsi maupun jumlahnya. Ibu hamil harus mengonsumsi makanan lebih banyak karena harus memenuhi kebutuhan zat gizi untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janin/ bayinya. Bila makanan ibu sehari-hari tidak cukup mengandung zat gizi yang dibutuhkan, maka janin atau bayi akan mengambil persediaan yang ada didalam tubuh ibu sebagai sumber zat besi janin/ bayi (Savitrie, 2022). Janin bergantung pada asupan makanan ibu serta cadangan gizi tubuhnya, jika asupan makanan harian ibu tidak memenuhi kebutuhan gizi seperti sel lemak sebagai sumber energi atau cadangan zat besi dalam tubuh ibu sebagai pasokan bagi janin atau bayi, maka janin atau bayi akan menggunakan cadangan gizi yang ada dalam tubuh ibu. Oleh karena itu, konsumsi makanan beranekaragam dengan jumlah dan proporsi seimbang menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan kalori, protein, zat besi, vitamin serta mineral lainnya (Rudatin et al., 2024). Jika gizi selama kehamilan tidak terpenuhi maka akan menyebabkan kekurangan gizi seperti anemia atau berat badan ibu kurang hingga dampak terburuknya adalah terjadi pertumbuhan janin yang tidak sempurna, berat badan bayi lahir rendah (BBLR) serta terjadi kecacatan janin (Pratiwi et al., 2021).

Terkait pemenuhan nutrisi selama hamil, hal penting yang harus diperhatikan ibu hamil adalah makanan yang dikonsumsi terdiri dari susunan menu yang seimbang, oleh karena itu diperlukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang nutrisi kehamilan. Kegiatan edukasi yang dilakukan di Klinik Kartika Husada Donomulyo Malang berhasil meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang nutrisi kehamilan, sebelum diberikan edukasi terdapat 30% ibu hamil yang memiliki pengetahuan baik kemudian setelah diberikan edukasi terdapat peningkatan pengetahuan menjadi 80% ibu hamil dengan pengetahuan baik (Retnaningtyas, Retnoningsih, et al., 2022). Mengedukasi dan mendukung ibu selama kehamilan dalam membuat pilihan makanan sehat untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan janin akan

membantu awal pola hidup yang sehat. Mengonsumsi makanan yang bervariasi dan seimbang dari periode prakonsepsi sangat penting untuk memastikan kesejahteraan ibu dan hasil kehamilan yang baik, beberapa nutri yang dibutuhkan ibu hamil antara lain protein, karbohidrat, asam folat dan vitamin (Pratiwi et al., 2021).

Tabel 8.1 Porsi Makan dan Minum Ibu Hamil untuk Kebutuhan Sehari

Bahan Makanan	Kebutuhan Ibu Hamil Trimester 1	Kebutuhan Ibu Hamil Trimester 2 dan 3	Keterangan
Nasi atau makanan pokok seperti jagung, kentang, singkong, roti dan mie	5 porsi	6 porsi	1 porsi = 100 gram atau $\frac{3}{4}$ gelas nasi 125 gram atau 3 buah jagung ukuran sedang 210 gram atau 2 kentang ukuran sedang 120 gram atau 1 $\frac{1}{2}$ potong singkong 70 gram atau 3 iris roti putih 200 gram atau 2 gelas mie basah
Protein hewani seperti : ikan, telur, ayam, dll	4 porsi	4 porsi	1 porsi = 50 gram atau 1 potong sedang ikan 55 gram atau 1 butir telur
Protein nabati seperti : tempe, tahu, dll	4 porsi	4 porsi	1 porsi = 50 gram atau 1 potong sedang tempe 100 gram atau 2 potong sedang tahu
Sayur-sayuran	4 porsi	4 porsi	1 porsi = 100 gram atau 1 mangkok sayur matang tanpa kuah
Buah-buahan	4 porsi	4 porsi	1 porsi = 100 gram atau 1 potong sedang pisang 100-190 gram atau 1 potong besar pepaya
Minyak/ lemak	5 porsi minyak/ lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan, makanan	5 porsi minyak/ lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan, makanan digoreng,	1 porsi = 5 gram atau 1 sendok teh, bersumber dari pengolahan makanan seperti menggoreng, menumis, santan, kemiri, mentega

	digoreng, ditumis atau dimasak dengan santan	ditumis atau dimasak dengan santan	dan sumber lemak lainnya
Gula	2 porsi	2 porsi	1 porsi = 10 gram atau 1 sendok makan bersumber dari kue-kue manis, minum teh manis, dll.
Garam	Batasi konsumsi garam (hingga 1 sendok teh/ hari)		
Air putih	Minum air putih 8-12 gelas per hari		

Sumber : (Kemenkes, 2023)

Selain porsi makanan dan minuman yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil perlu juga diperhatikan tentang kecukupan gizi ibu hamil yang diperoleh dari rata-rata kecukupan gizi pada trimester 1, 2 dan 3. Berikut keterangan tentang kecukupan gizi sehari ibu hamil disajikan pada tabel berikut :

Tabel 8.2 Kecukupan Gizi Ibu Hamil

Zat Gizi	Kecukupan Gizi Ibu Hamil
Energi (kkal)	2460
Protein (gram)	77
Lemak (gram)	62
Karbohidrat (gram)	385
Serat (gram)	35
Kalsium (mg)	2650
Zat besi (mg)	44
Vitamin A	900
Vitamin C (mg)	85
Folat (mcg)	600
Vitamin B12 (mcg)	4,5

Sumber : (Rudatin et al., 2024)

4. Anemia dalam Kehamilan

Anemia adalah suatu kondisi tubuh dimana kadar hemoglobin (Hb) dalam sel darah merah lebih rendah dari standar yang seharusnya. Ibu hamil dikatakan anemia apabila kandungan Hb <11 gr/dl (Kemenkes RI, 2020). Ibu hamil rentan menderita anemia karena pola makan yang kurang beragam dan bergizi seimbang, kurangnya asupan makanan yang kaya sumber zat besi (seperti hati, ikan, telur, daging, sayuran dan buah berwarna), kehamilan yang berkurang dalam waktu singkat, ibu hamil mengalami kurang energi kronis (KEK) dan terjadi infeksi yang menyebabkan kehilangan zat besi seperti kecacingan dan malaria, serta adanya peningkatan volume darah selama kehamilan untuk pembentukan placenta, janin dan cadangan zat besi dalam ASI (Kemenkes RI, 2020). Kadar hemoglobin (Hb) pada ibu hamil akan menurun pada trimester 1 dan terendah pada trimester 2, selanjutnya meningkat lagi pada trimester 3 (Permenkes, 2021).

Tanda-tanda anemia pada ibu hamil antara lain : lesu, letih, lelah, lemah dan lunglai; kelopak mata pucat; lidah dan bibir pucat; mata berkunang-kunang dan pusing (Kemenkes RI, 2020).

Menurut Kemenkes RI (2020) anemia pada ibu hamil dapat mengakibatkan:

1. Menurunnya fungsi kekebalan tubuh
2. Meningkatkan risiko terjadinya infeksi
3. Menurunkan kualitas hidup sehingga akan berdampak pada : keguguran/ abortus, pendarahan yang dapat mengakibatkan kematian ibu, bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan rendah (BB <2500gram) dan pendek (PB <48 cm), bila ibu dalam kondisi anemia berat dapat menyebabkan bayi berisiko lahir mati.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2023) disampaikan bahwa ada hubungan yang bermakna antara usia kehamilan ibu dengan kejadian anemia, semakin meningkatnya usia kehamilan akan berisiko menimbulkan anemia apabila tidak diimbangi dengan pola makan yang seimbang dan konsumsi TTD secara teratur (Wahyuningsih et al., 2023).

5. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada Ibu Hamil

Upaya pencegahan anemia gizi besi pada ibu hamil dilakukan dengan memberikan 1 tablet setiap hari selama kehamilan minimal 90 tablet, dimulai sedini mungkin dan dilanjutkan sampai masa nifas (Permenkes, 2021). Pemberian TTD bagi ibu hamil diperlukan untuk memenuhi asupan zat besi guna mempersiapkan proses kehamilan dan persalinan yang sehat. Agar konsumsi TTD dapat lebih efektif untuk mencegah anemia maka (Kemenkes RI, 2020) :

1. TTD sebaiknya diminum pada malam hari sebelum tidur untuk mengurangi mual
2. TTD dikonsumsi bersama dengan makanan atau minuman yang mengandung vitamin C seperti buah segar, sayuran dan jus buah agar penyerapan zat besi di dalam tubuh lebih baik
3. Jangan minum TTD bersama teh, kopi, susu, obat sakit maag dan tablet calk karena akan menghambat penyerapan zat besi.
4. Bila perut terasa perih, mual serta feses berwarna kehitaman maka ibu hamil tidak perlu khawatir karena tubuh akan menyesuaikan, maka untuk meminimalkan efek samping tersebut jangan minum TTD dalam kondisi perut kosong

Ibu hamil dapat memperoleh tablet tambah darah dari bidan atau tenaga gizi di pelayanan kesehatan terdekat, TTD yang dikonsumsi oleh ibu hamil memiliki kandungan zat besi sekurang-kurangnya 60 mg besi elemental dan 400 mcg asam folat. Selain itu ibu hamil harus mencatat di kartu kontrol minum TTD

atau dalam buku KIA atau mencatat secara manual untuk kemudian dilaporkan ke bidan atau tenaga gizi (Kemenkes RI, 2020). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi TTD yaitu pengetahuan, sikap, dukungan keluarga, dukungan tenaga kesehatan, frekuensi kunjungan ANC dan usia ibu hamil, sedangkan untuk kepatuhan minum TTD dapat diukur dari ketepatan jumlah TTD yang diminum, ketepatan cara meminum TTD dan frekuensi minum TTD per hari (Arisanti et al., 2022).

Pengetahuan memiliki dampak penting dalam memutuskan kepatuhan konsumsi TTD, semakin tinggi pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya konsumsi TTD maka mereka akan semakin patuh dalam mengonsumsi TTD tersebut sesuai anjuran karena mereka mengetahui bahwa hal tersebut akan dapat mencegah terjadinya anemia (Watiah et al., 2024). Selain pengetahuan, dukungan keluarga menjadi salah satu faktor perilaku ibu hamil dalam mengonsumsi TTD, jika ibu hamil mendapatkan dukungan keluarga ibu akan merasa ada yang mengingatkan untuk mengonsumsi TTD tersebut mengingat TTD harus dikonsumsi setiap hari dan dalam jangka waktu yang lama (Watiah et al., 2024). Kemudian frekuensi kunjungan ANC juga mempengaruhi kepatuhan konsumsi TTD, ibu hamil yang rutin melakukan ANC terpadu maka dipastikan mendapatkan TTD lebih dari 90 tablet selama kehamilan dan mendapat pemantauan dari bidan atau tenaga kesehatan lainnya untuk konsumsi TTD nya (Watiah et al., 2024).

Pemberian TTD secara rutin terbukti efektif dapat meningkatkan kadar Hb ibu hamil terutama di trimester III dan ibu hamil yang mengalami anemia, efeknya akan terlihat dalam 4-8 minggu dengan rata-rata peningkatan Hb 1-3 g/dL. Keberhasilan peningkatan kadar Hb dipengaruhi oleh kepatuhan konsumsi, pola makan kaya zat besi serta dukungan nutrisi seperti vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi, konsumsi sesuai rekomendasi (≥ 90 tablet selama kehamilan) memberikan hasil optimal, sementara efek samping seperti konstipasi dan mual dapat diminimalkan dengan dosis dan cara konsumsi yang tepat (Rafeifadattis et al., 2024).

Melihat pentingnya konsumsi TTD pada ibu hamil maka perlu dilakukan pelaksanaan dan penguatan upaya peningkatan kesadaran ibu hamil mengenai pentingnya konsumsi TTD pada masa kehamilan yaitu melalui penyuluhan atau edukasi yang tepat mengenai konsumsi TTD kepada ibu hamil saat melakukan kunjungan ANC (Arisanti et al., 2022).

6. Perawatan Sehari-hari Ibu Hamil

Pemberian edukasi kepada ibu hamil perlu dilakukan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan selama

kehamilan, salah satunya adalah perawatan sehari-hari antara lain (Kemenkes, 2023) :

- a. Menjaga kebersihan diri seperti : cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air bersih mengalir, mandi dan gosok gigi 2 kali sehari, mencuci rambut/ keramas 2 hari sekali, menjaga kebersihan payudara dan daerah kemaluan serta periksa gigi rutin
- b. Istirahat yang cukup yaitu tidur malam sedikitnya 6-7 jam dan siang hari usahakan tidur atau berbaring 1-2 jam
- c. Bersama suami melakukan stimulasi janin dengan cara sering berbicara dengan janin dan sering melakukan sentuhan pada perut ibu
- d. Melakukan hubungan suami istri selama kehamilan dalam kondisi sehat

Edukasi tentang perawatan sehari-hari selama kehamilan yang meliputi nutrisi, istirahat pada ibu hamil, kebersihan diri pada ibu hamil dan hubungan seksual selama kehamilan ini dapat dilakukan melalui online yaitu dengan virtual class berupa grup whatsApps dengan menggunakan berbagai metode seperti ceramah, tanya jawab, *voice note*, *video learning* dan *brainstroming*. Meskipun dilaksanakan secara online didapatkan hasil bahwa terjadi peningkatan rerata pengetahuan pada ibu hamil yang mengikuti edukasi tersebut dan terdapat peningkatan frekuensi kunjungan ANC ke tempat pelayanan kesehatan (Wahyuni et al., 2022).

D. Kesimpulan

Angka Kematian Ibu (AKI), secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991-2020 yaitu dari 390 menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan untuk jumlah kematian ibu di tahun 2023 yaitu sebesar 4.482 jiwa, meningkat dari tahun 2022 yaitu sebesar 3.572 jiwa. Salah satu lingkup kesehatan reproduksi yang penting dilakukan pemantauan adalah kesehatan ibu selama kehamilan (Permenkes, 2021). Berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 disampaikan bahwa proporsi faktor risiko kehamilan pada perempuan umur 10-54 tahun di Indonesia yaitu sebanyak 15,6% mempunyai faktor risiko, 58,1% tidak mempunyai faktor risiko dan sisanya sebanyak 26,3% tidak ada catatan.

Upaya percepatan penurunan AKI perlu dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti salah satunya adalah pelayanan kesehatan (pemantauan) ibu hamil. Pemantauan selama kehamilan memiliki tujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil agar memperoleh pelayanan antenatal yang komprehensif dan berkualitas sehingga ibu hamil dapat menjalani kehamilan dan persalinan dengan pengalaman yang bersifat positif serta melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Pemantauan selama kehamilan melalui

perawatan antenatal (ANC) yang berkualitas dapat digunakan untuk melakukan skrining dan identifikasi dini komplikasi terkait kehamilan. Pemantauan selama kehamilan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui pemeriksaan kehamilan. Ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan 3. Pemantauan selama kehamilan melalui pelayanan ANC harus memenuhi standar pelayanan antenatal yang meliputi 10T.

Edukasi kesehatan ibu hamil sangat penting dilakukan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Berbagai kegiatan edukasi dilakukan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada ibu hamil tentang pentingnya menjaga kesehatan selama masa kehamilan. Kegiatan edukasi ibu hamil yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan antara lain Kelas Ibu Hamil, nutrisi selama kehamilan, tanda bahaya kehamilan, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan perawatan sehari-hari ibu hamil

E. Referensi

- Abejirinde, I. O. O., Douwes, R., Bardaji, A., Abugnaba-Abanga, R., Zweekhorst, M., van Roosmalen, J., & De Brouwere, V. (2018). Pregnant women's experiences with an integrated diagnostic and decision support device for antenatal care in Ghana. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 18(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12884-018-1853-7>
- Arisanti, A. Z., Catur, R., Wulandari, L., Desi, Y. A., Studi, P., Kebidanan, S., Pendidikan, D., & Bidan, P. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Ibu Hamil dalam Mengonsumsi Tablet Fe: Literature Review Factors Affecting the Compliance of Pregnant Mothers in Consuming Fe Tablets: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 9(2), 131–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/oksitosin.v9i2.1676>
- Budiarti, V., Putri, R., & Amelia, C. R. (2018). *Hubungan Karakteristik Ibu dan Dukungan Suami dengan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Tanda Bahaya Kehamilan*. *Journal of Issues in Midwifery*.
- Febrianti, Angelina F, C., Yanti, D. E., & Sari, N. (2023). Relationship Between Participation in Maternity Classes and Knowledge About Pregnancy and Childbirth. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(11), 10492–10498. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i11.4270>
- Jinga, N., Mongwenyana, C., Moolla, A., Malete, G., & Onoya, D. (2019). Reasons for late presentation for antenatal care, healthcare providers' perspective. *BMC Health Services Research*, 19(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12913-019-4855-x>
- Kemenkes. (2023). Buku Kesehatan Ibu dan Anak. In *Kementrian kesehatan RI*.

- Kemenkes RI. (2020). Pedoman Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Bagi Ibu Hamil. In *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. https://promkes.kemkes.go.id/pub/files/files99516TTD_BUMIL_OK2.pdf
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Survey Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023. In *Kementerian Kesehatan RI*. Kementerian Kesehatan RI. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/hasil-ski-2023/>
- Kementrian Kesehatan RI. (2024). *Profil Kesehatan Indonesia 2023*. Kementerian Kesehatan RI. <https://kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2023>
- Patriaajati, S., & Sriatmi, A. (2019). Determinants of Mothers' Participation in Antenatal Classes. *Indonesian Journal of Health Administration*, 7(2), 139–146. <https://doi.org/10.20473/jaki.v7i2.2019.139-146>
- Permenkes. (2021). *Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2021*. Menteri Kesehatan RI. <https://peraturan.go.id/files/bn853-2021.pdf>
- Pratiwi, R. D., Aulia, G., Oktora, A. S., Prasetyo, A., Savira, A., & Nurmila, S. (2021). Education on the Importance of Nutrition for Pregnant Women. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 2(1), 101–105. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52031/jam.v2i1.132>
- Rafeifadattis, K. F., Setyawan, N. A. F., Amalia, R., Windasari, Y., Lawrence, Y. N., & Simarmata, M. A. S. (2024). Efektivitas Tablet Fe dalam Meningkatkan Hemoglobin Ibu Hamil Trimester III. *Jurnal Inovasi Global*, 3(12), 543–551. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jig.v2i12.235>
- Retnaningtyas, E., Retnoningsih, Kartikawati, E., Nuning, Sukemi, Nilawati, D., Nurfajri, & Denik. (2022). Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil Melalui Edukasi Mengenai Kebutuhan Nutrisi Ibu Hamil. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 19–24. <https://doi.org/doi.org/10.34306/adimas.v2i2.552>
- Retnaningtyas, E., Siwi, R. P. Y., Wulandari, A., Qoriah, H., Rizka, D., Qori, R., Sabdo, M., & Malo, S. (2022). Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil Melalui Edukasi Mengenai Tanda Bahaya Kehamilan Lanjut. . *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 25–30. <https://doi.org/10.34306/adimas.v2i2.553>
- Rudatin, Ekayanti, I., Rachman, P. H., Jahari, A. B., & Iwaningsih, S. (2024). Pedoman Standar Gizi dan Makanan Program Makan Bergizi Gratis. In *Dirjen Kesehatan Masyarakat RI*.
- Sasnitiari, N. N., & Puspitasari. (2017). Hubungan Keikutsertaan Ibu dalam Kelas Ibu Hamil dengan Pengetahuan dan Sikap terhadap Tanda Bahaya dalam Kehamilan di Kota Bogor. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 8(2), 175–185. <https://doi.org/DOI: 10.22435/kespro.v8i2.6424.175 185>.
- Savitrie, E. (2022). *Gizi Seimbang Ibu Hamil*. Kementerian Kesehatan RI.

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/405/gizi-seimbang-ibu-hamil

Triguno, Y., Wardana, K. E. L., & Ayu Wulandari, K. (2021). Health Education On The Danger Signs Of Pregnancy In Primigravida And Multigravida. *Journal of Applied Nursing and Health*, 3(2), 71–76. <https://doi.org/10.55018/janh.v3i2.8>

Wahyuni, S., Nuryati, S., Nurfurqoni, F. A., Astuti, M., & Djamiloes, F. (2022). Edukasi Perawatan Kehamilan. *Edukasi Perawatan Kehamilan*, 6(2), 637. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i2.8185>

Wahyuningsih, E., Hartati, L., & Puspita, W. D. (2023). Analisis Resiko Kejadian Anemia pada Ibu Hamil. *Professional Health Journal*, 4(2), 303–313. <https://doi.org/10.54832/phj.v4i2.388>

Watiah, Soraya, D., & Qomariyah. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Tablet Tambah Darah Pada Ibu Hamil di Puskesmas Buaran. *Protein: Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan.*, 2(2), 307–324. <https://doi.org/10.61132/protein.v2i2.314>

F. Glosarium

A

ANC : *Antenatal Care*
AKI : Angka Kematian Ibu
ASI : Air Susu Ibu

B

BB : Berat Badan
BTA : Basil Tahan Asam

C

cm : centimeter

D

DJJ : Denyut Jantung Janin

H

Hb : Hemoglobin
HIV : *Human Immunodeficeincy Virus*

K

KEK : Kekurangan Energi Kronik
KIA : Kesehatan Ibu dan Anak
kkal : Kilo kalori

L

LiLA : Lingkar Lengan Atas

M

mcg : mikrogram

mg : miligram

mmHg : milimeter air raksa

P

PB : Panjang Badan

S

SDG's : *Sustainable Developments Goals*

SKI : Survey Kesehatan Indonesia

T

TB : Tuberculosis

Td : Tetanus difteri

TTD : Tablet Tambah Darah

U

USG : Ultrasonografi

CHAPTER 9

KESEHATAN MENTAL PADA WANITA: MENANGANI STRESS DAN DEPRESI DI BERBAGAI TAHAP KEHIDUPAN

Cynthia Puspariny, S.ST., Bdn., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan mental merupakan aspek krusial dalam kehidupan setiap individu, termasuk wanita yang menghadapi berbagai tantangan emosional di sepanjang tahapan hidup mereka. Mulai dari masa pubertas, kehamilan, hingga menopause, wanita sering kali mengalami perubahan hormonal dan tekanan sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Menurut data WHO tahun 2021, sekitar 3,8% populasi global, atau sekitar 280 juta orang, mengalami depresi, dengan prevalensi yang lebih tinggi pada wanita. (WHO, 2021) Stres dan depresi menjadi dua isu utama yang kerap muncul, menuntut perhatian khusus dalam penanganannya.

Di Indonesia, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 melaporkan bahwa 9,8% penduduk mengalami gangguan mental emosional, meningkat dari 6% pada 2013. Kenaikan ini menunjukkan urgensi penanganan kesehatan mental, terutama pada wanita yang menghadapi berbagai tekanan sosial dan biologis. Perubahan hormonal yang signifikan pada wanita, seperti saat menstruasi, kehamilan, dan menopause, dapat mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan risiko depresi. (Kementrian Kesehatan RI, 2018) Fluktuasi hormon estrogen dan progesteron dapat memengaruhi bagian sistem saraf yang berhubungan dengan suasana hati, sehingga wanita lebih rentan mengalami depresi dibandingkan pria.

Selain faktor biologis, aspek psikologis dan sosial juga memainkan peran penting. Wanita sering kali diharapkan untuk memenuhi peran ganda, seperti menjadi ibu rumah tangga sekaligus pekerja, yang dapat menimbulkan tekanan dan stres berlebih dan depresi. Tekanan ini diperparah oleh stigma sosial yang menghambat mereka mencari bantuan profesional. Studi menunjukkan bahwa wanita dengan pendidikan rendah memiliki risiko 1,442 kali lebih tinggi mengalami gangguan mental dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Tuntutan sosial dan budaya yang mengharuskan wanita bersikap lembut, mampu mengasuh, dan peka terhadap orang lain dapat membuat mereka lebih rentan terhadap stres dan depresi. (Khoiriyah, R., & Handayani, 2020)

Pada masa kehamilan dan pascapersalinan, risiko depresi semakin meningkat. Perubahan fisik dan emosional yang terjadi selama periode ini dapat memicu kondisi seperti baby blues atau bahkan depresi pascapersalinan. Halodoc menyebutkan bahwa kurangnya dukungan keluarga dan persiapan mental yang tidak memadai dapat memperparah kondisi ini. Masa menopause, wanita kembali menghadapi perubahan hormonal yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Hello Sehat mengungkapkan bahwa risiko depresi pada wanita meningkat selama masa perimenopause, yaitu periode sebelum menopause terjadi. Untuk menangani stres dan depresi pada wanita di berbagai tahap kehidupan, pendekatan holistik diperlukan. Dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting dalam membantu wanita menghadapi tantangan emosional. Selain itu, konsultasi dengan profesional kesehatan mental dapat memberikan strategi coping yang efektif. Kementerian Kesehatan RI menyarankan untuk melakukan hal-hal yang disukai, terlibat dalam kegiatan sosial, dan mencoba hal-hal baru guna meningkatkan rasa percaya diri dan kesejahteraan mental.

Penting bagi wanita untuk menyadari bahwa mencari bantuan profesional bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah proaktif dalam menjaga kesehatan mental. Terapi psikologis dan, jika diperlukan, intervensi medis dapat membantu mengatasi depresi dan stres yang dialami. Alodokter menekankan bahwa depresi yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang serius, bahkan mengancam nyawa penderitanya. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental dan mengambil langkah-langkah preventif serta kuratif yang tepat, wanita dapat menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan sehat secara emosional di setiap tahap kehidupannya.

B. Konsep Kesehatan Mental

Kesehatan mental adalah kondisi di mana individu mampu menyesuaikan diri dengan baik, mengelola fungsi kejiwaan secara harmonis, dan mencapai kesejahteraan psikologis. Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan mental didefinisikan sebagai keadaan sejahtera di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. (Vitoasmara et al., 2024)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kesehatan jiwa atau kesehatan mental merupakan suatu kondisi dimana seorang individu mampu untuk berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga seorang individu tersebut dapat menyadari kemampuan dalam dirinya, dapat mengatasi masalah, dapat bekerja dan dapat memberikan peran serta

kepada masyarakat sekitar. Kesehatan mental mencakup kesejahteraan subjektif, efikasi diri (self-efficacy), otonomi, kompetensi, ketergantungan antargenerasi, dan aktualisasi potensi intelektual serta emosional seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan gangguan mental, tetapi juga dengan kemampuan individu untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.

Kesehatan mental mencakup berbagai aspek yang memengaruhi kesejahteraan psikologis individu. Macam-macam kesehatan mental antara lain:

1. Kesehatan Mental Positif

Kesehatan mental positif melibatkan lebih dari sekadar tidak adanya gangguan mental. Ini mencakup kemampuan individu untuk mencapai potensi maksimal dan merasa puas dalam hidup. (Yuliandari, 2019) Ciri-cirinya antara lain:

- a. Memiliki tujuan hidup yang jelas dan terarah.
- b. Merasa bahagia dan puas dengan kehidupan.
- c. Berkontribusi aktif kepada masyarakat atau lingkungan.

Contoh: Orang yang aktif dalam kegiatan sosial, merasa terpenuhi, dan memiliki pandangan hidup optimis.

2. Mental Health Problems (Masalah Kesehatan Mental)

Mental health problems adalah kondisi di mana seseorang mengalami tekanan emosional, psikologis, atau sosial yang memengaruhi kesehariannya, tetapi tidak cukup untuk disebut gangguan mental. (Mind, 2017) Ciri-cirinya antara lain:

- a. Perasaan cemas, marah, atau sedih yang berlebihan namun sementara.
- b. Gangguan tidur atau makan yang ringan.
- c. Penurunan performa kerja atau studi karena stres.

Penyebab:

- a. Perubahan besar dalam hidup, seperti kehilangan orang tercinta atau tekanan pekerjaan.
- b. Ketidakseimbangan antara tuntutan hidup dan kemampuan individu.

Contoh: Burnout akibat beban kerja berlebih atau stres menjelang ujian.

3. Gangguan Kesehatan Mental (Mental Disorders)

Gangguan kesehatan mental mengacu pada kondisi yang lebih serius, di mana pola pikir, emosi, atau perilaku seseorang terganggu secara signifikan, memengaruhi kualitas hidupnya. (APA, 2022) Beberapa jenis gangguan mental:

- a. Depresi: Gangguan suasana hati yang ditandai oleh rasa sedih mendalam dan kehilangan minat pada aktivitas.
- b. Gangguan Kecemasan: Perasaan cemas berlebihan yang dapat mencakup fobia, serangan panik, dan kecemasan umum.

- c. Gangguan Bipolar: Perubahan suasana hati ekstrem antara mania dan depresi.
- d. Skizofrenia: Gangguan serius yang memengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak, sering disertai halusinasi atau delusi.
- e. Obsessive-Compulsive Disorder (OCD): Pikiran obsesif dan perilaku kompulsif yang mengganggu kehidupan sehari-hari.

Penyebab:

- a. Faktor genetik, trauma masa kecil, atau stres kronis.
- b. Ketidakseimbangan neurotransmitter di otak.

Contoh: Seseorang dengan depresi berat yang sulit melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan profesional.

C. Faktor Risiko Stres dan Depresi pada Wanita

Stres dan depresi merupakan masalah kesehatan mental yang sering dialami oleh wanita. Berbagai faktor risiko berkontribusi terhadap kerentanan ini, yang dapat dikategorikan menjadi faktor biologis, psikologis, dan sosial. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut:

1. Faktor Biologis

- a. Perubahan Hormon: Wanita mengalami fluktuasi hormon signifikan selama siklus menstruasi, kehamilan, pascapersalinan, dan menopause. Perubahan kadar estrogen dan progesteron dapat mempengaruhi neurotransmitter di otak yang mengatur suasana hati, meningkatkan risiko depresi.
- b. Pubertas Dini: Anak perempuan yang mengalami pubertas lebih awal cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi, kemungkinan karena ketidaksiapan psikologis menghadapi perubahan fisik dan emosional.

2. Faktor Psikologis

- a. Trauma Masa Lalu: Pengalaman traumatis, seperti pelecehan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, dapat meninggalkan dampak psikologis jangka panjang yang meningkatkan kerentanan terhadap depresi.
- b. Kepribadian: Wanita dengan kepribadian yang cenderung perfeksionis atau memiliki harga diri rendah lebih rentan mengalami stres dan depresi, terutama ketika menghadapi tekanan atau kegagalan.

3. Faktor Sosial

- a. Peran Ganda: Tuntutan untuk menyeimbangkan peran sebagai ibu, istri, dan pekerja dapat menyebabkan stres kronis. Tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial dalam berbagai peran ini dapat meningkatkan risiko depresi.
- b. Dukungan Sosial yang Kurang: Kurangnya dukungan dari keluarga atau teman dalam menghadapi masalah hidup dapat memperburuk stres dan memicu

depresi. Isolasi sosial atau hubungan interpersonal yang buruk juga menjadi faktor risiko signifikan.

4. Faktor Genetik

Riwayat Keluarga: Adanya anggota keluarga dengan riwayat depresi atau gangguan mental lainnya dapat meningkatkan risiko seorang wanita mengalami kondisi serupa, menunjukkan adanya komponen genetik dalam kerentanan terhadap depresi.

5. Faktor Lingkungan

Stres Lingkungan: Paparan terhadap lingkungan yang penuh tekanan, seperti kemiskinan, diskriminasi, atau lingkungan kerja yang tidak kondusif, dapat meningkatkan risiko stres dan depresi pada wanita.

Memahami faktor-faktor risiko ini penting untuk pengembangan strategi pencegahan dan intervensi yang efektif dalam menangani stres dan depresi pada wanita.

D. Tahap Kehidupan dan Dinamika Kesehatan Mental Wanita

Tahap Kehidupan dan Dinamika Kesehatan Mental Wanita, yang mencakup bagaimana setiap fase kehidupan wanita membawa tantangan dan dinamika tersendiri terhadap kesehatan mentalnya,

1. Masa Kanak-Kanak dan Remaja

Pada masa ini, kesehatan mental wanita mulai dipengaruhi oleh pengalaman awal, lingkungan keluarga, dan perkembangan biologis.

a. Tantangan Utama:

- 1) Pengalaman Traumatis: Kekerasan fisik, emosional, atau seksual dapat meninggalkan dampak jangka panjang pada kesehatan mental
- 2) Pubertas: Perubahan hormon selama pubertas sering dikaitkan dengan perubahan suasana hati, kecemasan, atau risiko depresi.

b. Dinamika Psikologis: Munculnya kebutuhan untuk diterima oleh teman sebaya dan konflik identitas dan pencarian jati diri.

c. Data Global: Menurut (UNICEF, WHO, 2021) depresi mulai meningkat pada anak perempuan menjelang akhir masa remaja, sering dipicu oleh tekanan akademik atau sosial.

2. Masa Dewasa Muda (18-35 Tahun)

Tahap ini ditandai dengan transisi menuju tanggung jawab dewasa, termasuk karier, hubungan, dan mungkin pernikahan atau keibuan.

a. Tantangan Utama:

- 1) Stres Akademik dan Karier: Banyak wanita menghadapi tekanan untuk mencapai kesuksesan dalam pendidikan atau pekerjaan dan

- 2) keseimbangan Peran: Wanita sering kali harus menyeimbangkan peran sebagai istri, ibu, dan profesional.

b. Dinamika Psikologis:

- 1) Kesehatan mental dapat terganggu oleh tekanan untuk memenuhi harapan sosial dan Baby Blues dan
- 2) Depresi Pascapersalinan: Menurut (Association., 2020) sekitar 1 dari 7 wanita mengalami depresi pascapersalinan.

3. Masa Dewasa Tengah (35-50 Tahun)

Pada masa ini, banyak wanita menghadapi perubahan fisik dan sosial yang signifikan, seperti menopause dan perubahan dalam dinamika keluarga.

a. Tantangan Utama:

- 1) Menopause: Perubahan hormonal sering dikaitkan dengan gangguan suasana hati, seperti kecemasan atau depresi
- 2) Tekanan Ganda: Wanita mungkin merawat anak-anak yang masih remaja sekaligus orang tua yang menua (sandwich generation).

b. Dinamika Psikologis:

- 1) Risiko meningkat untuk gangguan kesehatan mental akibat kelelahan fisik dan emosional
- 2) perasaan kehilangan makna hidup ketika anak-anak mulai mandiri.

4. Masa Lanjut Usia (>50 Tahun)

Tahap ini sering ditandai dengan refleksi hidup, kehilangan pasangan atau teman sebaya, dan penyesuaian terhadap peran baru.

a. Tantangan Utama:

- 1) Isolasi Sosial: Kehilangan orang tercinta atau pensiun dapat meningkatkan risiko kesepian dan depresi dan
- 2) Gangguan Kognitif: Risiko gangguan seperti demensia atau Alzheimer meningkat pada usia lanjut.

b. Dinamika Psikologis:

- 1) Wanita lanjut usia dengan dukungan sosial yang baik cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih stabil.
- 2) Pengalaman hidup dapat menjadi sumber kebijaksanaan, tetapi juga rasa penyesalan jika ada trauma yang belum terselesaikan.

E. Dampak Stres dan Depresi pada wanita

Stres dan depresi adalah dua masalah kesehatan mental yang sangat memengaruhi wanita, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Mengingat peran dan tantangan yang dihadapi wanita dalam kehidupan sehari-hari, dampak dari

stres dan depresi ini sangat signifikan. (Suara, M., & Yudiawati, 22 C.E.) Berikut adalah dampak stres dan depresi pada wanita:

1. Dampak Fisik

Stres dan depresi yang berlangsung lama dapat memiliki efek negatif pada tubuh wanita.

- a. Gangguan Tidur: Salah satu dampak fisik yang paling umum dari stres dan depresi adalah gangguan tidur, yang mencakup insomnia atau tidur berlebihan. Kurang tidur dapat memengaruhi kesehatan fisik secara keseluruhan, meningkatkan risiko hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung (AHA, 2020)
- b. Masalah Pencernaan: Stres kronis sering dikaitkan dengan gangguan pencernaan seperti sindrom iritasi usus besar (IBS) dan gangguan lambung, yang dapat memperburuk kualitas hidup.
- c. Kelelahan: Depresi menyebabkan rasa lelah yang ekstrem meskipun sudah tidur cukup, mengurangi energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kelelahan ini seringkali meningkatkan perasaan tertekan dan memperburuk stres.

2. Dampak Psikologis

Dampak psikologis dari stres dan depresi pada wanita dapat berupa perubahan dalam pikiran dan perasaan.

- a. Perasaan Tidak Berharga dan Cemas: Wanita yang mengalami depresi sering merasa tidak berharga, cemas, atau tidak mampu mengelola situasi hidupnya. Rasa putus asa dapat muncul, yang pada akhirnya berisiko memperburuk kualitas hidup mereka.
- b. Gangguan Kecemasan: Stres yang kronis dapat memicu gangguan kecemasan, termasuk gangguan kecemasan umum (GAD), fobia sosial, atau serangan panik, yang sangat mengganggu fungsi sehari-hari (NIHM, 2020)
- c. Penurunan Fungsi Kognitif: Wanita dengan depresi dan stres sering mengalami penurunan fungsi kognitif, seperti kesulitan berkonsentrasi, pengambilan keputusan, dan ingatan. Hal ini dapat mempengaruhi pekerjaan, studi, dan hubungan interpersonal.

3. Dampak Sosial

Stres dan depresi tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga hubungan sosial dan kesejahteraan sosial wanita.

- a. Kesulitan dalam Hubungan Pribadi: Wanita yang mengalami stres dan depresi mungkin menarik diri dari keluarga, teman, atau pasangan mereka. Isolasi sosial ini sering memperburuk kondisi emosional dan memperburuk rasa kesepian.

- b. Penurunan Kinerja di Tempat Kerja atau Studi: Stres dan depresi dapat menyebabkan penurunan produktivitas di tempat kerja atau studi, seperti kehilangan motivasi, keterlambatan, atau ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas.
- c. Penyalahgunaan Substansi: Beberapa wanita yang mengalami stres dan depresi mungkin mencoba untuk mengatasi rasa sakit emosional mereka dengan cara yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang.

4. Dampak Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi wanita juga dapat terpengaruh oleh stres dan depresi, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

- a. Menstruasi Tidak Teratur: Stres dapat menyebabkan gangguan siklus menstruasi, dengan menstruasi yang terlambat, lebih ringan, atau lebih berat dari biasanya.
- b. Gangguan Kesuburan: Stres yang tinggi dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dan mengganggu ovulasi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesuburan wanita.
- c. Depresi Pascapersalinan: Setelah melahirkan, banyak wanita mengalami perubahan hormon yang signifikan. Jika tidak diatasi dengan baik, hal ini dapat berkembang menjadi depresi pascapersalinan yang berdampak pada kemampuan mereka untuk merawat diri sendiri dan bayi mereka (APA, 2022)

5. Dampak Jangka Panjang

Jika stres dan depresi tidak ditangani dengan tepat, dampak jangka panjangnya bisa sangat merugikan.

- a. Risiko Penyakit Jantung: Stres kronis berhubungan dengan peningkatan tekanan darah dan kadar kolesterol, yang berisiko menyebabkan penyakit jantung pada wanita (Association., 2020)
- b. Penyakit Autoimun: Wanita yang mengalami stres kronis lebih rentan terhadap gangguan autoimun, seperti lupus dan rheumatoid arthritis, yang lebih sering ditemukan pada wanita daripada pria.
- c. Risiko Depresi Berulang: Depresi yang tidak ditangani dengan benar dapat menyebabkan episode depresi berulang di masa depan, meningkatkan kerentanannya terhadap masalah kesehatan mental.

F. Strategi Penanganan Stres dan Depresi pada Wanita

Stres dan depresi pada wanita memerlukan pendekatan penanganan yang holistik, yang mencakup aspek psikologis, fisik, sosial, dan spiritual. Berdasarkan berbagai penelitian terbaru, strategi penanganan dapat dikelompokkan menjadi

pendekatan mandiri, psikoterapi, pengobatan medis, dan intervensi berbasis komunitas.

1. Strategi Mandiri untuk Mengelola Stres dan Depresi

Pendekatan mandiri membantu wanita mengelola stres dan depresi melalui perubahan gaya hidup dan kebiasaan sehat.

- a. Olahraga Teratur: Aktivitas fisik, seperti yoga, berjalan kaki, atau berenang, membantu meningkatkan kadar endorfin yang memperbaiki suasana hati (Craft, L. L., & Perna, 2021)
- b. Teknik Relaksasi: Latihan pernapasan dalam, meditasi, dan mindfulness terbukti efektif mengurangi kecemasan dan depresi.
- c. Pola Makan Seimbang: Nutrisi yang baik, termasuk konsumsi asam lemak omega-3, vitamin D, dan serat, dapat memengaruhi neurotransmitter otak yang terkait dengan suasana hati.
- d. Manajemen Waktu: Membuat jadwal yang realistis dan menetapkan prioritas membantu wanita mengurangi tekanan dari tuntutan peran ganda dalam pekerjaan dan keluarga.

2. Psikoterapi

Psikoterapi merupakan pendekatan ilmiah yang efektif untuk menangani stres dan depresi pada wanita.

- a. Terapi Kognitif-Perilaku: membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang menyebabkan stres dan depresi. Terapi ini efektif untuk mengurangi gejala depresi ringan hingga sedang (Beck, A. T., & Alford, 2020)
- b. Terapi Psikodinamik: Pendekatan ini membantu wanita memahami konflik emosional yang mendasari stres, seperti trauma masa kecil atau hubungan yang bermasalah.
- c. Terapi Kelompok: Terapi ini memberikan dukungan sosial dan membantu wanita berbagi pengalaman, sehingga mereka merasa tidak sendirian.

3. Pengobatan Medis

Pada kasus stres berat atau depresi klinis, pengobatan medis mungkin diperlukan untuk memperbaiki keseimbangan kimiawi otak.

- a. Antidepresan: Obat seperti selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) sering diresepkan untuk mengobati depresi (APA, 2022)
- b. Hormon Terapi: Untuk wanita menopause, terapi penggantian hormon dapat membantu mengurangi gejala mood yang disebabkan oleh perubahan hormon (Schmidt, P. J., 2018)
- c. Konsultasi Dokter: Penting untuk berkonsultasi dengan profesional medis sebelum memulai pengobatan apa pun untuk menghindari efek samping atau interaksi obat.

4. Dukungan Sosial dan Intervensi Komunitas

Komunitas dan dukungan sosial memiliki peran penting dalam mengatasi stres dan depresi.

- a. Kelompok Dukungan: Wanita yang bergabung dalam kelompok dukungan merasa lebih dimengerti dan didukung. Kelompok ini sering mencakup wanita dengan pengalaman serupa, seperti depresi pascapersalinan.
- b. Keluarga dan Teman: Lingkungan yang mendukung dapat membantu wanita merasa dicintai dan dihargai, yang berdampak positif pada kesejahteraan mental mereka.
- c. Program Berbasis Komunitas: Beberapa organisasi menawarkan program pelatihan keterampilan hidup, seperti pelatihan kerja atau manajemen emosi, untuk membantu wanita merasa lebih mandiri dan percaya diri (Craft, L. L., & Perna, 2021)

5. Pendekatan Spiritual dan Keagamaan

Bagi banyak wanita, spiritualitas atau agama menjadi sumber kekuatan dalam mengatasi stres dan depresi.

- a. Ibadah dan Doa: Aktivitas keagamaan, seperti doa dan meditasi spiritual, memberikan rasa tenang dan harapan.
- b. Komunitas Keagamaan: Berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dapat memperkuat rasa memiliki dan dukungan sosial.
- c. Perspektif Positif: Ajaran agama sering membantu wanita mengembangkan pandangan hidup yang lebih positif dan menerima situasi sulit dengan ikhlas (Yusuf, 2014)

6. Peran Teknologi dalam Penanganan

Teknologi semakin banyak digunakan dalam penanganan stres dan depresi pada wanita, terutama melalui aplikasi kesehatan mental.

- a. Aplikasi Meditasi: Aplikasi seperti Headspace dan Calm membantu wanita berlatih mindfulness secara rutin.
- b. Konsultasi Online: Terapi online melalui video call memberikan akses yang lebih luas kepada wanita untuk mendapatkan dukungan psikologis.
- c. Forum Online: Komunitas daring memungkinkan wanita berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari orang-orang yang menghadapi masalah serupa.

7. Kebijakan dan Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan layanan kesehatan mental bagi wanita.

- a. Pusat Layanan Psikologis: Meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental yang terjangkau di fasilitas kesehatan umum.

- b. Pendidikan dan Kampanye: Kampanye kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental membantu mengurangi stigma terhadap wanita yang mencari bantuan.
- c. Cuti Melahirkan: Kebijakan cuti melahirkan yang mendukung memberikan kesempatan bagi wanita untuk memulihkan diri dari stres dan depresi pascapersalinan.

G. Simpulan

Stres dan depresi merupakan dua masalah kesehatan mental yang signifikan pada wanita, dengan dampak luas pada fisik, psikologis, sosial, dan kehidupan sehari-hari. Berbagai faktor, seperti tekanan sosial, peran ganda, perubahan hormonal, dan pengalaman hidup tertentu, dapat meningkatkan kerentanan wanita terhadap stres dan depresi. Oleh karena itu, penanganan masalah ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional.

Strategi penanganan meliputi pendekatan mandiri, seperti olahraga teratur, pola makan sehat, dan teknik relaksasi; intervensi psikologis, seperti terapi kognitif-perilaku dan terapi kelompok; serta pengobatan medis untuk kondisi yang lebih berat. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas juga memiliki peran krusial dalam mempercepat pemulihan. Selain itu, pendekatan berbasis spiritualitas dan keagamaan sering membantu wanita menemukan ketenangan dan makna hidup di tengah tantangan.

Teknologi modern, seperti aplikasi meditasi dan terapi daring, memberikan akses lebih luas kepada wanita untuk mendapatkan bantuan kapan saja. Pemerintah dan organisasi kesehatan pun berperan dalam mengatasi tantangan ini melalui penyediaan layanan kesehatan mental yang terjangkau, kampanye kesadaran, dan kebijakan yang mendukung, seperti cuti melahirkan dan layanan kesehatan reproduksi.

Dengan kombinasi dukungan sosial, kebijakan yang inklusif, dan pendekatan yang berpusat pada kebutuhan individu, wanita dapat mengelola stres dan depresi dengan lebih efektif, meningkatkan kesejahteraan, dan menjalani hidup yang lebih sehat dan bermakna. Penanganan yang tepat tidak hanya memperbaiki kualitas hidup wanita, tetapi juga memberikan dampak positif bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

H. Referensi

- AHA. (2020). *Highlights of the 2020 American Heart Association guidelines for CPR and ECC*. https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelinesfiles/highlights/hghlghts_2020_ecc_guidelines_english.pdf

- APA. (2022). *APA Dictionary of Psychology*. American Psychological Association. <https://dictionary.apa.org/mental-health>
- Association., A. P. (2020). *Postpartum Depression*. <https://www.apa.org>.
- Beck, A. T., & Alford, B. A. (2020). *Depression: Causes and Treatment*. University of Pennsylvania Press.
- Craft, L. L., & Perna, F. M. (2021). "The Benefits of Exercise for the Clinically Depressed." Primary Care Companion to the. *Journal of Clinical Psychiatry*, 6(3), 104-111.
- Kementrian Kesehatan RI. (2018). *Riset Kesehatan Dasar*.
- Khoiriyah, R., & Handayani, S. (2020). Kesehatan Mental Emosional Perempuan Penderita Kanker di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Maritim*, 3(2), 164–171. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jkmmunhas/article/view/9845/5391>
- Mind. (2017). Mental health problems - an introduction. *Www.Mind.Org.Uk*, 1–25. <https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/mental-health-problems-introduction/#.XCUs8mT7R1M>
- NIHM. (2020). Older adults and depression. In NIMH (p. 8). *NIHM*, 8. <https://doi.org/10.4135/9781483365817.n886%0A>
- Schmidt, P. J., et al. (2018). "The Role of Estrogen Therapy in the Treatment of Mood Disorders in Women." *Psychoneuroendocrinology*, 8(9), 1–11.
- Suara, M., & Yudiawati, R. (22 C.E.). Evaluasi Intervensi Keperawatan Psikoedukasi dalam Penurunan Stress Psikologis Usia Lanjut selama Wabah COVID-19 di Bogor. *Malahayati Nursing Journal*, 4(12), 3468–3480.
- UNICEF, WHO, W. B. G. (2021). *Joint Child Malnutrition Estimates*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240025257>
- Vitoasmara, K., Vio Hidayah, F., Yuna Aprillia, R., & Dyah Dewi, L. A. (2024). Gangguan Mental (Mental Disorders). *Student Research Journal*, 2, 57–68. <https://doi.org/10.55606/srjyapi.v2i3.1219>
- WHO. (2021). *Depression*. <https://publication.k-pin.org/index.php/jpu/article/download/469/223/4617>
- Yuliandari, E. (2019). "Kesehatan Mental Anak dan Remaja," *Journal of Chemical Information and Modeling*. 53(9), hal. 1689–1699.
- Yusuf, S. (2014). *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama*. Remaja Rosdakarya.

I. Glosarium

OCD : *Obsessive-Compulsive Disorder*

WHO : *World Health Organization*

PROFIL PENULIS



Yenda Hasnita, S.Tr.Keb., M.Keb., Lahir di Solok, 20 Maret 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV pada Program Studi Bidan Pendidik, STIKes Ranah Minang tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas dan lulus tahun pada tahun 2019. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan S3 di Lincoln University College. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2020 menjadi tenaga pendidik kebidanan sampai sekarang sebagai dosen tetap di Program Studi DIII Kebidanan. Saat ini penulis bekerja di Universitas Perintis Indonesia

mengampu berbagai mata kuliah seperti Pengantar Asuhan Kebidanan, Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL, Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita, Pengantar Mom and Baby Spa, Mom and Baby Spa dan Dokumentasi Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, dan kegiatan ilmiah Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yenda.hasnita@upertis.ac.id

Motto: "Menginspirasi, membimbing, dan memotivasi untuk perubahan positif."



Cintika Yorinda Sebtalezy, SST., M.Kes., lahir di Madiun, pada 9 Desember 1989. Ia telah menyelesaikan pendidikannya di Kota Surakarta. Alumni D-III Kebidanan tahun 2011, D-IV Kebidanan tahun 2012, dan S2 Magister Kedokteran Keluarga Minat Utama Pendidikan Profesi Kesehatan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2014. Ia pernah bekerja di Akademi Kebidanan Dulang Mas tahun 2013 dan sekarang bekerja di

STIKes Bhakti Husada Mulia Madiun Tahun 2016-sekarang,. Saat ini penulis aktif dalam beberapa kegiatan penulisan buku ajar kebidanan dan kegiatan sosial PPA-SC Madiun. Ia dapat dihubungi melalui email cintikayorindas@gmail.com.

Motto: "Hidup sekali di dunia, bermanfaat selamanya"

PROFIL PENULIS



Machria Rachman, S.ST., M.Kes., Lahir di Banyuwangi, 12 Januari. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi D-IV Kebidanan, STIKES Insan Unggul Surabaya tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 (Magister Promosi Kesehatan, Kesehatan Reproduksi dan HIV AIDS) pada Universitas Diponegoro Semarang dan lulus tahun pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2007 sebagai dosen DIII Kebidanan dan sekarang bertugas pada Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Saat ini penulis bekerja di STIKES Banyuwangi mengampu mata kuliah Asuhan Kesehatan Reproduksi Perimenopause, Promosi Kesehatan, Asuhan Remaja dan Pranikah, Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Asuhan Kasus Kompleks, serta Asuhan Kehamilan.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, penulis buku, publikasi penelitian dan pengabdian masyarakat, seminar, dan pelatihan terkait kebidanan dan kesehatan reproduksi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: machria@stikesbanyuwangi.ac.id

Motto: "Hidup adalah seni, jadilah seniman yang menciptakan karya terbaikmu"



Januar Dwi Christy SST., Bd., M.Kes., Lahir di kabupaten Sidoarjo Prov. Jawa Timur, pada 2 Januari 1988, Menyelesaikan Magister Pada Tahun 2017 di Univ. Diponegoro Semarang, dan pernah bekerja di UPT. Di Kabupaten dan Menjadi Dosen Tetap sekaligus Kasie LPPM di AKBID Mandiri Gresik mulai 2010 – 2017 dan mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang menjadi Dosen Tetap sekaligus Wakil Ketua III di STIKES Griya Husada Surabaya. Saat ini penulis bekerja di STIKES Griya Husada Surabaya Penulis

aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pelatihan baik di bidang kebidanan dan Kesehatan. Aktif melakukan penulisan buku yang telah di HKI dan ISBN, adapun buku berjudul Buku Pegangan Kader Posyandu dan Asuhan Kebidanan Keluarga berencana, Buku ajar psikologi kebidanan, Buku Latihan soal-soal OSCE Kebidanan, Buku Prediksi soal UKOM DIII Kebidanan, Buku Standar prosedur operasional Ketrampilan Dasar Praktek Kebidanan, Buku KMK Pengembangan diri dan Profesionalisme.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: christy.akgh@gmail.com

Motto: "Pengetahuan Adalah landasan kehidupan dan mimpi itu gratis maka kejarlah mimpimu hingga terwujud"

PROFIL PENULIS



Selvy Apriani. SST., M.Biomed., lahir di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 18 Maret 1992. Penulis menyelesaikan gelar Strata Satu (S-1) tahun 2014 di peminatan Entomologi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Diponegoro (UNDIP) di Semarang dan melanjutkan studi jenjang Magister of Science (M.Sc.) di program studi Ilmu Kedokteran Tropis Konsentrasi Entomologi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKMKM) Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. Setelah menamatkan studi Magister pada tahun 2019, penulis mengawali karirnya sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang pada Program Studi Kesehatan Masyarakat. Saat ini, penulis merupakan dosen ASN di program studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Mulawarman, Samarinda. Bidang kepakaran penulis adalah Entomologi Kesehatan. Semoga *book chapter* ini dapat meningkatkan pengetahuan pembaca terkait penyakit infeksi mengenai malaria. Pembaca dapat berkorespondensi dengan penulis di alamat email fitrianggraini@fk.unmul.ac.id
Motto: "Hiduplah untuk selalu menjadi bermakna"



Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes. Lahir di Ulu-Siau, 27 April 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu lulus pendidikan Diploma Tiga Kebidanan di Akademi Kebidanan Sari Mulia tahun 2009, lulus pendidikan Diploma IV Bidan Pendidik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia tahun 2011, dan lulus pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Respati Indonesia di Jakarta tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali dengan bekerja sebagai Tenaga Kependidikan di AKBID Sari Mulia tahun 2009 dan sebagai Dosen di Universitas Sari Mulia sejak 2012 – sekarang. Penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan di Komunitas, Asuhan Kebidanan pada Kesehatan Reproduksi Wanita, Promosi Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Biologi Reproduksi, Anatomi Fisiologi, dan Metodologi Penelitian. Selain pengajaran, penulis juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi lainnya yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan bidang fokus pada Kesehatan Reproduksi Perempuan. Penulis aktif menghasilkan luaran-luaran hasil Tridarma Perguruan Tinggi berupa Buku Ajar Kebidanan Komunitas, Buku Panduan Uji Kompetensi Bidan sub-bagian Kesehatan Reproduksi, serta publikasi artikel ilmiah hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di jurnal maupun prosiding. Penulis dapat dihubungi melalui email: elvineivana@gmail.com

PROFIL PENULIS



Dr. Devi Arista, SST., Bdn., M.Kes lahir di Jambi, 05 Oktober 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma IV Kebidanan di Universitas Respati Yogyakarta tahun 2012. Kemudian melanjutkan Magister Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Reproduksi di Universitas Respati Indonesia tahun 2013. Pada tahun 2021 penulis menyelesaikan Profesi Bidan di Universitas Prima Indonesia dan tahun 2024 lalu penulis telah menyelesaikan program doktoral pada Prodi Doktor Ilmu Kedokteran di Universitas Prima Indonesia. Saat ini penulis bekerja di Universitas Adiwangsa Jambi mengampu mata kuliah Kesehatan Reproduksi Remaja dan Kesehatan Reproduksi Lansia. Selain itu penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: deviarista@unaja.ac.id.



Hardiningsih, SST., M.Kes Lahir di Surakarta, 7 Januari 1987. Penulis menempuh pendidikan DIV Kebidanan di Fakultas Kedokteran UNS lulus tahun 2009 dan melanjutkan studi S2 Magister Kedokteran Keluarga di UNS lulus tahun 2012. Penulis menjadi dosen tetap di Program Studi D3 Kebidanan Sekolah Vokasi UNS sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. Penulis mengajar mata kuliah terkait kebidanan seperti Mata Kuliah Asuhan Kehamilan, Mata Kuliah Gizi dan Kesehatan reproduksi serta Mata Kuliah Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga. Selain mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional terkait kesehatan wanita antara lain Pengembangan Model Community Health Project untuk Meningkatkan Kesehatan Maternal dan Pengaruh Peer Counseling terhadap Pengetahuan dan Motivasi Ibu Hamil dalam Pencegahan Stunting serta terkait kesehatan reproduksi remaja seperti anemia pada remaja, pencegahan stunting sejak usia remaja dan gizi pada remaja. Selain itu penulis telah menulis beberapa buku ajar untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hardiningsih@staff.uns.ac.id

PROFIL PENULIS



Cynthia Puspariny, S.ST., Bdn., M.Kes., Lahir di Tanjung Karang, 25 September 1985. Pendidikan kebidanan dan Kesehatan Masyarakat ditempuh di STIKes Estu Utomo Boyolali, Poltekkes Kemenkes Surakarta dan Universitas Malahayati Lampung. Penulis pernah bekerja di salah satu klinik di Surakarta, lalu bekerja di akademik kebidanan di Lampung Utara dan saat ini penulis mengabdikan menjadi seorang dosen Prodi S1 Kebidanan di Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Penulis menguasai beberapa mata kuliah yaitu Asuhan Kebidanan Remaja dan Perimenopause, Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan BBL serta, mata kuliah asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi namun penelitian dan pengabdian fokus pada tema yang berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pelayanan Keluarga Berencana (KB).

Sinopsis

Perawatan Kesehatan Wanita dalam Berbagai Tahap Kehidupan adalah sebuah buku yang dirancang untuk memberikan wawasan mendalam tentang cara merawat kesehatan wanita di setiap tahap kehidupannya. Buku ini mengupas berbagai aspek penting yang memengaruhi kesehatan wanita, mulai dari usia remaja hingga lansia, dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada pengetahuan medis terkini.

Buku ini dimulai dengan pembahasan tentang **deteksi dini kanker payudara**, yang sangat penting untuk mendeteksi masalah sejak awal dan meningkatkan peluang kesembuhan. Dilanjutkan dengan topik **perawatan menopause**, memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perubahan fisik dan psikologis yang terjadi serta cara mengelolanya. Topik **kesehatan reproduksi pada wanita remaja** juga tak kalah penting, dengan edukasi seputar menstruasi dan pengelolaan masalah reproduksi yang sering terjadi di usia muda.

Selain itu, buku ini juga membahas **perawatan kesehatan seksual wanita**, **gangguan menstruasi**, dan **perawatan kesehatan wanita hamil**, memberikan panduan untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul. **Kesehatan mental** juga menjadi bagian penting dalam buku ini, dengan fokus pada pengelolaan stres dan depresi yang dapat memengaruhi kualitas hidup wanita di berbagai tahap kehidupannya.

Buku ini tidak hanya berfokus pada masalah kesehatan fisik, tetapi juga membahas **pentingnya olahraga dan nutrisi** di semua usia sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang mendukung kesejahteraan tubuh secara keseluruhan. Terakhir, buku ini menyentuh topik perawatan kesehatan wanita lansia, memberikan perhatian khusus pada pencegahan penyakit degeneratif dan penanganan osteoporosis yang sering terjadi di usia tua.

Dengan pendekatan yang praktis dan mudah dipahami, buku ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi setiap wanita agar dapat menjaga kesehatan dengan lebih baik dan menjalani kehidupan yang sehat, bahagia, dan produktif.

Perawatan Kesehatan Wanita dalam Berbagai Tahap Kehidupan adalah sebuah buku yang dirancang untuk memberikan wawasan mendalam tentang cara merawat kesehatan wanita di setiap tahap kehidupannya. Buku ini mengupas berbagai aspek penting yang memengaruhi kesehatan wanita, mulai dari usia remaja hingga lansia, dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada pengetahuan medis terkini.

Buku ini dimulai dengan pembahasan tentang deteksi dini kanker payudara, yang sangat penting untuk mendeteksi masalah sejak awal dan meningkatkan peluang kesembuhan. Dilanjutkan dengan topik perawatan menopause, memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perubahan fisik dan psikologis yang terjadi serta cara mengelolanya. Topik kesehatan reproduksi pada wanita remaja juga tak kalah penting, dengan edukasi seputar menstruasi dan pengelolaan masalah reproduksi yang sering terjadi di usia muda.

Selain itu, buku ini juga membahas perawatan kesehatan seksual wanita, gangguan menstruasi, dan perawatan kesehatan wanita hamil, memberikan panduan untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Kesehatan mental juga menjadi bagian penting dalam buku ini, dengan fokus pada pengelolaan stres dan depresi yang dapat memengaruhi kualitas hidup wanita di berbagai tahap kehidupannya.

Buku ini tidak hanya berfokus pada masalah kesehatan fisik, tetapi juga membahas pentingnya olahraga dan nutrisi di semua usia sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang mendukung kesejahteraan tubuh secara keseluruhan. Terakhir, buku ini menyentuh topik perawatan kesehatan wanita lansia, memberikan perhatian khusus pada pencegahan penyakit degeneratif dan penanganan osteoporosis yang sering terjadi di usia tua.

Dengan pendekatan yang praktis dan mudah dipahami, buku ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi setiap wanita agar dapat menjaga kesehatan dengan lebih baik dan menjalani kehidupan yang sehat, bahagia, dan produktif.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-78-8



9

786347

139788